



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA**

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE BACHARELADO EM MEDICINA**

CATALÃO - GO
2024

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA

Membros Internos a UFCAT

Prof. Me. Augusto César da Fonseca Neto

Profa. Dra. Cristiane de Oliveira Cardoso

Profa. Dra. Fernanda Vieira Rodovalho Callegari

Prof. Me. Jonatha Cajado Menezes e Silva

Profa. Esp. Gizelda Vasconcelos Vieira de Alcântara

Prof. Esp. Leonardo Vieira Fernandes

Prof. Dr. Thiago Montes Fidale

Profa. Dra. Wânia Rezende Lima

Membros Externos a UFCAT

Profa. Dra. Rosuita Fratari Bonito

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - Apresentação	5
CAPÍTULO 2 - Exposição de motivos	6
CAPÍTULO 3 - Objetivos	14
CAPÍTULO 4 - Princípios norteadores para a Formação Profissional	15
CAPÍTULO 5 - Expectativa para a Formação Profissional	35
CAPÍTULO 6 - Perfil do egresso	37
CAPÍTULO 7- Estrutura Curricular	43
CAPÍTULO 8 - Política e Gestão de Estágio Curricular Obrigatório e não Obrigatório	81
CAPÍTULO 9 - Trabalho de Conclusão de Curso	86
CAPÍTULO 10 - Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão.	86
CAPÍTULO 11 - Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de ensino-aprendizagem e Apoio ao Discente;	88
CAPÍTULO 12 - Gestão do Curso e os Processos de Avaliação interna e externa	97
REFERÊNCIAS	98

LISTA DE FIGURAS

Figura	Página
FIGURA 01- Imagem aérea de Catalão	8
FIGURA 02 - Imagem aérea da UFCAT	10
FIGURA 03 - Mapa regiões de saúde do estado de Goiás	12
FIGURA 04 - Modelo educacional baseado em competências	20
FIGURA 05- Eixos orientadores, habilidades e competências nos ciclos no Curso de Medicina da UFCAT	43

LISTA DE QUADROS

Quadro	Página
QUADRO 01 - Médicos e razão de médicos por 1.000 habitantes, segundo unidades da Federação, em 2022	5
QUADRO 02- Equipe de Saúde da Família Quantidade - Conceitos e práticas tradicionais e sistêmico Maio/2016 Região Saúde da Estrada de Ferro	12
QUADRO 03 - Comparação educação centrada no professor (tradicional) e educação centrada no estudante.	21
QUADRO 04 - Aportes do construtivismo ao processo pedagógico	22
QUADRO 05 - Conceitos e práticas tradicionais e sistêmico	23
QUADRO 06 - Estágios para aquisição das habilidades clínicas de Dreyfus	24
QUADRO 07- Concepções em avaliação na Literatura internacional	26
QUADRO 08 - Elementos a serem considerados na escolha do método avaliativo	27
QUADRO 09 - Melhores evidências em programa de avaliação	28
QUADRO 10. Perfil de competência do egresso do Curso de Medicina da UFCAT, 2023	38
QUADRO 11 - Área de competência educação em Saúde: construção de saberes e práticas em saúde e medicina	41
QUADRO 12 - Eixos orientadores da Matriz Curricular do Curso de Medicina da UFCAT	44
QUADRO 13 - Estrutura curricular segundo ciclo, anos e percursos curriculares, Curso de Medicina, UFCAT, 2023.	45
QUADRO 14 - Carga horária dos percursos organizadores, Curso Medicina da UFCAT, 2023.	47
QUADRO 15 - Carga horária do curso por componente curricular/ percurso e semestre letivo	47
QUADRO 16 - Carga horária por percurso e por período	48
QUADRO 17 - Componentes Curriculares e Metodologias Avaliativas	88
QUADRO 18 - Diferenças entre os vários métodos de feedback ou devolutivas	90
QUADRO 19 - Descrição das competências esperadas nos docentes de cursos médicos	95

CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) segue os preceitos da Constituição Federal Brasileira no que se refere à reorientação da formação profissional na área da saúde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº. 9.394 de 20/12/1996); Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Medicina (Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014); acompanha também, as orientações do Ministério da Educação, especialmente àquelas vinculadas ao Plano de Expansão da Educação em Saúde - Plano Nacional de Expansão do Curso de Medicina, as políticas de saúde do Ministério da Saúde, sobretudo as de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, e a macro política do Governo Federal; Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Catalão; Estatuto da UFCAT e demais legislações educacionais e regulamentações do Conselho Federal e Regional de Medicina, incluindo o Código de Ética Médica.

1. Nome do Curso: Graduação em Medicina
2. Unidade responsável pelo curso: Unidade Acadêmica de Biotecnologia (IBIOTEC)
3. Área de conhecimento: Ciências da Saúde
4. Título a ser conferido: Médico (ver PLC 179/2015 SENADO aprovado em 22/03/2016)
5. Carga horária Total do Curso: 7584 horas relógio (revisão do CURSO/UFCAT - ainda não validado pelo MEC); carga horária total do curso hora aula: 5606,4 e carga horária total do curso estágios: 2912h horas relógio.
6. Modalidade: Presencial
7. Turno de funcionamento: Integral
8. Número de vagas: 30 vagas anuais (por decisão do CURSO/UFCAT - ainda não validado pelo MEC)
9. Tempo para integralização curricular:
 1. Mínimo: 12 (doze) semestres – 06 (seis) anos
 2. Máximo: 18 (dezoito) semestres – 09 (nove) anos
10. Forma de Ingresso ao Curso: O ingresso na UFCAT poderá se dar em uma das seguintes opções: sistemas unificados de seleção; transferência facultativa; transferência ex officio; portador de diploma de graduação; convênios ou acordos culturais; matrícula cortesia (diplomática).

CAPÍTULO 2 - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os estudos da Demografia Médica do Brasil, realizados desde 2011 pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e depois em parceria com Associação Médica Brasileira (AMB), mantém, em sua sexta edição, em 2023, a luz lançada sobre a desigualdade na distribuição de médicos no país, bem como na proporção médico/habitantes. O Brasil apresenta taxa nacional de 2,60 médicos por 1.000 habitantes (Scheffer, 2023), com uma grande variação entre as regiões e estados. O Quadro 1, a seguir, apresenta a quantidade de médicos por habitantes, considerando os Estados.

Quadro 01 - Médicos e razão de médicos por 1.000 habitantes, segundo unidades da Federação, em 2022

UF	População	%	Médicos	%	Razão
Distrito Federal	3.094.325	1,5	17.100	2,9	5,53
Rio de Janeiro	17.463.349	8,2	65.855	11,3	3,77
São Paulo	46.649.132	21,9	163.430	28	3,50
Santa Catarina	7.338.473	3,4	22.407	3,8	3,05
Rio Grande do Sul	11.466.830	5,4	34.803	6	3,04
Espírito Santo	4.108.508	1,9	12.335	2,1	3,00
Minas Gerais	21.411.923	10	62.266	10,7	2,91
Paraíba	4.059.905	1,9	11.396	2	2,81
Paraná	11.597.484	5,4	32.525	5,6	2,80
Mato Grosso do Sul	2.839.188	1,3	7.589	1,3	2,67
Goiás	7.206.589	3,4	19.019	3,3	2,64
Mato Grosso	3.567.234	1,7	8.116	1,4	2,28
Pernambuco	9.874.793	4,5	21.589	3,7	2,23
Tocantins	1.607.363	0,8	3.489	0,6	2,17
Sergipe	2.338.474	1,1	5.018	0,9	2,15
Rondônia	1.815.278	0,9	3.847	0,7	2,12
Rio Grande do Norte	3.560.903	1,7	7.483	1,3	2,10
Ceará	9.240.580	4,3	17.509	3	1,89
Amapá	877.613	0,4	1.814	0,3	1,84
Alagoas	3.365.351	1,6	6.178	1,1	1,84
Bahia	14.985.284	7	27.362	4,7	1,83
Piauí	3.289.290	1,5	5.965	1,0	1,81
Roraima	652.713	0,3	1.070	0,2	1,64
Acre	906.876	0,4	1.278	0,2	1,41
Amazonas	4.269.995	2	5.796	1,0	1,36
Maranhão	7.153.262	3,4	8.743	1,5	1,22
Pará	8.777.124	4,1	10.359	1,8	1,18

Fonte: Scheffer M. et al., Demografia Médica no Brasil 2023

Considerando a Demografia Médica no Brasil 2023, fica evidenciado a diferença da Razão médico/1.000 habitantes entre interiores e capitais, sendo necessário estimular a fixação do

médico no interior, especialmente nos municípios menos populosos. O curso de Medicina da UFCAT faculta o campo de prática nestes cenários, o que atende à necessidade de formação de médicos para atuar no SUS, buscando suprir essa necessidade social.

Na publicação Cuidados de Saúde Primários (2023), a OMS considera que “Uma força de trabalho dedicada é essencial para prestar cuidados de saúde primários e, no entanto, estima-se que faltem 18 milhões de profissionais de saúde em todo o mundo”.

Nas atuais condições de oferta de atenção à saúde, grande parcela da população sofre e morre vitimada por problemas sanitários para cuja resposta, em sua maioria, já há conhecimento/tecnologia disponível. O curso de Medicina da UFCAT atende a outro aspecto apontado pela OMS, quando o modelo biomédico mostra sinais de insuficiência, exigindo a construção de novos modelos de formação e capacitação de recursos humanos em saúde (OMS, 2018).

Existe, ainda hoje, o reconhecimento que as populações continuam esquecidas e o mesmo sentimento de oportunidades perdidas que impulsionou, há 45 anos, em Alma-Ata, na mudança de paradigma no pensar sobre saúde, quando na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, da OMS, houve uma mobilização para revisão das posições do modelo biomédico em direção ao “movimento de Cuidados de Saúde Primários” de profissionais e instituições, governos e organizações da sociedade civil, investigadores e de pequenas organizações.

Como destacam Aguiar e Ribeiro (2010), na formação médica, é cada vez mais evidente a distância entre a concepção de conhecimento dominante nas escolas e os atuais requerimentos exigidos para os profissionais nas áreas mais importantes da prática. Tradicionalmente, o conhecimento científico transmitido no chamado ciclo básico é descontextualizado, atendendo a uma concepção de acúmulo linear e progressivo do saber, em analogia a construções de edificações civis. Sem desqualificar a pesquisa biomédica, é fundamental o reconhecimento da legitimidade profissional decorrente da expertise da prática, e não apenas por meio da pesquisa científica, segundo as autoras citadas acima.

No curso de Medicina da UFCAT, há a valorização e aplicação na prática médica dos conhecimentos produzidos pela Epidemiologia, Psicologia, Antropologia e pela Comunicação Social (Ciências Sociais e Humanas), assim como, se reconhece os benefícios trazidos à formação, pela manutenção da atividade profissional concomitante à docência.

Busca-se a orientação dos estudantes para os problemas da prática extraídos do mundo real, cada vez mais complexos e indeterminados, sem recortes bem delineados, dando oportunidades do exercício do conhecimento e da tomada de decisão sob condições de incerteza, a lidar com a ambiguidade, seguindo princípios da educação de adultos e dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis para a educação, ofertando condições de aprendizado para manejo das situações de forma rápida e eficiente, estimulando uma confiança intuitiva em conceitos que ganham sentido na prática ofertada.

O Curso de Medicina da UFCAT apresenta o seu compromisso com a formação de médicos qualificados para atender as necessidades da atenção à saúde da população, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), dando condições para que esses profissionais contribuam para assegurar a “integralidade da atenção, a qualidade e humanização do atendimento” (Brasil, 2001), com compromisso político, social e ético, com competências e habilidades para reconhecer a realidade em que se insere, e assim executar ações assertivas, (trans)formadoras e inovadoras no processo de trabalho, tendo como meta a qualidade e resolutividade na atenção à saúde.

Pensar no processo de trabalho em saúde requer reflexões sobre as necessidades postas pelo contexto atual de formar médicos que atuem com qualidade na Atenção Básica, em especial, na Estratégia da Saúde da Família, que surgiu como proposta de reorganização do modelo de atenção à saúde. Frente a essas necessidades, torna-se importante formar médicos com essas competências e

qualificações, para desenvolver ações específicas no atendimento à indivíduos, famílias e comunidades, em todas as fases do ciclo de vida, estabelecendo uma relação de vínculo e confiança.

O Curso de Medicina busca contribuir para melhorar o acesso da população ao sistema de saúde, pois a proposta do Projeto Pedagógico do Curso da UFCAT, tem como cerne o SUS e seus princípios, em sintonia com as políticas relacionadas ao sistema de saúde do país, a atenção integral à saúde direcionada ao processo saúde-adoecimento-cuidado do cidadão, da família e da comunidade, alcançando a promoção da saúde das pessoas, atenção às suas necessidades, prevenção de agravos, tratamento de doenças e reabilitação dos indivíduos, famílias e comunidade, considerando o empoderamento e autonomia coletiva, ajustando uma realidade carente em garantia de atender os direitos do cidadão.

2.1 O município

Figura 1- Imagem aérea de Catalão



Fonte:

<https://portalnoticiasgoias.com.br/prefeitura-de-catalao-prorroga-prazo-de-inscricao-para-concurso-publico-que-disponibiliza-mais-de-600-vagas/>

Segundo informações do sítio da Prefeitura Municipal de Catalão (Prefeitura Municipal de Catalão, SEM DATA), o município de Catalão foi fundado em 1859; está localizado no sudeste Goiano, a 254 km da capital Goiânia e a 320 km da capital federal, Brasília. Abrange uma área de 3.778 km², que corresponde a 1,11% do território goiano (IBGE, 2022). Está inserido em uma região de interligação entre estados, conta com boa estrutura de transportes destacando-se a BR 050, rodovias estaduais e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), antiga Rede Ferroviária Federal utilizada atualmente para o escoamento de produtos minerais, industriais e agrícolas (Brasil, s/d).

Seu posicionamento geográfico, estratégico, na região central do Brasil, torna a cidade um ponto chave nas rotas de ligação entre regiões e cidades de grande importância econômica do Sudeste e Sul, com regiões e cidades ao Norte e Nordeste do país, em especial como ponto de conexão com as capitais de Goiás e do país. (Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás, 2006).

Com população residente de 114.427 pessoas (IBGE, 2022), é a 11ª. Cidade mais populosa do Estado e a de maior população do Sudeste Goiano, com grande influência regional, dinamizando 22 municípios desta região, também chamada de Região da Estrada de Ferro, além de estender sua influência para municípios de regiões Sul Goiano e Entorno do Distrito Federal, e ainda, para outros estados.

Segundo o IBGE, em 2020, Catalão apresentava o quinto maior PIB do Estado de Goiás, abaixo apenas da capital Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde. A economia catalana destaca-se em todos os setores da economia goiana: indústria, setor de serviços e comércio, agropecuária e, um destaque para a maior província mineral do estado de Goiás. Outra característica de destaque da economia catalana é sua menor desigualdade social, dentre os municípios goianos de maior renda.

Com especial cuidado na atenção às necessidades de saúde coletiva, o município oferta parques ecológicos e praças de convivência à sua população nos mais diversos bairros, permitindo a integração com a natureza, a oportunidade de atividades físicas, de desenvolvimento de atividades de lazer e de cultura, democratizando o acesso a esses recursos e trazendo qualidade de vida à população.

A Região Centro-Oeste do País, ocupa uma área de 340.165 km² e possui 246 municípios. Estruturado, inicialmente, com base na atividade mineradora dos séculos XVIII e XIX e na implantação, no século XX, de lavouras em terras de matas, o espaço correspondente ao Estado de Goiás passou, nos últimos decênios, por acentuado processo de mudanças. Com efeito, a estrutura espacial do estado apresentou alterações associadas a decisões governamentais indutoras de grandes transformações, entre as quais se incluem: fundação de Goiânia em 1933 e a transferência da Capital do estado, em 1941, da cidade de Goiás para Goiânia; a fundação de Brasília e a transferência da capital federal para o Planalto Central; a construção de grandes eixos viários (Belém-Brasília, por exemplo); a criação do Estado do Tocantins em 1989; e a formação de programas e projetos de estímulo à expansão da ocupação e à implantação da moderna agricultura e de parques industriais.

A reestruturação espacial ocorrida nas últimas décadas, no Estado de Goiás, está associada a profundas transformações econômicas, às mudanças tecnológicas e à redefinição da ocupação territorial. Assim, responde por novos padrões de relações intersetoriais e por uma nova estruturação das relações sociais e do sistema urbano.

Dessa forma, a dinâmica recente da produção, no seu contexto macro, influencia o Estado, em todos os seus municípios, em especial aqueles, que ao longo da história, tem contribuído para o crescimento do Estado e consequentemente do País, como é o caso da cidade de Catalão, localizada em pleno “Portal do Cerrado”, região geográfica com mais de dois milhões de quilômetros quadrados, em franco processo de desenvolvimento, crescimento populacional, e ainda carente de médicos.

2.2 A Universidade Federal de Catalão

Figura 2 – Imagem aérea da UFCAT



Fonte: Divulgação/UFCAT

A Universidade Federal de Catalão – UFCAT, foi criada pela Lei 13.634/2018 por desmembramento da Universidade Federal de Goiás - UFG.

Durante a sua trajetória histórica, a UFG implantou novas unidades nas diversas áreas do conhecimento, ampliou a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, e consequentemente reconhecendo a importância e as dificuldades na execução do princípio da indissociabilidade, buscou uma efetiva articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

Esse cenário resultou, nos anos de 1980, na parceria da UFG com o município de Catalão e com a abertura de cursos de graduação na cidade. A assinatura do primeiro termo de convênio entre a UFG e a Prefeitura Municipal de Catalão, prevendo a instalação da Universidade no município ocorreu em 20 de dezembro de 1982 nas gestões do Prefeito Divano Elias e da Reitora Maria do Rosário Cassimiro. Esta, então, chamada Unidade Acadêmica de Catalão da UFG, tornou-se o Campus Avançado de Catalão – CAC, em 7 de dezembro de 1983, com projeto de estabelecer uma efetiva participação no processo de desenvolvimento cultural e socioeconômico local, regional e nacional, mas ainda, oferecer bases físicas, administrativas e técnicas para a realização de programas de Extensão Universitária, alcançando a região sudeste do estado de Goiás. Os primeiros convênios de implantação de cursos celebrados entre a UFG e Prefeitura Municipal de Catalão foram, em 1985, Licenciatura Plena em Letras e Licenciatura Plena em Geografia; em 1987, Cursos de Licenciaturas Plena de Pedagogia e de Matemática e depois; de 1989 a 1996, outros sete cursos de Licenciatura Plena foram implantados e; em 1996, implantou-se o primeiro curso de bacharelado, o Curso de Ciências da Computação (Silva, 2011). Em 2009 contava com vinte e um cursos de graduação, e em 2016 foi criado o Curso de Medicina.; e em 2019 iniciou sua primeira turma. (UFCAT, sem data).

Quanto à estrutura física, o Campus está instalado no município de Catalão, no Setor Universitário, numa área de 89.992,50 m². No ano de 2009, a área construída correspondia a cerca de 20.000 m², distribuídos entre, salas de aula, salas para professores, secretarias, laboratórios, geoprocessamentos, informática, Museu de Geologia, prédios de laboratório, auditório e biblioteca, evidenciando um crescimento muito rápido em infraestrutura física e recursos educacionais em um curto intervalo de tempo. Está em construção o edifício que atenderá os cursos da área de saúde, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2024. A edificação de 2.374 m² abrigará laboratório de técnicas operatórias, laboratório de habilidades médicas, miniauditório com 100 lugares, salas de tutoria, laboratório multidisciplinar, sala de professores, salas de coordenação, secretarias, cantina, fotocopiadora, banheiros e ambulatório (UFCAT, sem data).

A UFCAT conta com uma Biblioteca Setorial, com um acervo aproximado de 70 mil exemplares e com o Restaurante Universitário – RU, com capacidade estimada de 500 pessoas simultâneas, e serviço de fornecimento de 1000 refeições, em média, entre almoço e jantar.

Atualmente, a UFCAT possui vinte e oito cursos de Graduação presenciais, dois cursos de Graduação a distância, onze programas de Mestrado e três programas de Doutorado, além de vários cursos de Especialização. O corpo discente é composto por mais de 3.400 (três mil e quatrocentos) estudantes. O corpo docente conta com 328 professores e o quadro de pessoal com 116 técnicos administrativos em educação, além de 138 funcionários terceirizados e prestadores de serviços. (UFCAT, sem data).

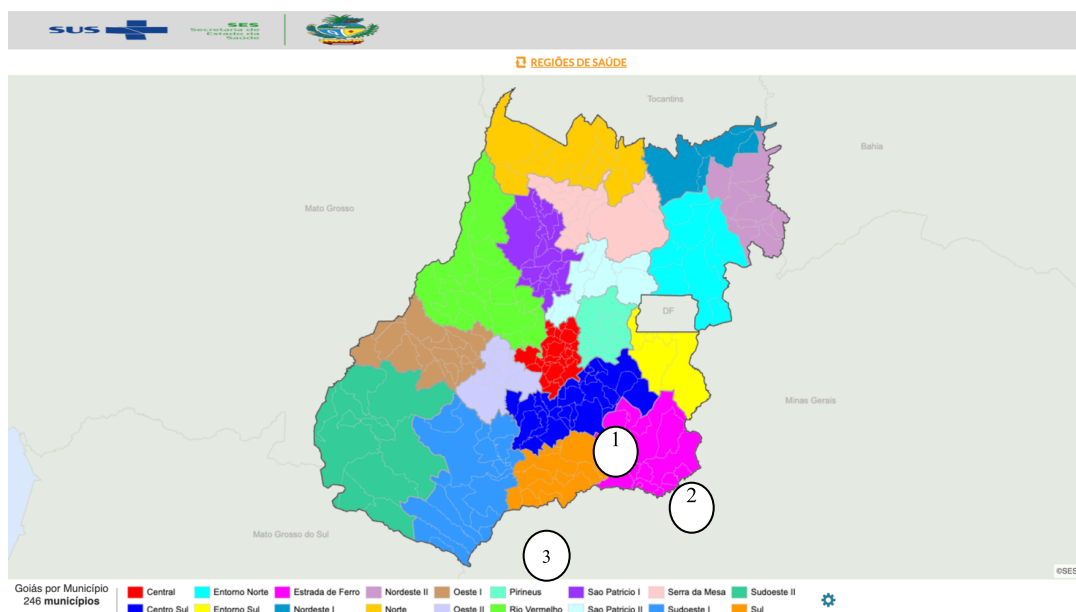
Em 2021, a UFCAT entregou à sua comunidade universitária a Moradia Universitária do Cerrado - MUC, objetivando suporte à permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade, com disponibilidade de apartamentos para habitação, cada apartamento possui dois quartos e tem capacidade para quatro moradores; há disponibilidade de 5 apartamentos adaptados e acessíveis à PCD (Pessoa com Deficiência), com capacidade de 2 moradores cada, além de áreas para prática de esportes, quiosque para socialização, sala de reuniões e outros ambientes complementares para síndico e depósito de materiais de limpeza.

2.3 A Rede de Serviços de Saúde

O Estado de Goiás, sede do curso de Medicina da UFCAT, implantou o seu Plano Diretor de Regionalização – PDR, com última revisão em 2016, quando seu território foi dividido em 18 (dezoito) regiões de saúde, cada uma com uma sede administrativa, denominada Regional de Saúde, cobrindo toda a população estimada pelo IBGE para 2022, em 7.056.495 habitantes, agrupadas em 05 (cinco) Macrorregiões. As Regionais de Saúde representam a Secretaria de Estado da Saúde - SES-GO na região de saúde delimitadas pelo PDR e tem uma equipe formada por um coordenador de regional, possui oito coordenações técnicas responsáveis por assessorar e apoiar os municípios, além de implementar e monitorar as ações da SES-GO em âmbito regional.

Catalão faz parte da Macrorregião Centro Sudeste, que abrange três Regiões de saúde: Centro Sul (1), Estrada de Ferro (2) e Sul (3), com 55 municípios e 1.542.513 habitantes; é o município sede da Regional de Saúde da Estrada de Ferro, com 18 municípios e 325.940 habitantes. (Populações estimadas pelo IBGE 2022).

Figura 3 – Mapa: Regiões de Saúde do estado de Goiás- 2023



Fonte: <https://www.saude.go.gov.br/estrutura/regioes-de-saude>

Toda a rede regionalizada é potencial cenário de práticas dos processos educativos dos estudantes do Curso de Medicina, favorecendo a compreensão da dimensão cotidiana do conjunto do SUS na assistência, na gestão, na formação e no controle social.

Nos municípios que compõem a Regional Estrada de Ferro, existem ofertas de serviços na área de Urgência e Emergência, Pronto Atendimento e Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; e a quantidade de equipes de saúde da família pode ser vista no quadro 2.

Quadro 02 - Equipe de Saúde da Família Quantidade - Maio/2016 Região Saúde da Estrada de Ferro

Município	Quantidade
Anhanguera	1
Caldas Novas	19
Campo Alegre de Goiás	4
Catalão	11
Corumbaíba	3
Cumari	1
Davinópolis	1
Goiandira	2
Ipameri	9
Marzagão	1
Nova Aurora	1
Ouvidor	3
Palmelo	1
Pires do Rio	8
Rio Quente	2

Santa Cruz de Goiás	1
Três Ranchos	2
Urutaí	3
TOTAL	73

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES

A quantidade de equipes é insuficiente, considerando a população desta área, e o fato é que o programado é uma equipe para cada 4 mil habitantes, outro fato que aponta a falta de profissionais médicos.

CAPÍTULO 3 - OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

- Formar profissionais médicos generalistas, humanitários, éticos, com capacidade crítica e reflexiva, capazes de atuar nos processos de saúde-adoecimento-cuidado em diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, promovendo a saúde integral do ser humano e contribuindo de forma efetiva na melhoria das condições sociais da população brasileira a partir do contexto loco-regional.

3.2 - Objetivos específicos

- Desenvolver os raciocínios clínico-epidemiológico, estratégico e científico-reflexivo que fundamentam, respectivamente, as três áreas de competência do perfil profissional: atenção à saúde, gestão em saúde e educação na saúde;
- Promover o desenvolvimento articulado de capacidades nas três áreas de competência, integrando conhecimentos, habilidades e atitudes, com vistas à identificação de necessidades de saúde e produção de intervenções qualificadas e contextualizadas frente aos problemas de adoecimentos prevalentes da população brasileira e aos desafios de promover tolerância à diversidade e sustentabilidade para a vida no planeta;
- Promover o cuidado integral à saúde, considerando promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social de pessoas e populações, tanto por meio da articulação de ações e profissionais de saúde, como pela conexão de serviços em redes de atenção à saúde do Sistema Único de saúde – SUS da região de Catalão;
- Promover a construção de capacidades para o trabalho interprofissional em saúde e a articulação entre diferentes setores, com vistas à produção de um cuidado integral com inovação tecnológica, segurança, qualidade, efetividade, eficácia e eficiência.
- Desenvolver uma prática de excelência, ética, humanizada e baseada nas melhores evidências científicas, contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção à saúde, com ética profissional, responsabilidade social e compromisso com a igualdade dos direitos de cidadania e a equidade em relação às necessidades;
- Orientar a formação e a organização das atividades curriculares pelas necessidades de saúde locais e regionais, construindo e incorporando práticas inovadoras e emergentes na atenção à saúde, gestão em saúde e educação na saúde em parceria com os serviços de saúde da região de Catalão.
- Articular atividades curriculares de simulação com atividades curriculares realizadas em cenários reais do trabalho em saúde no município de Catalão e região, acompanhando estudantes, preceptores e equipes de saúde na produção de ações com excelência técnica e baseadas nas melhores evidências.
- Promover a construção de trajetórias singulares de formação médica que contemplem os interesses dos estudantes na construção de sua identidade profissional de modo articulado aos requerimentos formais e legais da formação, no contexto da educação superior e do exercício profissional na sociedade brasileira.

CAPÍTULO 4 - PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

4.1 Princípios Gerais

A estrutura curricular do Curso de Medicina da UFCAT encontra-se orientada por competências e pelas necessidades de atenção/cuidado da população, fundamentada nos princípios do construtivismo e do humanismo, na utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e da avaliação dialógica, na integração teoria e prática, na formação no contexto do SUS, favorecendo a formação generalista, crítico-reflexiva, ética, pautada na responsabilidade social e compromisso com a cidadania, visando a promoção da saúde integral do ser humano.

4.1.1 Formação orientada às necessidades de saúde

A orientação da formação às necessidades de atenção/cuidado das pessoas constitui um elemento central na luta pela equidade e pela integralidade na atenção à saúde e possibilita, fundamentalmente, uma ampliação no modo de compreender o processo saúde-adoecimento-cuidado e repensar aspectos importantes da organização do processo de trabalho, gestão, planejamento, construção de novos saberes e práticas em saúde. (Cecílio, 2009).

As necessidades de atenção/cuidado são dinâmicas, social e historicamente construídas. Originam-se das relações que os indivíduos estabelecem entre si para se constituírem como sujeitos e das diferentes posições que ocupam nas relações de reprodução social, expressam uma síntese das exigências das condições específicas de cada homem e mulher. Variam de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, sexo, condição de saúde, estilo de vida e contexto socioeconômico. São reconhecidas no conjunto da vida social do indivíduo, na forma de trabalhar; modo de viver; relações do indivíduo com a família, grupo social, instituições e características do território onde vive. Significa reconhecer em indivíduos, famílias e grupos/classes sociais. (Campos, 2005; Cecílio, 2009; Stotz, 1991).

Cecílio (2006) indica que as necessidades de atenção/cuidado podem ser amplamente captadas numa taxonomia organizada em quatro grandes conjuntos: 1. necessidade de boas condições de vida, 2. garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e prolonguem a vida, 3. necessidade de vínculos (a)efetivos e necessidade de autonomia e 4. autocuidado no modo de “andar a vida” (Cecílio, 2006).

O conjunto “boas condições de vida” engloba reconhecer os fatores do ambiente externo que determinam o processo saúde-adoecimento-cuidado, ou seja, os lugares distintos ocupados por homens e mulheres no processo produtivo - inserção na fábrica, no escritório, desemprego; acesso às condições de moradia - acesso a água tratada, condições de moradia, violência; e hábitos pessoais. Indica que a maneira como se vive se “traduz” em diferentes necessidades de saúde (Cecílio, 2006).

O outro conjunto “garantia de se ter acesso e se poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida” inclui o acesso a tecnologias leves, leve-duras e duras. Não há qualquer tentativa de se hierarquizar essas tecnologias. Assume-se que a necessidade a cada tipo de tecnologia em saúde é sempre definida a partir da necessidade de cada pessoa, em cada singular momento que vive (Cecílio, 2006). Como citado por Cecílio 2006 “o diagnóstico precoce de uma

hipertensão arterial, para determinada pessoa, em determinado momento de sua vida, é tão crucial quanto o acesso a um exame de cineangiocoronariografia para outro, que vive outro momento.”.

O terceiro conjunto " criação de vínculos (a)efetivos entre cada usuário e uma equipe e/ou um profissional" reconhece o vínculo para além de uma simples adscrição a um serviço ou inscrição formal a um programa. Representa o vínculo enquanto referência e relação de confiança. Significa o estabelecimento de uma relação contínua no tempo, pessoal e intransferível, calorosa: encontro de subjetividades (Cecílio, 2006).

Um quarto e último conjunto de necessidades diz respeito à necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu modo de levar a vida. Nessa necessidade, ressalta-se que a informação e educação em saúde são apenas parte do processo de construção da autonomia de cada pessoa. A autonomia implicaria a possibilidade de reconstrução, pelos sujeitos, dos sentidos de sua vida, da possibilidade de lutarem pela satisfação de suas necessidades da forma mais ampla possível (Cecílio, 2006).

No encontro usuário - serviço de saúde há sempre uma “cesta de necessidades de saúde” a serem decodificadas e caberia à equipe ter sensibilidade e preparo para esta tarefa, também saber atendê-las da melhor forma possível. Dessa forma, a ênfase da gestão, organização da atenção e capacitação dos trabalhadores deveria ser no sentido de uma maior capacidade de escutar e atender às necessidades de saúde, mais do que a simples adesão a modelos de atenção consagrados, pura e simples, a qualquer modelo de atenção dado aprioristicamente (Cecílio, 2006) .

Dessa forma, do ponto de vista educacional, ao trabalharmos a partir das necessidades de saúde é possível superar a fragmentação entre os ciclos básico e clínico, abordados de modo sequencial e fragmentado nos currículos convencionais. Permite que o estudo articulado das dimensões biológica, psicológica e social se torne natural, uma vez que emergem como inerentes ao fenômeno e requerem respostas intersetoriais, interdepartamentais e interdisciplinares. Possibilita também a construção de planos de cuidado mais resolutivos e com melhores chances de adesão por parte de pacientes, familiares ou responsáveis, e impulsiona respostas mais significativas para enfrentamento, especialmente, das mudanças no perfil de morbimortalidade e da grande prevalência de condições crônicas e relacionadas aos estilos de vida e de trabalho das pessoas (Lima, 2020)

A proposta pedagógica elaborada para o Curso de Medicina, fundamenta-se na abordagem das disciplinas básicas e clínicas, de forma integrada e transversal, durante todo o currículo, por meio do processamento de problemas de saúde-adoecimento-cuidado. Os avanços e as inovações tecnológicas são explorados de modo articulado ao desenvolvimento de capacidades para o trabalho em equipe e para o cuidado humanizado na atenção à saúde das pessoas.

4.1.2 Currículo integrado e orientado por competência

Currículos por competência são projetados com base no perfil do egresso ou ainda em papéis sociais a serem desempenhados pelo profissional em formação ao final do programa educacional. Na sua estruturação, o primeiro passo é definir o perfil de formação desejado, ou seja, os resultados. Uma vez que o perfil de formação tenha sido estabelecido, o próximo passo é identificar os processos necessários para alcançar esses resultados (Santos, 2011; Frenk et al., 2010).

Nesse sentido, no currículo orientado por competência, situações concretas de trabalho e a prática profissional desejada, constituem a referência para seleção de conteúdos e experiências educacionais voltadas ao desenvolvimento de excelência profissional. O enfoque é dado ao que tem que ser aprendido pelo educando e não ao que tem que ser ensinado. As práticas educacionais procuram refletir a vida profissional, considerando as múltiplas dimensões de seu exercício junto à sociedade. Os encontros educacionais são centrados na aplicação do conhecimento, em contraposição à sua simples aquisição, e no desenvolvimento da identidade profissional. O sistema de avaliação enfatiza a avaliação formativa em detrimento da somativa (Santos, 2011; Frenk et al., 2010; Taroco et al, 2017).

Contrapõem-se aos currículos voltados para a aquisição de conhecimentos, que focalizam mais os processos do que os resultados, e que são estruturados em torno da exposição a conteúdos específicos dentro de um determinado período de tempo, desempenhando o professor, um papel central no aprendizado, com os estudantes assumindo posição mais passiva, recebendo informações e conhecimentos por meio de aulas, palestras, materiais didáticos, entre outros. Os resultados desse processo de aprendizagem são avaliados principalmente por meio da avaliação somativa (Aguiar; Ribeiro, 2010; Santos, 2011).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em medicina trazem a noção de competência como um dos vetores para a orientação da mudança no ensino e na avaliação da aprendizagem (Aguiar; Ribeiro, 2010). Sabe-se que a competência profissional não é algo que possa ser observado diretamente, mas pode ser inferida por meio do desempenho do indivíduo e da forma como ele articula suas habilidades e conhecimentos para realizar tarefas específicas. Em outras palavras, a competência é evidenciada pelas ações e realizações do profissional (Freitas et al, 2017).

As DCN 2014 preconizam que competência [...] é compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis; é também a capacidade de ter iniciativas e ações que traduzam desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentem à prática profissional em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica (Brasil, 2014; Freitas et al, 2017).

Dessa forma, a competência na prática clínica levará em consideração o uso adequado do conhecimento, comunicação, habilidades técnicas, raciocínio clínico, valores, emoções, reflexões e as melhores práticas científicas (Frenk et al., 2010; Santos, 2011; Ben, et al., 2017).

Considerando que o termo "competência" pode ter múltiplos significados e interpretações, a definição de currículos orientados por competências requer uma opção conceitual clara em relação ao que se entende por competência (Lima, 2005; Santos, 2011).

Na educação, distinguem-se, três enfoques conceituais prevalentes sobre competência. Um que associa competência a atributos pessoais que um indivíduo possui e que contribuem para o desempenho efetivo em determinada área. A ênfase recai nas características internas do indivíduo que são relevantes para o desempenho competente. Outro enfoque a vincula aos resultados de tarefas realizadas, destaca-se os resultados efetivos alcançados em um contexto real, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos. Um terceiro propõe a noção de competência dialógica, originada na associação das características pessoais para a realização de ações, em contextos específicos, visando atingir determinados resultados. O diálogo

entre as características pessoais, as ações, e o contexto, é central para o desenvolvimento e mobilização da competência (Pereira Júnior; Sá, 2021).

Essa multiplicidade de interpretações deriva-se de dois modelos nucleares em relação às noções de competência, estabelecidos a partir de meados do século XX, que influenciaram os campos da educação e do trabalho. Uma delas, predominantemente focada na adequação da formação profissional às demandas do mercado de trabalho e outra voltada para a transformação dos processos de trabalho e educacional (Lima, 2005; Lima; Ribeiro, 2023).

Os modelos de perfil de competência orientados às demandas do mercado de trabalho estão referenciados nas óticas condutivista (behaviorista) e funcionalista. No modelo condutivista, acredita-se que aqueles que possuem o conhecimento adequado são capazes de realizar as tarefas com eficácia. Assim, o foco é dado predominantemente ao desenvolvimento de capacidades/atributos cognitivos. No modelo funcionalista, a valorização é deslocada para realização de tarefas e os resultados obtidos, tanto dentro como fora das organizações. Isso significa que a competência é avaliada não apenas com base na cognição, mas também na capacidade de alcançar resultados efetivos em um contexto mais amplo, considerando as interações entre diferentes partes do sistema organizacional e as demandas do mercado (Hager; Gonczi, 1996; Lima, 2005; Lima; Ribeiro, 2023).

Já os modelos de perfil de competência voltados para os processos de trabalho e educacional, e são dirigidos pela visão construtivista e crítico-emancipatória, focalizando as formas e os meios pelos quais os sujeitos contribuem, pela apropriação de sua profissão ou ocupação, para reproduzir ou transformar os processos de trabalho (Lima; Ribeiro, 2023).

O modelo construtivista enfatiza que o conhecimento é construído ativamente pelos indivíduos através de suas experiências e interações com o ambiente. O foco está na reflexão sobre a própria prática, na identificação de problemas e na busca de soluções inovadoras. Os profissionais são vistos como agentes ativos na construção do conhecimento e na transformação de suas profissões ou ocupações. A matriz crítico-emancipatória vai além da análise das práticas profissionais e da educação profissional, buscando também articular as necessidades dos trabalhadores e dos processos de trabalho (Lima, 2005; Lima; Ribeiro, 2023; Neves, 2003; Schwartz, 1998). Ambas as abordagens são importantes para a melhoria da educação profissional e incentivam a formação de profissionais mais capacitados e conscientes de seu papel na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de uma educação profissional mais relevante e significativa.

O "modelo holístico ou integrador" que realiza uma releitura dessas modelagens nucleares de competência, e busca integrar e articular os diferentes elementos que constituem a competência, quando conectado à abordagem dialógica de competência, beneficia a gestão e a educação profissional orientadas por competência (Fleury, Fleury, 2001; Lima; Ribeiro, 2022). Tal conexão se caracteriza por: (i) em sua dimensão filosófica - por valorizar diferentes perspectivas, conhecimentos e abordagens, os quais podem ser integrados de forma a enriquecer a compreensão e possibilitar ação efetiva em determinado contexto. Em vez de considerar que apenas uma visão é correta ou verdadeira, a abordagem dialógica busca criar um metaponto de vista, onde diferentes perspectivas são unidas em uma síntese coerente e abrangente; e (ii) em sua dimensão técnico-científica por identificar e articular as lógicas e racionalidades que fundamentam e caracterizam áreas de competência. Isso implica na compreensão das diferentes lógicas e formas de pensar que estão presentes em uma determinada área de conhecimento ou prática profissional. Além

disso, a abordagem procura organizar essas áreas de competência de acordo com as atividades profissionais que as definem e expressam os processos de trabalho e melhores práticas (Lima; Ribeiro, 2022).

Considerando o contexto da atuação na área da saúde, na qual os profissionais serão continuamente demandados por problemas cada vez mais complexos e indeterminados, impostos pelas rápidas mudanças demográficas e epidemiológicas das sociedades (Frenk et al, 2010), essa modelagem se faz, especialmente, relevante. Igualmente, atende a concepção de competência apontada nas DCN 2014 que apresenta, as capacidades ou habilidades como elementos constitutivos da competência, não se limitando à aquisição ou à verificação desarticulada ou compartimentalizada desses elementos (Lima; Ribeiro, 2022).

Sobre a confusão conceitual entre competências e habilidades, segundo Lima e Ribeiro (2022, p.4):

[...] Se, por definição, as competências são operações mentais que articulam e mobilizam os conhecimentos, as habilidades e os valores, as habilidades seriam, então, elementos constitutivos das competências. A identificação das competências, das habilidades e das bases tecnológicas, feita de forma separada, fragmentada, nas matrizes de referência das áreas profissionais, converte-se, portanto, em uma incoerência teórico-metodológica. (apud Deluiz, 2001, p. 5).

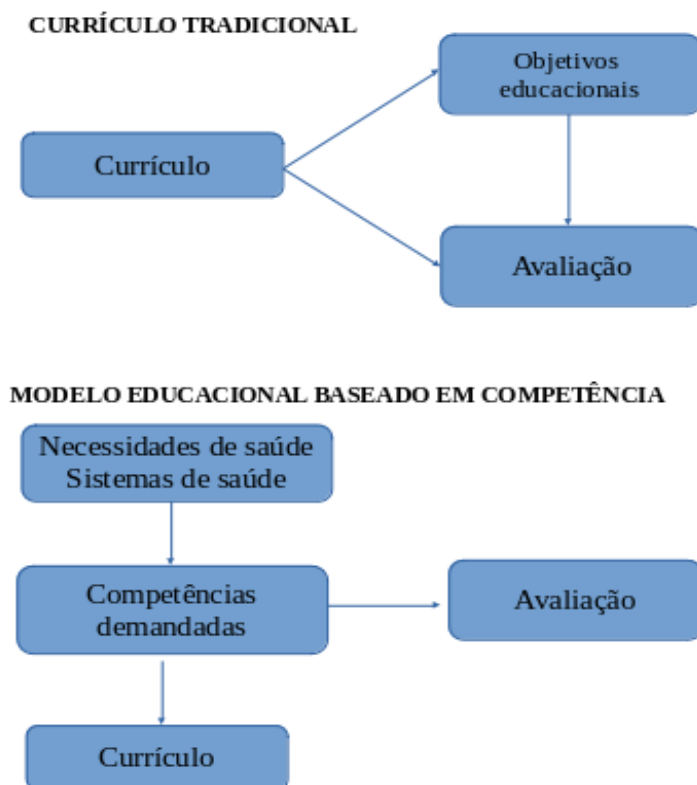
Utilizamos no nosso currículo a abordagem dialógica de competência, articulando, ou melhor, dialogando com diversas perspectivas sobre o que é ser competente; capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras que qualificam as ações profissionais; ações, segundo contexto e critérios de excelência (Lima; Ribeiro, 2022).

O currículo organizado, segundo perfil de competência, oferece experiências educacionais potentes para o desenvolvimento das capacidades de modo articulado, favorecendo que elas possam ser mobilizadas, com sucesso, frente a um determinado contexto que requeira a atuação profissional.

As experiências educacionais (práticas de ensino-aprendizagem) são modeladas para proporcionar a construção de significado, por meio da transferência da aprendizagem baseada nos conteúdos teóricos, para uma aprendizagem baseada na integração teoria-prática. São utilizadas situações simuladas da prática para a exploração de conteúdos relevantes ao desenvolvimento de competência, concomitantemente com a inserção dos estudantes em situações reais de saúde, no contexto do SUS.

A utilização de situações reais ou simuladas da prática profissional garante uma aproximação imediata da aprendizagem ao mundo do trabalho, favorecendo a construção de novos saberes a partir do reconhecimento da prática em questão e do potencial significativo das ações observadas e/ou realizadas, assim como da funcionalidade das capacidades a serem desenvolvidas para melhor qualificar essas ações.

Figura 04 - Modelo educacional baseado em competências



Fonte: Autoria própria, baseado em Frenk et al., 2010.

4.1.3 Utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Curso de Medicina impõem a necessidade do uso de metodologias ativas no curso de medicina (Brasil, 2014), mas não explica o motivo da proposta nem o significado da ruptura com o modelo tradicional.

O ensino médico tradicional, assim chamado aquele que surgiu por influência do relatório Flexner, teve inegável importância na formação técnica dos médicos, garantindo melhora de muitos indicadores de saúde (Abreu, 2009). Ocorre, porém, que, ao promover uma formação centrada no hospital, na especialidade e na doença, criou obstáculos para uma formação que promovia uma visão integral do indivíduo em favor de outra mais reducionista do processo saúde-doença-cuidado e que, por ser centrada no professor, geralmente especialista, que ministrava aulas magistrais para grandes grupos de estudantes, tinha como base a transmissão de conhecimento, passou a não ser vista como adequada para formar o profissional de saúde pelo perfil de egresso esperado para o novo modelo de cuidado que se desenhava (Mattos, 2003).

Um dos pontos vistos como mais falhos na formação foi o da integralidade: um termo polissêmico, que engloba tanto a prática do profissional como a organização dos cuidados como o sentido das políticas. Implica, assim, que o profissional médico consiga ir além do que é explicitado na consulta, apreendendo as necessidades não ditas para bem além do diagnóstico precoce, prevenção e controle das patologias e fazer isto num esforço articulado com outros profissionais e

numa proposta de cuidado que garanta a longitudinalidade do cuidado e, com isto, o vínculo (Mattos, 2003), garantida, porém a excelência técnica que garantisse alta resolutividade tanto a nível individual como a nível coletivo.

Foi proposta então uma mudança do modelo de ensino tradicional, centrado no professor, para um outro, centrado no estudante, também conhecidas como metodologias ativas que promovem a autonomia, a auto regulação, as habilidades de comunicação e de trabalho em grupo (Siqueira-Batista; Siqueira-Batista, 2009).

Uma comparação entre os métodos educacionais centrados no professor e os centrados no estudante podem ser vistos no Quadro 03.

Quadro 03 - Comparação entre educação centrada no professor e educação centrada no estudante.

EDUCAÇÃO CENTRADA NO PROFESSOR (TRADICIONAL)	EDUCAÇÃO CENTRADA NO ESTUDANTE
Avaliação somativa fora de contexto	Avaliação formativa contínua
Estudantes passivos, recebem informações do professor especialista	Estudantes ativos, constroem seus objetivos educacionais sob supervisão do docente facilitador
Uso de exposição oral	Uso de múltiplos recursos educacionais
Não tem espaço para o individual, entrega passiva de informação	Considera as qualidades individuais, promove destreza educacional
Programas estabelecidos, usa oportunidades existentes	Auto aprendizagem, analítica criativa
Acrítica, baseada no uso da memória	Crítica, baseada em problemas, relevante e estimula raciocínio
Sequencial e desintegrada	Integra conceitos
Impessoal, individualista	Favorece trabalho em grupos
Centrada em hospitais e nas patologias que se encontra ali	Baseada em necessidades prioritárias de saúde e atenção primária
Divisão entre matérias básicas e clínicas	Integração das ciências básicas com as clínicas

Autoria própria - baseada em Venturelli, 2003.

O impacto da metodologia ativa na educação, é exatamente o que se espera no perfil do profissional de saúde: crítico, capaz de trabalhar em grupo, com visão holística e integrada do indivíduo e que sabe selecionar os próprios objetivos de aprendizado e buscar as fontes adequadas para atender suas próprias demandas educacionais. Estudos comprovam que a forma como os estudantes absorvem informações durante sua formação tem um impacto direto na capacidade de se manterem atualizados ao longo de suas carreiras. A busca ativa pelo conhecimento é fundamental para aprimorar constantemente as habilidades clínicas e garantir uma prática profissional de excelência. Estar aberto a novas informações, métodos e descobertas na área médica, não apenas amplia o conhecimento, mas também melhora a capacidade de tomar decisões fundamentadas e oferecer o melhor cuidado aos pacientes (Rossi et al, 2021).

Há várias teorias que fundamentam as metodologias ativas, entre elas a teoria da aprendizagem significativa, que aponta que conhecimento para ser assimilado, precisaria se conectar a outro conhecimento existente na estrutura cognitiva do indivíduo (Ausubel et al., 1980). Esta teoria tem como seu oposto a aprendizagem mecânica, literal ou memorística, a qual ocorreria quando não há um elemento de conexão para aquela informação ou o estudante não desejou fazer o esforço de confrontar a informação com a ideia de conexão. Considerando esse contexto, a aprendizagem significativa se daria, só se o conteúdo for potencialmente significativo - seja lógico e

tenha conectores nos estudantes, e que estes tenham uma predisposição para aprender de maneira significativa (Valadares, 2011). A teoria do professor David Ausubel se enquadra no que se chama de construtivismo, uma corrente teórica que defende que a inteligência humana se desenvolve a partir de interações recíprocas com o ambiente (Castañon, 2015).

O construtivismo não é um método de ensino e ele não defende que os indivíduos aprendem sozinhos (Fernandes et al., 2018), mas uma concessão construtivista cria condições para que os esquemas de conhecimento construídos pelos estudantes sejam os mais corretos e ricos possível.

Muitos autores apresentam sua visão dos aportes do construtivismo ao processo pedagógico (Quadro 04).

Quadro 04 - Aportes do construtivismo ao processo pedagógico

IDEIA CONSTRUTIVISTA	COMENTÁRIO
Considerar as ideias do estudante	Considerar o conhecimento prévio do estudante
Tornar o conteúdo significativo para o estudante	Apresentar o conteúdo de modo que seja significativo, funcional e de relevância
Conhecer e respeitar o nível de desenvolvimento do estudante	Buscar entender como os estudantes percebem os problemas e permitir que levantem e testem hipóteses e modelos explicativos para os problemas.
Desencadear o conflito cognitivo e/ou resolução de problemas	As atividades propostas devem indicar problemas a serem resolvidos em grupo.
Valorizar atividades que favoreçam a construção de conhecimentos próprios do estudante e o aprender a aprender	Atividades devem fazer com que os estudantes adquiram habilidades de aprender a aprender
Não apresentar conhecimentos prontos	O papel do professor é proporcionar oportunidades e incentivos para que o estudante o construa
Estruturar o conhecimento em torno de conceitos e grandes ideias	Estruturar a aprendizagem em torno de conceitos primários e os significados criados são generalizados pelos estudantes.
Apresenta a prática e busca a teoria a partir dela	busca a teoria a partir da prática.

Autoria própria, baseado em Galindo Massabni (2007) e Schmidt; Dauphinee, Patel (1987)

4.1.4 Formação no contexto e para o Sistema Único de Saúde (SUS)

O currículo do Curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão adotará as propostas da terceira geração das reformas para formação profissional em saúde que indicam que deve ser um currículo que promova integração com os sistemas de local, no caso com o Sistema Único de Saúde (Frenk et al., 2010).

O SUS, é um sistema de saúde inovador, instituído a partir da lei 8080, assinada em 19/9/1990, fundamentado nos princípios da universalização, equidade, integralidade, descentralização e participação popular (Brasil, 1990).

O conceito de saúde adotado pelo SUS avança ao incorporar primeiro os elementos psicológicos e sociais, e negar que seja apenas ausência de doença (OMS, 1948), avança ainda ao incorporar não só tratamento dos agravos, mas prevenção, promoção de saúde e reabilitação e ações de vigilância epidemiológica e sanitária (Brasil, 1990).

A integração do processo de formação médica com a rede SUS exige ruptura com o paradigma biomédico que dá primazia à fisiopatologia, minimizando os determinantes sociais e o senso de pertencimento, identidade comunitária e espiritualidade que foi agregado ao conceito de saúde adotado pela OMS em 1998 (Salgado, 2006).

A integração com a rede promove a incorporação da teoria da complexidade, evocando a integralidade, intersectorialidade, multidimensionalidade (Cabral; Viana; Gontijo, 2020).

Considerando os paradigmas do SUS e os paradigmas do ensino tradicional (Quadro 05).

Quadro 05 - Conceitos e práticas tradicionais e sistêmico

CONCEITOS E PRÁTICAS DO PARADIGMA TRADICIONAL(NEWTON-CARTESIANO)	CONCEITOS E PRÁTICAS DO PARADIGMA SISTÊMICO
Teoria microbiana/epidemiologia	Teoria da complexidade
Modelo explicativo da história natural da doença	Modelo explicativo do campo da saúde de Lalonde
Modelo biomédico	Modelo dos determinantes sociais de saúde
Saber anátomo-clínico	Saber biopsicossocial
Saúde enquanto ausência de doença	Saúde enquanto bem-estar complexo
Especialização	Predomínio da atenção primária de saúde
Método clínico centrado na doença	Método clínico centrado na pessoa
Saber multidisciplinar e multiprofissional	Saber interdisciplinar/interprofissional
Prevenção de doença	Promoção de saúde
Verticalização das relações	Horizontalização das relações
Verdades absolutas	Verdades co-construídas
Práticas pedagógicas tradicionais	Práticas pedagógicas libertadoras
Avaliação tradicional	Avaliação mediadora
Competição	Postura de colaboração
Administração hierarquizada	Administração em redes

Autoria própria, baseada em Cesario, Cesario e Santos (2019)

A relação entre o estudante com a realidade do SUS será mediada pela figura do preceptor, considerado como o profissional que acompanha ou facilita o processo de ensino-aprendizagem nos cenários de prática, e a atividade deste profissional é crucial para o bom desenvolvimento do estudante, competindo a ele apresentar todas as dimensões do cuidado à saúde, no caso, a atenção à saúde, a gestão em saúde e a educação em saúde (Nordi et al., 2022).

O curso de medicina vai articular o processo de qualificação dos preceptores para que possam:

(i) orientar a organização das práticas voltadas à construção de um cuidado integral, eficiente, efetivo e seguro, pautado pela garantia de acesso, continuidade, equidade e qualidade da atenção à saúde, especialmente por meio da aplicação de ferramentas e dispositivos da gestão da clínica;

(ii) promover a articulação do trabalho e da educação, participando de iniciativas de mudanças nas práticas educativas e de cuidado, orientadas às necessidades de saúde da população;

(iii) facilitar processos de aprendizagem, promovendo o pensamento crítico e reflexivo do educando, mostrando responsabilidade, tolerância e comprometendo-se com a educação como forma de intervenção no mundo, e de transformação da realidade.

4.1.5 Avaliação voltada para o incremento da aprendizagem e aperfeiçoamento do processo educacional

4.1.5.1 Conceitos gerais

A avaliação é uma etapa das mais relevantes no processo educacional, tanto por permitir obter informações sobre o processo pedagógico, como também do aproveitamento do processo pelo estudante (Troncon, 1996).

Indissociável do planejamento e do ensino, este último entendido como o processo contínuo no qual o conhecimento é transformado em algo com sentido através de conexões entre fontes de informação, e a formação de padrões úteis que geralmente resultam em algo que pode ser utilizado em algum contexto de forma consciente (Hift, 2014), o que tem como consequência que avaliar, pode passar por verificar a aquisição de informações, mas necessariamente precisa ter como foco a observação da aplicação dos padrões de entendimento surgidos a partir delas em situações novas.

Tanto a teoria subjacente das categorias de Bloom (saber, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar), quanto os níveis de competência clínica da pirâmide de Miller (saber, saber como, mostrar como e fazer) (Domínguez-Torres; Vega-Peña, 2023), o modelo de cinco estágios para aquisição das habilidades de Dreyfus e Dreyfus (1980) (Quadro 06) incorporam o mesmo padrão de complexidade crescente que inicia do conhecimento não contextual e rígido, até os níveis mais avançados, fluidos, intuitivos e aplicáveis em novos contextos.

Quadro 06 - Estágios para aquisição das habilidades clínicas de Dreyfus e Dreyfus

ESTÁGIO	CARACTERÍSTICAS
1. Novato	performance baseada em regras e protocolos incapaz de lidar com a complexidade vê as tarefas isoladamente (sem contexto) precisa de supervisão o tempo todo
2. Iniciante avançado	performance baseada em protocolos e guias, mas também com base na experiência capaz de lidar com a complexidade com análise e planejamento tarefa vista como uma série de passos /etapas capaz de fazer tarefas simples com supervisão indireta tarefas complexas demandam supervisão
3. Competente	performance não apenas baseada em regras e guias, mas também com base na experiência prévia. capaz de lidar com a complexidade com análise e planejamento tarefa vista como um construto capaz de fazer tarefas rotineiras complexas precisa de supervisão em tarefas complexas não rotineiras
4. Proficiente	performance baseada em experiência e intuição tem performance aceitável em atividades de rotina capaz de lidar com tarefas complexas de modo analítico opções relacionadas também vistas através de uma dada tarefa ainda precisa de supervisão para tarefas complexas não rotineiras. capaz de supervisionar outros em tarefas rotineiras complexas
5. Experiente	performance baseada na experiência e intuição alcança performance excelente em situações complexas transita facilmente entre soluções analíticas e intuitivas todas as opções relacionadas a uma dada tarefa são consideradas capaz de treinar e supervisionar outros em tarefas complexas de rotina e não rotineiras

Autoria própria, baseado em Dreyfus e Dreyfus (1980) e Khan e Ramachandran (2012)

O argumento de Dreyfus e Dreyfus (1980) é que as competências complexas em seu estado inicial são geradas seguindo regras formais, e apenas experiências podem gerar níveis mais

avançados de conhecimento, performance, e aponta que o treinamento continua até o nível de competente sendo que é parte da competência saber utilizá-la no contexto correto e atingir resultados por meio delas (Khan; Ramachandran, 2012)

Importante lembrar que o modelo explicativo de Dreyfus e Dreyfus (1980) foi desenvolvido para descrever o conhecimento de pilotos de avião, e que depois foi generalizado para outras atividades, e não é o único modelo, havendo também o da professora Elizabeth Simpsons e da professora Harrow que explicam a aquisição da competência em 5 estágios: estágio da resposta guiada (imitação e tentativa e erro); estágio mecânico, onde a habilidade pode ser mostrada com alguma confiança e proficiência; estágio da resposta aberta complexa, onde o indivíduo poderia ser considerado competente; estágio da adaptação, onde as habilidades estão bem desenvolvidas e o indivíduo pode modificar padrões de movimento para enfrentar situações difíceis; e o estágio final, onde o indivíduo pode criar novos padrões e habilidades para enfrentar situações únicas. (Sawyer et al., 2015).

A avaliação das habilidades pede compreensão teórica diferente da avaliação cognitiva.

4.1.5.2 Concepções de avaliação em educação

Cada uma das concepções citadas têm contribuições e contradições, sendo necessário ter clareza das características e problemas de cada uma (Quadro 07)

Quadro 07 – Concepções em avaliação na literatura internacional

CONCEPÇÃO	PERÍODO	TERMOS CHAVE	CENÁRIO DA DEMANDA
1.Mensuração	1890 - 1930	- Medição - Objetividade - Escola “tradicional”	Testes para o sistema educacional e forças armadas norte americanas
2.Orientada por objetivos	1930 - 1957	- Objetivos educacionais - Taxonomia dos objetivos educacionais - Avaliação como descrição do desempenho do estudante relacionado ao comportamento de seu grupo - Avaliação da eficiência da escola - forte influência da psicologia - Escola “progressista”	Reformas curriculares e massificação do sistema educacional nos países desenvolvidos.
3.Juízo de valor	1957-1973	- Ruptura com o paradigma positivista em educação - Influência das ciências sociais e de estudos de economia - Incorporação de elementos da sociologia, antropologia e psicologia social à avaliação. - Avaliação dos estudantes, escolas, docentes, conteúdos e metodologias - Avaliação somativa, formativa e global para superar lacunas nas práticas avaliativas - Era do “realismo”	Críticas à efetividade do sistema educacional norte -americano e às políticas de avaliação; Responsabilização da escola pelos baixos rendimentos dos estudantes; Cobrança de transparência sobre financiamento em educação.
4.Negociação	Após 1973	- Negociação quantitativa / qualitativa / formativa / diferenciada / integrativa - Conceito de meta avaliação. - Avaliação da mudança ocorrida no estudante - Função política da avaliação - Considera os valores dos grupos avaliados. - Promoção de valores democráticos	Políticas de avaliação e os regimes de regulação burocrático-profissional.

Fonte – Autoria própria baseado em SILVA; GOMES (2018)

A crença de uma pretensa neutralidade do avaliador, a valorização da memória e das informações, e a descontextualização do processo avaliativo são as principais críticas da concepção de avaliação enquanto mensuração, enquanto não considerar os fatores sociais nem o papel social e político da avaliação, e não oferecer elementos para melhoria do currículo seriam os problemas da concepção da avaliação orientada por objetivos (Silva; Gomes, 2018).

Esta evolução de paradigmas no campo repercutiu na legislação educacional brasileira que hoje entende que a avaliação deve ser contínua e cumulativa e deve ter os aspectos qualitativos prevalentes sobre os quantitativos (Brasil, 1971, Brasil, 1996).

4.1.5.3 Tipos de avaliação

As avaliações podem ser classificadas, de diferentes modos:

a) **conforme seu propósito:** em formativa e somativa, sendo a primeira aquela que se faz durante o processo pedagógico para, através de feedback, ajudar o estudante a perceber as forças e fraquezas dos esforços que faz para alcançar os objetivos educacionais, e pela qual o docente pode observar questões relacionadas ao processo de aprendizagem; e a segunda aquela feita ao final do processo pedagógico para avaliar o quanto dos objetivos educacionais foram alcançados, geralmente classificatória (Scriven, 1966).

b) **conforme o momento de aplicação:** em diagnóstica, processual e acumulativa (somativas) ou final. A diagnóstica é a que é feita com o objetivo de avaliar as características dos estudantes no aspecto pessoal, como de conhecimentos prévios; a processual é a formativa feita durante o processo de andamento do curso, inclusive, segundo o autor da Teoria da Aprendizagem que a apresentou, deve ser relacionada ao que ocorreu durante a atividade,¹ e não relacionada a objetivos prévios definidos pelo docente (Scriven, 1966) e acumulativa, a que se faz ao final do curso.

c) **conforme o referencial de análise:** em normativa e critério referenciada. A avaliação normativa é aquela que a informação avaliativa será interpretada em relação à curva de distribuição de seus pares, de modo hierarquizado e classificatório. Na avaliação critério referenciada, a avaliação obtida será comparada com um conjunto de critérios selecionados previamente como relevantes para a formação do futuro profissional e com forte impacto na melhora da aprendizagem por promover a autorregulação da aprendizagem (Ferraz et al., 1994).

4.1.5.4 Atributos fundamentais dos métodos de avaliação

Além do já exposto, a escolha de um método avaliativo precisa ainda atentar para os elementos indicados no quadro 08:

Quadro 08. Elementos a serem considerados na escolha do método avaliativo

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
1. Validade (Coerência)	Refere-se à precisão e à exatidão com que uma avaliação realmente mede o que se propõe a medir. Para garantir a validade é essencial utilizar métodos apropriados que estejam alinhados com os objetivos de aprendizado, além de selecionar adequadamente os conteúdos e tarefas a serem avaliadas, para representar fielmente as competências/desempenhos que se deseja medir. O que vai ser avaliado precisa ser definido previamente: se vai ser uma avaliação de elemento cognitivo, atitude ou habilidade psicomotora.
2. Fidedignidade (Reprodutibilidade, confiabilidade ou consistência)	Refere-se à precisão, acurácia e reprodutibilidade. Deve ser possível controlar a maior parte dos fatores internos e externos envolvidos na avaliação. Todos os avaliados devem encontrar as mesmas condições. Os resultados da avaliação devem ser os mesmos se repetidos em circunstâncias semelhantes.
3. Equivalência	A mesma avaliação produz pontuações ou decisões equivalentes quando administrada em diferentes instituições ou ciclos de testes.

4.Flexibilidade e Factibilidade	O método avaliativo deve ser possível ser executado. É prático, realista e sensato, dadas as circunstâncias e o contexto.
5.Impacto educacional	O método avaliativo deve repercutir no processo de ensino aprendizagem e este impacto deve ser monitorado
6. Efeito catalítico	A avaliação fornece resultados e feedbacks que motivam todas as partes interessadas a criar, melhorar e apoiar a educação e a qualidade geral do programa.
7.Aceitabilidade (credibilidade)	O método avaliativo deve ser aceito pelos estudantes e avaliadores e considerado pertinente, adequado e honesto.
8.Transparência	O método avaliativo deve ser claro e bem compreendido por todos
9.Autenticidade	Representa uma situação real do ambiente de trabalho
10.Complexidade cognitiva	Incorpora habilidades cognitivas complexas
11.Justiça	As tarefas devem corresponder ao nível de desenvolvimento do estudante
12. Relevância	A temática avaliada deve ser relevante para a prática profissional

Autoria própria, baseado em Baartman et al. (2007); Troncon; Panuncio-Pinto (2014); Troncon (2016); Norcini et al. (2018) e CFM (2020)

4.1.5.5 Princípios gerais em avaliação

As melhores evidências em programas de avaliação estão sumarizadas no Quadro 09

Quadro 09 – Melhores evidências em programa de avaliação

PRINCÍPIO	COMENTÁRIO
1.Cada avaliação (ou parte) é apenas um ponto de dados	O programa de avaliação deve ser desenhado para otimizar a função de aprendizagem da avaliação, gerando informações significativas, muitas vezes feedbacks narrativos. Devem ser criadas, propositalmente, oportunidades de avaliações de apoio e/ou feedback para concretizar a função da avaliação programática. Avaliações únicas não devem ser usadas para decisões de aprovação-reprovação.
2. Cada ponto de dados pode otimizar a aprendizagem, fornecendo feedback significativo ao estudante	
3. As decisões de aprovação/reprovação não são fornecidas em um único ponto de dados	
4. Existe uma combinação de métodos avaliativos	Cada método avaliativo apresenta limitações em termos de validade e confiabilidade e pode ser usado para testar apenas um nível da pirâmide de Miller. É necessário uma combinação de métodos avaliativos para cobrir todos aspectos indicados na pirâmide e assegurar a validade e confiabilidade. A escolha do formato de avaliação deve estar completamente alinhada com os resultados de aprendizagem desejados e as atividades de ensino
5. A escolha do método deve depender da justificativa educacional para a utilização do mesmo	

6. A distinção entre somativa e formativa é substituída por um continuum de desafios/marcos a serem alcançados	Na avaliação programática, os desafios da avaliação são organizados num continuum de avaliações de baixo e alto impacto para os estudantes, contrastando com a dicotomia mais tradicional e binárias entre avaliação formativa versus avaliação somativa.
7. A tomada de decisões sobre o progresso do estudante está proporcionalmente relacionada ao interesse	Na avaliação de baixo risco, os resultados não têm consequências ou têm consequências limitadas para o estudante em termos de aprovação ou reprovação. O ponto de dados é otimizado para aprendizagem. A avaliação/tomada de decisão de alto risco traz consequências importantes, como graduação ou promoção.
8. As informações de avaliação são trianguladas entre pontos de dados em direção a uma estrutura de competências	Requer a combinação de dados qualitativos e quantitativos, gerenciamento central do processo, corpo docente com experiência em processos avaliativos, além do estabelecimento de processos eficazes de tomada de decisão em grupo a partir de uma visão holística dos dados. Um sistema robusto para coletar todas avaliações e retornos do feedback é essencial Ex: portfólio eletrônico)
9. Decisões de alto risco são tomadas de forma confiável e transparente, usando uma abordagem holística	A decisão de progressão (decisão de alto risco) é baseada num conjunto de dados coletados ao longo do tempo, provenientes de uma ampla amostragem, em contextos, métodos de avaliação e avaliadores diversos.
10. A revisão intermediária é feita para discutir e decidir com o estudante sobre sua progressão	As decisões de progressão (alto risco) são tomadas ao final de período, ano ou programa e não podem ser surpresas para os estudantes. É obrigatório que os estudantes recebam feedback informativo sobre uma decisão e orientações para recuperação.
11. Os estudantes têm reuniões recorrentes de aprendizagem com mentores (docentes) utilizando a autoanálise de todos os dados de avaliação	O feedback é essencial para o aprendizado e o desenvolvimento profissional. Na maioria das vezes, é estruturado na auto análise/reflexão por parte do estudante, sendo necessário a orientação por um mentor/facilitador.
12. A avaliação programática procura aumentar gradualmente a autonomia e a responsabilidade do estudante pela sua própria aprendizagem por meio da adaptação do processo de aprendizagem as suas necessidades individuais	A motivação e autorregulação dos estudantes são essenciais para a aprendizagem. O sentimento de estar no controle é essencial para percepção dos desafios crescentes relacionados à avaliação.

Autoria própria, baseado em Van Der Vleuten et al.,(2012); Schut et al., (2018) Heeneman et al., (2021)

4.2 Prática Profissional e Formação Técnica

A construção de competências para o exercício profissional da medicina pressupõe a inserção dos estudantes nos diversos cenários do sistema de saúde e nos diferentes ambientes de trabalho.

As Diretrizes Curriculares Nacionais estimulam a inserção precoce do estudante na rede de saúde, de maneira a problematizar as situações encontradas à luz de um novo modelo de formação, privilegiando a atenção primária à saúde enquanto organizadora e coordenadora da rede de atenção.

Deve-se levar em conta que os sujeitos não são seres isolados, mas, possuem a sua cultura e uma inserção na comunidade, que exercem grande influência no processo saúde–adoecimento–cuidado. Espera-se que a formação médica propicie essas vivências, para que o estudante possa entender o processo de adoecimento em seu contexto biopsicosociocultural e o funcionamento de estruturas de atendimento e seus modelos assistenciais.

O processo de aprendizagem deve ser direcionado para a mudança nos atuais modelos de trabalho, que fragmentam o indivíduo, focando-se apenas na doença. Ele deve estimular a prática interdisciplinar, o cuidado integral e a qualidade da atenção.

No Percurso da Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho busca-se reconhecer os contextos culturais e os processos históricos de construção cultural, assim como entender o papel dos diferentes indivíduos e profissionais no processo saúde-adoecimento-cuidado, apoiando o fortalecimento do cuidado integral, da ação intersetorial e de estímulo à autonomia dos sujeitos em seu cuidado com a saúde.

A incorporação dos serviços de saúde e de outros equipamentos sociais como cenários de aprendizagem, possibilita a diversificação da formação que, assim, se aproxima da prática profissional real. As modalidades de cuidado à saúde são consideradas, numa perspectiva de integralidade da atenção, e para tanto foram incorporados à formação médica, os cenários de atendimento domiciliar, ambulatorial, pré-hospitalar, hospitalar, serviços de urgência-emergência, escolas, creches e instituições para idosos, entre outros.

Para cada um desses cenários destacam-se capacidades específicas a serem desenvolvidas e outras, consideradas transversais, que podem ser mobilizadas e transferidas, de um contexto para outro.

O conjunto dos cenários potenciais de aprendizagem para a formação médica é chamado: Rede de Saúde Escola, fruto de uma relação paritária entre a UFCAT e a Prefeitura Municipal de Catalão, responsável pela formulação da política de formação na área da saúde e de organização do modelo de atenção à saúde no município.

4.3 Formação ética e função social do profissional

Os profissionais de saúde têm um papel crucial como mediadores na aplicação do conhecimento para melhorar a saúde. Eles não apenas fornecem serviços de saúde, mas também atuam como cuidadores, educadores, líderes e formuladores de políticas.

Dessa forma, a educação profissional na área da saúde desempenha um papel central na melhoria da saúde das pessoas, famílias e comunidades. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de uma combinação especial de competência técnica e orientação para o serviço, aliada ao compromisso ético e responsabilidade social dos profissionais de saúde.

Conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a inclusão de aspectos éticos e humanísticos nas grades curriculares é essencial para a formação de profissional adequada às necessidades da sociedade e uma missão essencial para os futuros profissionais de saúde, para que não se perca ao longo do curso.

Essa abordagem multidisciplinar estimula os estudantes a adotarem uma perspectiva atenta às necessidades da sociedade, baseada em direitos humanos e dignidade da pessoa humana, o que contribui para uma melhor adaptação aos cenários de prática e inspira responsabilidade ética e profissional.

Na proposta pedagógica elaborada para o Curso de Medicina, aspectos éticos e humanísticos, como as dimensões biológicas, psicológicas, étnico-raciais, socioeconômicas, culturais, ambientais e educacionais são abordadas de modo transversal, durante todo o currículo,

por meio do processamento de problemas de saúde-adoecimento-cuidado em cenários reais e simulados.

Os percursos tanto da prática profissional simulada e em contexto real do trabalho, como da formação profissional singular, estarão em permanente construção e diálogo, para propiciar essa formação que direciona o perfil do egresso para as competências e prima pela integralidade de uma Medicina centrada no indivíduo, voltada para dimensão biopsicossocial do processo saúde-adoecimento-cuidado.

Dessa forma, espera-se que o egresso do Curso de Medicina da UFCAT seja capaz de:

Aplicar os princípios morais, éticos e as responsabilidades legais inerentes à profissão;

Demonstrar valores profissionais que incluem a busca da excelência, do altruísmo, da responsabilidade, da compaixão, da empatia, da honestidade, da integridade, do compromisso com os métodos científicos e da disponibilidade para prestar contas dos atos executadas;

Promover, realçar e direcionar os elementos acima para o benefício dos pacientes, da profissão e da sociedade em geral;

Reconhecer que a boa prática médica depende da compreensão e do relacionamento com o paciente e com a família, respeitando a diversidade cultural, crenças e autonomia;

Se implicar nas tomadas de decisão em consonância com os aspectos morais, éticos, legais e profissionais;

Auto-avaliar-se e reconhecer as limitações pessoais, incluindo as do conhecimento médico;

Demonstrar respeito aos colegas e outros profissionais de saúde e promover um relacionamento colaborativo multiprofissional;

Reconhecer a obrigação moral de fornecer cuidados, ao paciente, no fim da vida, incluindo o tratamento paliativo;

Reconhecer as questões éticas e médicas relativas à documentação, prontuário, plágio, e propriedade intelectual;

Planejar e controlar eficientemente o tempo de trabalho, contemplando as atividades para lidar com a incerteza e adaptar-se a mudanças. Responsabilizar-se pessoalmente pelo cuidado individual do paciente.

4.4 Interdisciplinaridade

Interdisciplinaridade e integração de saberes entre diferentes áreas de conhecimento, envolvendo as ciências básicas, as áreas clínicas, as ciências sociais e humanas e do comportamento e as da saúde coletiva (com sua interface com as Ciências Exatas), são desejadas.

As várias áreas de conhecimento são integradas em uma mesma unidade educacional (integração horizontal), ao mesmo tempo em que garante uma continuidade na construção de conhecimentos, habilidades e atitudes em graus crescentes de complexidade ao longo do curso (integração vertical).

De acordo com Fazenda (1998), o método para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o de transpor posições acadêmicas unilaterais em práticas de ensino integralizadas. Ainda segundo Japiassu (1976, p.122), o trabalho interdisciplinar faz apelo, diretamente à realidade concreta dos empreendimentos humanos e da história. Neste caso, toma efetivamente corpo entre aqueles que elegem esta prática integradora como formação do profissional médico.

A metodologia do curso exige uma organização curricular correspondente com a integração dos conteúdos, aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. A interdisciplinaridade coloca-se, então, como forma de atingir esses objetivos.

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade se faz essencial para a construção de novos saberes, os quais relacionam não apenas o conhecimento técnico, mas incorporam, igualmente, o perfil epidemiológico regional, a organização da rede de saúde, e os aspectos políticos e sociais.

A integração interdisciplinar, e entre a teoria e a prática, o mundo do trabalho e da aprendizagem, e entre processos educativos e de atuação profissional é um desfecho deste currículo, fundamentos dessa iniciativa educacional. Essa integração é expressa pela (o):

- (i) construção de um perfil de competência baseado na abordagem dialógica de competência
- (ii) identificação de macro problemas ou desafios a serem enfrentados pelos profissionais formados, considerando-se o contexto interno e externo das condições de saúde-adoecimento-cuidado e do SUS no país;
- (iii) exploração da teoria a partir de situações prevalentes do mundo do trabalho, relacionadas aos macro problemas e desafios a serem enfrentados;
- (iv) participação interdisciplinar e multiprofissional dos professores e técnicos educacionais responsáveis pelos conteúdos específicos, para o desenvolvimento do perfil de competência e pela construção das experiências e das atividades educacionais do curso;
- (v) desenvolvimento de intervenções na realidade, visando à construção de processos de mudança voltados à melhoria e consolidação do SUS;
- (vi) avaliação formativa e somativa, envolvendo todos os atores e dimensões do programa.

4.5 Articulação entre teoria e prática

A articulação teoria-prática se estabelece na integração entre a aprendizagem em ambiente protegido e o cenário do trabalho, deslocando o aprendizado estrito de conceitos abstratos nas disciplinas, para aplicação desses conhecimentos em situações reais de atenção/cuidado.

Na formação orientada por competência, a articulação ensino-pesquisa-extensão é um dos elementos constitutivos da integração teoria-prática, uma vez que busca conectar a academia com a realidade social, e possibilita o uso do conhecimento científico para atender às necessidades da comunidade. Essa articulação também orienta a formação e a produção de novos conhecimentos às necessidades sociais, e promove a inserção de estudantes e professores na Rede de Saúde Escola de modo orgânico.

No processo educacional, a integração teoria-prática é vivenciada de maneira concomitante, não havendo precedência de uma em relação à outra, ou a priorização de uma dimensão específica

(cognitiva, psicomotora ou atitudinal) em detrimento das outras. O objetivo é desenvolver o estudante de forma integrada, considerando todos esses aspectos em conjunto. As disciplinas deixam de ser os elementos disparadores da aprendizagem, que passa a ser desencadeada por situações de saúde-adoecimento-cuidado pertencentes ao campo de atuação da prática profissional médica. Ao confrontar com situações reais ou simuladas da prática profissional, os estudantes se deparam com desafios que lhes conferem sentido à aprendizagem. Isso torna a experiência educacional mais significativa, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades requeridas para a atuação profissional. A aprendizagem é direcionada pelas necessidades dos estudantes frente às situações apresentadas. Isso coloca o estudante como o centro do processo educacional e permite que eles sejam protagonistas de sua própria formação. As dimensões biológica, ético-social, técnico-política e as relações intersubjetivas são abordadas de maneira articulada, sempre ancoradas ao desafio de melhor explicar e fundamentar a intervenção médica frente às situações que representam a realidade da prática profissional.

4.5.1 Articulação teoria-prática: cenários reais da prática médica

A inserção dos estudantes no cenário do trabalho é realizada de modo a promover um ambiente que incentive o estabelecimento de vínculos e co-responsabilização com as pessoas atendidas, familiares e equipes, e serviços de saúde. Essa abordagem potencializa o estabelecimento de uma relação de confiança e empatia e o envolvimento dos pacientes/familiares em seu próprio cuidado. Nessa interação, os estudantes são acompanhados pelos preceptores, profissionais de saúde experientes. Os mesmos devem estar atuando diariamente nos serviços de saúde onde os estudantes realizam cotidianamente suas ações. Dessa forma, os preceptores têm a oportunidade de ensinar e orientar os estudantes com base em suas próprias práticas e experiências reais. Durante esse período, os estudantes são monitorados conjuntamente pelos preceptores e professores vinculados à Universidade, de forma contínua, para avaliar seu desenvolvimento, considerando o grau de domínio e autonomia esperado para a fase do curso em que se encontram. Isso inclui observar sua capacidade de realizar ações pertinentes ao contexto específico, e sua habilidade de justificar suas ações com fundamentação respaldada nas melhores evidências científicas. É essencial que as relações entre estudantes, profissionais de saúde e pacientes sejam pautadas em princípios éticos sólidos. Os direitos humanos devem ser respeitados, garantindo que as pessoas atendidas não sejam tratadas como objetos de aprendizado, mas sim como seres humanos com dignidade e autonomia.

4.5.2 Articulação teoria-prática: cenários simulados da prática médica

A inserção dos estudantes em cenários simulados da prática profissional têm por objetivo proteger os pacientes/famílias e proporcionar aos estudantes um ambiente de aprendizagem seguro. Os cenários educacionais protegidos permitem que todos os estudantes sejam expostos a experiências comuns, facilitando o acompanhamento e a sistematização das trajetórias de aprendizagem de uma coorte específica, o que pode ser difícil de controlar em contextos puramente reais. Como estímulos para a aprendizagem, nesses cenários podem ser utilizadas: situações-problema em papel, casos clínicos, atendimentos simulados da prática profissional com pacientes simulados e/ou manequins, filmes, dramatizações, entre outras técnicas. Essas experiências educacionais estimulam, ao longo de toda a formação do estudante, a exploração

integrada das diversas disciplinas básicas e clínicas. Tal como acontece na vivência real, as experiências educacionais retratam pessoas ou circunstâncias que necessitam de atendimento médico. A partir dos problemas identificados nessas situações, os processos de adoecimento são explorados como um todo, considerando o indivíduo, a família, a comunidade, além da realidade epidemiológica e profissional. A abordagem contínua, contextualizada e relacionada com intervenção profissional aumenta o potencial educacional de retenção do conhecimento e torna o conhecimento mais significativo e útil para o estudante.

4.5.3 Articulação teoria-prática: integração ensino-pesquisa-extensão

Desde o primeiro ano do curso médico, os estudantes têm a oportunidade de realizar atividades educacionais com o acompanhamento direto de preceptores vinculados aos serviços de saúde e de professores vinculados à Universidade. Os estudantes têm a oportunidade de aprender em diferentes cenários da rede e participar de projetos de pesquisa ou intervenção que atendam às necessidades de saúde da população de Catalão.

A integração entre ensino, pesquisa e extensão permite o desenvolvimento de diversas atividades relacionadas ao cuidado à saúde das pessoas e de grupos sociais, e da organização do trabalho em saúde. O objetivo do processo educacional é que os estudantes alcancem excelência na investigação das necessidades de saúde, na elaboração de planos terapêuticos, na organização do trabalho em saúde, e no enfrentamento de necessidades de aprendizagem e produção de novos conhecimentos.

Paralelamente aos ganhos educacionais para os estudantes, os programas e projetos de pesquisa-extensão desenvolvidos pelos professores vinculados à UFCAT têm um impacto significativo na comunidade atendida pela Rede de Saúde Escola. Essas iniciativas contribuem para solucionar problemas de saúde da população local e promovem um melhor acesso aos serviços de saúde.

Essa integração também apoia a inserção dos professores na Rede de Saúde Escola, possibilitando a participação dos mesmos no apoio matricial aos serviços de saúde, e no desenvolvimento de projetos de pesquisa/intervenção voltados para troca de conhecimentos, aprimoramento dos serviços e geração de novas soluções em saúde.

CAPÍTULO 5 - EXPECTATIVA PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

5.1 Perfil do Curso

O Curso de Medicina da UFCAT propõe formar médicos, enfatizando a formação:

1. generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva, orientada por competência e segundo uma abordagem construtivista do processo ensino-aprendizagem e com a avaliação referenciada em critérios de excelência;
2. baseada na articulação ensino-pesquisa-extensão: pela participação de estudantes e professores na prestação de cuidados qualificados à saúde, nos diferentes cenários e serviços da Rede Municipal de Saúde;
3. em consonância com o SUS, à luz dos princípios da universalidade, equidade e integralidade; pela participação de preceptores vinculados aos serviços de saúde na formação dos estudantes e pela construção de novos saberes voltados à melhoria da saúde das pessoas e, por extensão, da qualidade de vida da sociedade.
4. englobando as seguintes áreas de competência de:
 3. Atenção à Saúde: cuidado às necessidades de saúde individuais e coletivas;
 4. Gestão em Saúde: organização do trabalho em saúde;
 5. Educação na Saúde: construção de saberes e práticas em saúde e medicina.
- 6.

5.2 Pressupostos para o perfil geral dos profissionais formados pela UFCAT são:

I – comprometer-se com educação humana integral, consciente e cidadã;

II – gerenciar e/ou incluir-se em processos participativos em setores profissionais visando o desenvolvimento da sociedade brasileira

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;

VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares;

IX – fomentar e realizar atividades/ações, programas orientados ao desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social, nas áreas de conhecimento de sua competência;

X – contribuir para o desenvolvimento da sociedade mediante ações que venham a defrontar necessidades de ordem econômica, social, esportiva, cultural, ambiental, de saúde e de lazer;

XI – estimular a criação cultural e intelectual, além do desenvolvimento científico, tecnológico e do pensamento reflexivo e crítico.

CAPÍTULO 6 - PERFIL DO EGRESSO

Em consonância com a Resolução CNE/CES no 3, de 20 de junho de 2014, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina - DCN, o perfil profissional do egresso do Curso de Medicina da UFCAT compreende uma *"formação geral, humanista, crítica e reflexiva, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença"* (Brasil, 2014).

Pretende-se que o egresso esteja inserido na rede de saúde pública do interior de Goiás, especialmente a Região de Saúde da Estrada de Ferro, com forte vinculação e compreensão da realidade sócio econômica e cultural das regiões envolvidas e compromisso com a qualificação da assistência em saúde prestada à população.

6.1 Perfil de competências do Egresso

Considerando as Diretrizes Curriculares para Graduação Curso Medicina 2014 (Brasil, 2014), o perfil de competência do médico formado pela UFCAT será representado pelo desenvolvimento articulado de três áreas de competência que delimitam o escopo de trabalho na atuação profissional, no contexto do SUS local e regional: I) Atenção à Saúde: cuidado às necessidades de saúde individuais e coletivas; II) Gestão em Saúde: organização do trabalho em saúde; III) Educação na Saúde: construção de saberes e práticas em saúde e medicina (Quadro 1).

Cada uma dessas áreas é representada por um conjunto de ações-chave que são traduzidas em desempenhos que, por sua vez, retratam a integração das capacidades cognitivas, psicomotoras e atitudinais, agrupadas por afinidade nas áreas de competência.

A competência é aqui compreendida *"como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde"* (Brasil, 2014)

Na **área de competência atenção à saúde**, visamos formar um profissional cujo foco da atenção é transferido do modelo queixa/condução para a integralidade do cuidado, atuando tanto na promoção da saúde e prevenção de doenças, como no diagnóstico e tratamento da maioria dos problemas de saúde das pessoas e de grupos sociais. O processo de tomada de decisão deve ocorrer de forma compartilhada com os pacientes/familiares, considerando os princípios éticos e as melhores evidências científicas disponíveis. Nesse sentido, o egresso deve dominar tecnologias para trabalhar as dimensões biológica, subjetiva e social das pessoas, articulando as práticas de cuidado à saúde individual e coletiva nos diversos ciclos de vida, de modo a favorecer o desenvolvimento de vínculo e adesão dos pacientes.

O profissional médico deve estimular o autocuidado de seus pacientes, valorizando a autonomia na decisão sobre o estilo de vida desejado.

Nesse sentido, o egresso deve dominar tecnologias para trabalhar as dimensões biológica, subjetiva e social das pessoas, articulando as práticas de cuidado à saúde individual e coletiva nos diversos ciclos de vida, de modo a favorecer o desenvolvimento de vínculo e adesão dos pacientes. Deve-se buscar a negociação entre desejos e interesses das pessoas no tocante às suas vidas e saúde e, nesse sentido, entre as necessidades de saúde percebidas pelos profissionais de saúde, a partir dos referenciais ético-científicos, e as necessidades referidas pelas pessoas a partir de seus saberes. Espera-se dos profissionais que se dediquem a uma determinada especialidade, após sua formação, a manutenção de uma atuação no contexto da integralidade do cuidado à saúde. Essa abordagem oferece aos pacientes um diferencial no sentido da efetividade e da humanização do cuidado (Quadro 1).

Na **área de competência gestão em saúde**, o egresso deverá apresentar capacidades para trabalhar em equipe e construir, coletivamente, processos democráticos, participativos e co-responsáveis que visem à qualidade, eficiência e efetividade na organização do trabalho em saúde, de modo ético e socialmente compromissado (Quadro 1).

Na **área de competência educação em saúde**, deverá apresentar capacidades para aprender a aprender, produzir novos conhecimentos em bases científicas e éticas, e segundo os pressupostos da pesquisa em saúde. Deve socializar saberes, respeitando valores diferentes dos seus e a experiência prévia de pacientes, familiares, acompanhantes, profissionais de saúde formados e em formação, a partir de referenciais da educação de adultos e da abordagem construtivista do processo ensino-aprendizagem (Quadro 10).

Portanto, o perfil de competência contempla a atuação médica em diferentes cenários e âmbitos da atenção à saúde, segundo princípios da integralidade do cuidado, com responsabilidade social e compromisso com os direitos de cidadania e de dignidade humana. Orientado às necessidades locais e regionais de saúde, o perfil foi validado pelo Colegiado do Curso e por representantes dos parceiros da integração ensino-serviço

Quadro 10- Perfil de competência do egresso do Curso de Medicina da UFCAT, 2023.

Área de competência Atenção à Saúde: cuidado às necessidades de saúde individuais e coletivas		
Subárea: atenção à saúde das pessoas		
Identificação das necessidades individuais de saúde	Realiza história clínica	-Estabelece uma relação profissional ética no contato com pacientes, familiares e/ou responsáveis. Favorece a construção de vínculo, usando linguagem verbal compreensível ao paciente, atitude empática e cuidando de privacidade durante o atendimento. -Orienta o atendimento às necessidades de saúde do paciente, estimulando seu relato espontâneo e valorizando as preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas e desejos apresentados. -Identifica motivos e/ou queixas, evitando a explicitação de julgamentos e considerando o contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos e socioeconômico-culturais relacionados ao processo saúde-doença. -Orienta e organiza a anamnese, utilizando o raciocínio clínico epidemiológico e a técnica semiológica. -Investiga sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores de risco, condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares de modo orientado às necessidades

		identificadas. -Registra os dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara e legível.
	Realiza exame clínico	-Explica os procedimentos, manobras ou técnicas do exame clínico a serem realizados de modo aberto ao esclarecimento de dúvidas e obtém consentimento do paciente ou responsável. - Cuida da segurança, privacidade e conforto do paciente no exame clínico, ao máximo possível. - Realiza a inspeção, palpação, ausculta e percussão com postura ética e destreza técnica na aplicação das manobras e procedimentos do exame físico geral e específico, orientando-se pela história clínica e melhores práticas. -Compartilha com o paciente/responsável os sinais encontrados, esclarecendo dúvidas. Registra as informações do exame no prontuário, de modo legível e objetivo
	Formula hipóteses e prioriza problemas	-Estabelece hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da história e exame clínico. -Formula e prioriza os problemas do paciente, considerando as condições clínicas e os contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, ambiental e outros pertinentes. -Informa e esclarece suas hipóteses de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e questionamentos do paciente, familiares e responsáveis.
	Promove investigação diagnóstica	-Propõe e explica ao paciente/responsável a investigação complementar necessária para ampliar, confirmar ou afastar hipóteses diagnósticas. -Solicita exames complementares com base nas melhores evidências científicas, avaliando a possibilidade de acesso do paciente aos testes necessários, condições de segurança, eficiência e efetividade dos exames. -Interpreta e relaciona os resultados dos exames realizados considerando as hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o contexto do paciente. Registra e atualiza a investigação diagnóstica no prontuário, de forma clara e objetiva.
Constrói e avalia planos terapêuticos	Elabora e implementa planos terapêuticos	-Elabora planos de cuidados contemplando as dimensões de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, de modo contextualizado. -Discute o plano, suas implicações e o prognóstico, segundo as melhores evidências científicas e relação custo-efetividade. -Estimula o paciente a refletir sobre seus problemas e a promover o autocuidado. -Pactua as ações de cuidado, promovendo a participação de outros profissionais, sempre que necessário. -Disponibiliza prescrições e orientações legíveis, estabelecendo e negociando o acompanhamento e/ou encaminha o paciente com justificativa. Informa situações de notificação compulsória aos setores pertinentes de modo oportuno e socialmente responsável.
	Elabora e implementa planos terapêuticos	-Acompanha e avalia a efetividade clínica das intervenções realizadas, valorizando a avaliação do paciente/responsável sobre os resultados alcançados. -Favorece o envolvimento da equipe de saúde no monitoramento e avaliação das estratégias de cuidado e resultados obtidos, analisando dificuldades e conquistas. -Revê diagnósticos e planos terapêuticos, sempre que necessário, estabelecendo um diálogo permanente entre necessidades de saúde e planos de cuidado. -Explica e orienta os encaminhamentos ou a alta, verificando a compreensão do paciente ou responsáveis. -Registra o acompanhamento e a avaliação do plano no prontuário, buscando torná-lo um instrumento orientado ao cuidado integral do paciente

Quadro 10 (cont.)- Perfil de competência do egresso do Curso de Medicina da UFCAT, 2023.

Área de competência Atenção à Saúde: cuidado às necessidades de saúde individuais e coletivas		
Subárea: atenção à saúde coletiva		
Identifica necessidades coletivas de saúde	Investiga problemas de saúde coletiva	-Analisa as necessidades de saúde de grupos de pessoas e as condições de vida e de saúde de comunidades, a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das condições de saúde. -Acessa e utiliza dados secundários e/ou informações de forma a incluir o contexto cultural, socioeconômico, ecológico e das relações, movimentos e valores de populações, em seu território, visando ampliar a explicação de causas, efeitos e determinantes do processo saúde-doença.
	Reconhece os	-Relaciona os dados e as informações obtidas, identificando e articulando aspectos

	perfis do processo saúde-doença-cuidado	biológicos, psicológicos e socioeconômico-culturais e relacionando-os ao adoecimento e à vulnerabilidade de coletivos. -Participa da construção de diagnósticos ampliados de saúde e perfis epidemiológicos de grupos sociais e/ou comunidade, segundo princípios éticos, fundamentação clínico-epidemiológica e caracterização da natureza dos problemas e condições de saúde. -Seleciona e prioriza problemas a partir da análise de tendência, magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento e a importância técnica, cultural e política da situação, revelada pelas explicações e valores atribuídos pelos diferentes sujeitos envolvidos.
Desenvolve e avalia projetos de intervenção coletiva		-Participa da discussão e construção de projetos de intervenção em coletivos, de modo orientado aos problemas prioritizados, à melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade e à redução de riscos, danos e vulnerabilidades. -Estimula a inclusão da perspectiva de outros profissionais e representantes de segmentos sociais envolvidos na elaboração e desenvolvimento dos projetos de intervenção. -Participa de modo colaborativo da implementação de ações, apoiando o estabelecimento de metas, prazos, responsabilidades, orçamento e factibilidade, e buscando soluções criativas e inovadoras, sempre que necessário. -Participa da avaliação dos projetos de intervenção, prestando contas com transparência e compromisso social. Promove ajustes nos projetos de intervenção de modo orientado à melhoria da qualidade da saúde coletiva, considerando as melhores práticas e o permanente diálogo dos projetos com a identificação de necessidades coletivas de saúde.

Quadro 10 (cont.)- Perfil de competência do egresso do Curso de Medicina da UFCAT, 2023

Área de competência Gestão em Saúde: organização do trabalho em saúde		
Organiza o trabalho em saúde	Identifica problemas no processo de trabalho	-Identifica oportunidades e desafios na organização do trabalho nas redes de serviços de saúde, reconhecendo o conceito ampliado de saúde, considerando os princípios, diretrizes do SUS, as políticas de saúde, as normas institucionais dos ambientes de trabalho e o compromisso ético-profissional. - Trabalha de modo colaborativo em equipes de saúde, mostrando abertura para ouvir opiniões diferentes da sua e respeitando a diversidade de valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde e na identificação de problemas. - Utiliza diversas fontes para identificar problemas no processo de trabalho, incluindo a perspectiva dos profissionais, dos usuários, famílias e comunidade de modo articulado à análise de indicadores e do modelo de gestão. - Participa junto à equipe de saúde da priorização de problemas, identificando a relevância, magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os recursos disponíveis.
	Elabora e implementa planos de intervenção	- Participa com usuários, movimentos sociais, profissionais de saúde, gestores do setor saúde e outros setores implicados, construindo planos de intervenção para enfrentar os problemas prioritizados, com o objetivo de melhorar a organização do processo de trabalho e da atenção à saúde; - Apoia a criatividade e a inovação, na construção de planos de intervenção, implementando ações, que favoreçam a tomada de decisão, baseada em evidências científicas, na eficiência, na eficácia e na efetividade do trabalho em saúde - Negocia e avalia metas para os planos de intervenção, na perspectiva das políticas públicas de saúde, os colegiados de gestão e de controle social.
	Promove a gestão da clínica	- Promove a integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, articulando as ações de cuidado, na rede de serviços, próprios e conveniados ao SUS; - utiliza as melhores evidências, protocolos e diretrizes cientificamente reconhecidos, promovendo o máximo benefício à saúde, individual e coletiva, das pessoas e coletivos, com padrões de qualidade e de segurança na atenção à saúde - Favorece a articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a organização de sistemas integrados de saúde. - Desenvolve linhas de cuidado, facilitando o comprometimento de todos os profissionais e serviços com a organização de sistemas integrados de saúde.
Acompanha e avalia o		- Participa em espaços formais de reflexão coletiva sobre o processo de trabalho em saúde e sobre os planos de intervenção; monitorando o desenvolvimento dos planos, identificando conquistas e

trabalho em saúde	dificuldades; - Avalia o trabalho em saúde, utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, auditorias e processos de acreditação e certificação, promovendo ajustes e novas ações, de forma que os planos permaneçam atualizados e o trabalho em saúde em movimento; - Formula e recebe críticas, de modo respeitoso, valorizando o esforço de cada um e favorecendo a construção de um ambiente solidário de trabalho; - Estimula o compromisso de todos com a transformação das práticas e da cultura organizacional, no sentido da defesa da cidadania e do direito à saúde, como valores que orientam a gestão em saúde no contexto do SUS.
-------------------	---

Quadro 11 – área de competência educação em Saúde: construção de saberes e práticas em saúde e medicina

Área de competência Educação na Saúde: construção de saberes e práticas em saúde e medicina	
Identifica necessidades de aprendizagem individuais e coletivas	- Estimula a curiosidade e o desejo de aprender de todos os envolvidos, em todos os momentos do trabalho em saúde; - Identifica as próprias necessidades de aprendizagem, dos pacientes/responsáveis, dos cuidadores, familiares, da equipe multiprofissional de trabalho, de grupos sociais e/ou da comunidade a partir de uma situação significativa, respeitando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural de cada um, transformando saberes e práticas
Promove a construção e socialização de saberes e práticas em saúde	- Mantém postura flexível à transformação do conhecimento e da própria prática; - Escolhe de estratégias interativas para a construção e socialização de conhecimentos, segundo as necessidades de aprendizagem identificadas, considerando idade, escolaridade e inserção sociocultural das pessoas; - Orienta e compartilha conhecimentos e práticas em saúde e medicina com pacientes/responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, respeitando o desejo e o interesse desses, no sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde. - Estimula a construção coletiva de conhecimento em todas as oportunidades do processo de trabalho, propiciando espaços formais de educação permanente, participando da formação de futuros profissionais.
Promove o pensamento científico e apoia a produção de novos conhecimentos em saúde e medicina	- Utiliza os desafios do trabalho para estimular e aplicar o raciocínio científico, formulando perguntas e hipóteses e buscando dados e informações; - Analisa criticamente fontes, métodos e resultados, avaliando evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na educação de profissionais de saúde, pessoa sob seus cuidados, famílias e responsáveis; - Identifica da necessidade de produção de novos conhecimentos em saúde, a partir do diálogo entre a própria prática, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico disponíveis; - Favorece e participa do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas, disseminando as melhores práticas e apoiando a realização de pesquisas de interesse da sociedade.

Fonte: Autoria própria

6.2 Acompanhamento dos egressos

O curso de Medicina através de sua secretaria acadêmica manterá seguimento dos egressos no curso, tanto através de contato com os estudantes por e-mail, e outras Tecnologias de comunicação à distância, bem como por consulta aos CRMs avaliando e local de atuação avaliando: a) o grau de satisfação com o seu processo de formação, b) a satisfação com a formação crítico reflexiva recebida no curso, c) as suas expectativas com relação a formação continuada, d) o desenvolvimento profissional do egresso, e) o grau de satisfação com a prática de sua profissão, f) sua colocação no mercado de trabalho que é considerado um indicador positivo para a Instituição de Ensino Superior (Desidério; Ferreira, 2022).

O contato se fará a cada 12 meses após a formação, no período de 30 dias, inicialmente através de e-mail específico para este controle, que se tornará referência para todos os egressos do curso, e, no caso de não resposta, outras tecnologias de comunicação à distância.

O curso manterá uma página dentro do site do curso de medicina onde estarão a foto oficial da turma de egressos, os nomes dos participantes desta turma e o link para seus currículos Lattes.

Os dados obtidos serão organizados e compartilhados com os egressos.

O objetivo desta coleta de dados será para fornecer subsídios para aprimorar o planejamento acadêmico, incentivar os egressos a retornarem para fazer educação continuada, promover a vinculação aos grupos de estudo e pesquisa ligados ao curso de algum modo.

CAPÍTULO 7- ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso de Medicina da UFCAT foi projetada de modo a permitir que sejam trabalhados os avanços tecnológicos e as mudanças contemporâneas desejadas no cuidado e na formação profissional em saúde, com a transposição de um modelo estritamente biomédico para uma visão mais abrangente e integrativa do ser humano, para uma prática mais colaborativa e holística baseada em equipes de saúde e redes de atenção, com evidências científicas e socialmente relevante, visando a promoção da saúde e o tratamento eficaz dos processos de saúde-adoecimento-cuidado e o fortalecimento do SUS.

7.1- Matriz curricular

Assim, a matriz curricular do Curso de Medicina da UFCAT é formada por quatro eixos orientadores e três eixos organizadores, que correspondem aos Percursos Educacionais.

7.2- Eixos Orientadores

Considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina de 2014, alinhadas com as mudanças modernas nas práticas de atenção à saúde, reconhecem a importância de considerar não apenas a doença em si, mas também o contexto social, psicológico e ambiental de cada paciente/famílias, da elaboração de planos de cuidados contextualizados, singulares, baseados na ampla compreensão do processo saúde-adoecimento-cuidado, e da articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para atuação médica nas áreas de competência da Atenção à Saúde, da Gestão em Saúde e da Educação em Saúde, a matriz curricular engloba os eixos orientadores expressos na figura 05.

Figura 05- Eixos orientadores, habilidades e competências nos ciclos no Curso de Medicina da UFCAT



Fonte: Autoria Própria

Serão as seguintes as ênfases educacionais em cada período: PRIMEIRO ANO: educação médica, Movimento, proteção e segurança, alimentação e nutrição, respiração e meio ambiente, excreção e circulação, Interação, Percepção, Consciência e emoção, SEGUNDO ANO: processos de reprodução e genéticos, processos de homeostasia adaptativa, ciclos de vida: do nascimento e morte; processos inflamatórios, processos imunológicos, processos infecciosos e processos neoplásicos.

Quadro 12- Eixos orientadores da Matriz Curricular do Curso de Medicina UFCAT

Eixo orientador	Foco
Necessidades de saúde	Articula os determinantes biológicos, sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais do processo saúde-adoecimento-cuidado para cada pessoa e para grupos e comunidades. Aborda as necessidades de saúde referidas pelos pacientes/usuários e as percebidas pelos profissionais de saúde, considerando as especificidades dos ciclos de vida.
Planos de cuidado	Articula a elaboração de planos terapêuticos individuais e coletivos, considerando-se a promoção de estilos de vida saudáveis, a prevenção de doenças e a proposição de tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, segundo as necessidades de saúde identificadas e na compreensão do processo saúde-adoecimento-cuidado.
Processo saúde-adoecimento-cuidado	Articula os fenômenos biológicos (bases moleculares, celulares, bioquímicas, genéticas, fisiológicas, dos processos normais e alterados da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos), epidemiológicos, subjetivos e sociais, fundamentados em conteúdos curriculares das áreas básica e clínica, aplicados aos problemas da prática profissional e na perspectiva médica
Perfil de competência	Associa as áreas de competência da atenção à saúde individual e coletiva, da gestão do trabalho em saúde e da educação na saúde, que orientam a combinação de conteúdos cognitivos, psicomotores e atitudinais, visando o desenvolvimento dos desempenhos e das ações-chave expressos no perfil de competência do egresso.

Fonte – autoria própria

7.3 EIXOS ORGANIZADORES

O currículo está estruturado em 3 ciclos educacionais, com duração de 2 anos cada um:

- ✓ Integralidade do Cuidado I: primeiro e segundo anos letivos;
- ✓ Integralidade do Cuidado II: terceiro e quarto anos letivos;
- ✓ Integralidade do Cuidado III: quinto e sexto anos letivos.

Cada ciclo está organizado em eixos longitudinais e transversais, representados pelos Percursos Educacionais, que perpassam o currículo e correspondem a unidades educacionais (Quadro 13). Os mesmos são articulados entre si, de forma contextualizada e interdependente, formando um “contínuo”. Os percursos longitudinais são organizados pelos professores para todos os estudantes e o percurso transversal (percurso singular) é organizado a partir de necessidades específicas de cada estudante.

Os eixos organizadores do currículo são:

- (i) Percurso da Prática Profissional Simulada (PPPS)

(ii) Percurso da Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho (PPCART)

(iii) Percurso da Formação Profissional Singular (PFPS)

Quadro 13- Estrutura curricular segundo ciclo, anos e percursos curriculares, Curso de Medicina, UFCAT.

CICLOS EDUCACIONAIS	ANO	PERCURSOS CURRICULARES (EDUCACIONAIS)	
Integralidade do Cuidado I	1º	Prática Profissional Simulada 1	
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 1	
	2º	Prática Profissional Simulada 2	FPS 1
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 2	
Integralidade do Cuidado II	3º	Prática Profissional Simulada 3	FPS 2
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 3	
	4º	Prática Profissional Simulada 4	FPS 3
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 4	
Integralidade do Cuidado III	5º	Prática Profissional Simulada 5	FPS 4
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 5	
	6º	Prática Profissional Simulada 6	FPS 5
		Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho 6	

FPS: Formação Profissional Simulada

Fonte: Autoria própria

7.4 Percursos curriculares

A organização dos Percursos Curriculares, segundo ciclos educacionais e cenários de aprendizagem, busca explorar o melhor desenvolvimento de capacidades para a construção de competência do futuro profissional médico. O currículo está estruturado em seis séries anuais, segundo três percursos curriculares obrigatórios: (i) Prática Profissional Simulada; (ii) Percurso da Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho; e (iii) Percurso da Formação Profissional Singular

7.4.1 Percurso prática profissional simulada

O Percurso da Prática Profissional Simulada tem por objetivo promover o desenvolvimento de capacidades nas três áreas de competência do perfil em cenários simulados. A aprendizagem ocorre em ambiente protegido na UFCAT, com professores no papel de facilitadores, utilizando disparadores simulados para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Ao criar as simulações, pode-se combinar diversos elementos para enriquecer a experiência de aprendizado como casos clínicos complexos que raramente ocorreriam simultaneamente em pacientes reais. Essa abordagem permite que os estudantes sejam expostos a uma variedade de desafios e desenvolvam habilidades de solução de problemas de forma mais abrangente, oferecendo uma oportunidade para conectar o aprendizado com o mundo do trabalho.

O Percurso da Prática Profissional Simulada é desenvolvido por meio de três módulos que utilizam metodologias de ensino-aprendizagem específicas:

(i) Necessidades de Saúde e Planos Terapêuticos Aplicados

(ii) Habilidades Clínicas

(iii) Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e Cuidado

7.4.2 Percurso da prática profissional em contexto real do trabalho

O Percurso da Prática Profissional em Contexto Real do Trabalho tem por objetivo promover o desenvolvimento de capacidades nas três áreas de competência do perfil em cenários reais da prática profissional, no contexto do SUS. Esses cenários contemplam serviços de saúde nos âmbitos da atenção primária e atenção especializada ambulatorial e hospitalar. A aprendizagem tem como elementos disparadores o confronto experiencial direto com a realidade e a interpretação desse confronto na perspectiva dos estudantes. Os estudantes são acompanhados por docentes da UFCAT, preceptores e pela equipe do serviço no qual os mesmos estão inseridos, visando garantir uma vivência segura aos estudantes e às pessoas/famílias vinculadas a esses equipamentos de saúde.

O Percurso Teórico Prático Real é desenvolvido por meio de dois módulos que utilizam metodologias de ensino-aprendizagem específicas:

(i) Atenção à Saúde na Prática Comunitária

(ii) atividades complementares

7.4.3 Percurso da formação profissional singular

O Percurso da formação profissional singular tem por objetivo possibilitar ao estudante inserir sua perspectiva na construção do currículo e na aquisição das competências, sendo organizado conforme suas necessidades de aprendizagem e interesses.

O PFPS é desenvolvido por meio de Atividades Eletivas, Atividades Complementares (AC) e Núcleo Livre (NL), distribuídas em períodos letivos pré-estabelecidos, do primeiro (ou segundo) ao sexto anos do currículo, tanto nos cenários simulados e como nos cenários reais da prática profissional.

(i) Atividades Complementares: são atividades acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas pelo estudante durante o período em que esteja vinculado a um curso de educação superior, excetuando-se componentes curriculares. Compreendem a participação em monitorias, tutorias, pesquisas, projetos de extensão e cultura, estágio não obrigatório, conferências, seminários, palestras, congressos, debates e outras atividades científicas, artísticas, culturais, de saúde e qualidade de vida.

(ii) Núcleo Livre: é o conjunto de conteúdos que têm por objetivo: I- ampliar e diversificar a formação do estudante; II- promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; III- possibilitar o aprofundamento de estudo em áreas de interesse do estudante; IV- viabilizar o intercâmbio entre estudantes de diferentes cursos da UFCAT. Será ministrado em componentes curriculares criados para esse fim ou por meio de liberação de vagas em turmas de componentes obrigatórios ou optativos.

(iii) Nas atividades eletivas, o estudante elabora um plano educacional a partir de suas necessidades educacionais, podendo desenvolvê-lo dentro da faculdade, nos laboratórios da instituição ou fora da universidade, em cenários de prática real do trabalho em saúde, da vida em sociedade e do meio ambiente. Poderão focalizar as áreas de saúde, gestão e educação. A elaboração desses planos de ensino deve ser pactuada e acompanhada pelo respectivo docente orientador(a) e deverão ter um profissional ou equipe de saúde reconhecidas pelo Curso de Medicina que se comprometam pelo acompanhamento e avaliação do estudante em período pré-estabelecido.

7.4.4 Carga horária dos percursos curriculares

A carga horária (CH do Curso de Medicina) perfaz 7584 horas, distribuídas nos percursos indicados no quadro 14.

Quadro 14 - Carga horária dos percursos organizadores por período, Curso Medicina UFCAT

Período	PRÁTICA PROFISSIONAL SIMULADA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL SINGULAR	PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONTEXTO REAL DE TRABALHO	PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONTEXTO REAL DE TRABALHO (estágio)	Carga horária
1 período	320h	80h	128h	0	528
2 período	320h	80h	128h	0	528
3 período	320h	80h	128h	0	528
4 período	320h	80h	128h	0	528
5 período	192h	96h	320h	0	608
6 período	192h	96h	320h	0	608
7 período	192h	96h	320h	0	608
8 período	192h	96h	320h	0	608
9 período	0	0	0	640h	640
10 período	0	0	0	816h	816
11 período	0	0	0	640h	640
12 período	0	0	0	816h	816
Núcleo livre	-	128h	-	-	128
Total (horas)	2048	832	1792	2912	7584
%	27,00%	10,97%	23,63%	38,4%	

Fonte: Autoria própria

Da carga horária total, 2048h (27%) é destinado ao eixo PRÁTICA PROFISSIONAL SIMULADA, que ocorre em ambiente protegido, do primeiro ao oitavo períodos, 1792 horas (23,63%) é destinado ao eixo PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONTEXTO REAL DE TRABALHO do primeiro ao oitavo períodos, em campos de prática no Sistema Único de Saúde, 2912h (38,4%) é destinado ao eixo PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONTEXTO REAL DE TRABALHO no estágio obrigatório, e 896 horas (10,97%) é destinado ao percurso FORMAÇÃO PROFISSIONAL SINGULAR, que inclui tanto o núcleo livre tanto as atividades complementares.

Quadro 15 - Carga horária do curso por componente curricular/ percurso e semestre letivo

período	percurso	Componente curricular	carga
---------	----------	-----------------------	-------

			horária
1	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 1	128h
1	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 1	128h
1	PPS	Habilidade Clínica 1	64h
1	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 1	128h
2	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 2	128h
2	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 2	128h
2	PPS	Habilidade Clínica 2	64h
2	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 2	128h
1 E 2	FPS	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	160h
3	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 3	128h
3	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 3	128h
3	PPS	Habilidade Clínica 3	64h
3	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 3	128h
4	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 4	128h
4	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 4	128h
4	PPS	Habilidade Clínica 4	64h
4	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 4	128h
3 e 4	FPS	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	160h
5	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 5	64h
5	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 5	64h
5	PPS	Habilidade Clínica 5	64h
5	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 5	320h
6	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 6	64h
6	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 6	64h
6	PPS	Habilidade Clínica 6	64h
6	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 6	320h
5 e 6	FPS	ATIVIDADES “COMPLEMENTARES”	192h
7	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 7	64h
7	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 7	64h
7	PPS	Habilidade Clínica 7	64h
7	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 7	320h
8	PPS	Necessidades de saúde Planos terapêuticos Aplicados 8	64h
8	PPS	Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e cuidado 8	64h
8	PPS	Habilidade Clínica 8	64h
8	PPCRT	Atenção à saúde na Prática Comunitária 8	320h
7 e 8	FPS	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	192h
9	PPCRT	Estágio obrigatório Atenção Básica 1	320h
9	PPCRT	Estágio Obrigatório Urgência e Emergência 1	320h
10	PPCRT	Estágio Obrigatório Saúde da Mulher 1	192h
10	PPCRT	Estágio Obrigatório Saúde do Adulto e Idoso 1	192h
10	PPCRT	Estágio obrigatório Saúde da Criança 1	192h
10	PPCRT	Estágio Obrigatório - Optativo 1	240h
11	PPCRT	Estágio obrigatório Atenção Básica 2	320h
11	PPCRT	Estágio Obrigatório Urgência e Emergência 2	320h
12	PPCRT	Estágio Obrigatório Saúde da Mulher 2	192h
12	PPCRT	Estágio Obrigatório Saúde do Adulto e Idoso 2	192h
12	PPCRT	Estágio obrigatório Saúde da Criança 2	192h
12	PPCRT	Estágio Obrigatório - Optativo 2	240h
	FPS	Núcleos Livres	128h

FPS = FORMAÇÃO PROFISSIONAL SINGULAR PFS - PRÁTICA PROFISSIONAL SIMULADA; PPCRT - PRÁTICA PROFISSIONAL EM CONTEXTO REAL DE TRABALHO

Fonte: Autoria própria

Quadro 16- Carga horária por percurso e por período

período	prática	formação	prática profissional	prática profissional	carga horária total
---------	---------	----------	----------------------	----------------------	---------------------

	profissional simulada	profissional singular	em contexto real de trabalho	em contexto real de trabalho	
1 período	320	80	128	0	528
2 período	320	80	128	0	528
3 período	320	80	128	0	528
4 período	320	80	128	0	528
5 período	192	96	320	0	608
6 período	192	96	320	0	608
7 período	192	96	320	0	608
8 período	192	96	320	0	608
9 período	0	0	0	640	640
10 período	0	0	0	816	816
11 período	0	0	0	640	640
12 período	0	0	0	816	816
Núcleo livre		128			
total(horas)	2048	832	1792	2912	7584

Fonte: Autoria própria, 2024

7.5 CICLOS CURRICULARES

Os três ciclos de aprendizagem, chamados de Ciclos Curriculares, compreendem dois anos destinados ao desenvolvimento de um determinado conjunto de capacidades, nas três áreas de competência. O conjunto de capacidades de cada ciclo foi estabelecido segundo o grau de autonomia e responsabilidade dos estudantes para intervirem na realidade, com o acompanhamento de equipes de saúde e de docentes.

O Ciclo I (1º e 2º anos) é predominantemente desenvolvido na atenção primária, também chamada de atenção básica. O Ciclo Educacional II (3º e 4º anos) aporta módulos curriculares desenvolvidos tanto na atenção primária como especializada. O Ciclo III (5º e 6º anos) deve ser desenvolvido na atenção básica, na atenção especializada ambulatorial e hospitalar e na urgência e emergência e na saúde mental.

7.6 Módulos Curriculares - MC

A matriz curricular apresenta a composição por módulos, priorizando uma organização multidisciplinar, vinculada aos eixos organizadores. A integração visa o olhar ampliado sobre o processo saúde–doecimento–cuidado e implica em uma reação a mera superposição de conhecimentos sem correlação com a realidade e as reais necessidades de saúde da população. Enquanto o cenário de aprendizagem determina os eixos organizadores, a estratégia educacional e a ênfase definem o foco e a abordagem dos conteúdos nos módulos curriculares.

7.6.1 Módulo Necessidades de Saúde e Planos Terapêuticos Aplicados (NSPTA) – 1º ao 8º períodos

Esse módulo envolve o processamento de situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS. Permite o desenvolvimento de aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores, considerando o perfil de competência esperado para a série na qual o estudante se encontra.

O trabalho dos docentes e estudantes focaliza: (i) o conceitos de necessidades de saúde; (ii) as dimensões do processo saúde-adoecimento-cuidado; (iii) processos biológicos normais e alterados; (iv) processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento-cuidado; (v) os processos comportamentais/psicológicos normais e alterados; (vi) os processos de cuidado no contexto do SUS; (vii) processos educacionais por meio de metodologias ativas e (viii) o desenvolvimento de capacidades para busca e análise de informações em bases bibliográficas e de acesso remoto.

7.6.2 Módulo Habilidades Clínicas (HC) – 1º ao 8º

Esse módulo é desenvolvido a partir de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados. São utilizados atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem pacientes.

Permite o desenvolvimento de aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames complementares.

Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, considerando especificidades de gênero, raça, faixa etária, etc, assim como perfil de competência esperado para a série na qual o estudante se encontra.

7.6.3 Módulo Ciência, Tecnologias em Saúde, Adoecimento e Cuidado – 1º ao 8º

Esse módulo permite que os estudantes tenham contato com as contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado em suas dimensões biológica, psicológica, social e cultural relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde.

São utilizadas situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida como disparadores para o processo ensino-aprendizagem. São considerados as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência dos estudantes para selecionar e explorar aspectos cognitivos, psicomotores e atitudinais que fundamentam a medicina.

O trabalho dos docentes e estudantes focaliza: (i) aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança; (ii) as inovações no cuidado à saúde das pessoas; (iii) a gestão do trabalho em saúde; (iii) as melhores práticas no cuidado à saúde das pessoas e na gestão da clínica; (iv) processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas.

7.6.4 Módulo Atenção à Saúde na Prática Comunitária (A.S.P.C) 1º ao 4º

Esse módulo é desenvolvido à partir de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado, o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores

e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

7.6.5 Módulo Atenção à Saúde na Prática Comunitária (A.S.P.C) 5º ao -8º

Execução de atividades vinculadas à formação do estudante, envolvendo diretamente as comunidades externas à UFCAT, a população dos territórios de saúde vinculados ao curso, em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre o curso e a UFCAT com outros setores da sociedade, pela produção e a aplicação do conhecimento, articuladas com o ensino e a pesquisa. Ações de saúde coletiva e individual.

7.6.6 Atividades complementares e eletivas

As Atividades Complementares (AC) constituem-se em atividades que enriquecem e complementam o perfil do(a) formando(a), estimulando a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e de interdisciplinaridade, de caráter obrigatório que visam valorizar a formação do estudante em diferentes contextos de aprendizagem. Compreendem monitorias, pesquisas, projetos de extensão e cultura, conferências, seminários, palestras, congressos, debates e outras atividades científicas, artísticas e culturais, à exceção do estágio não obrigatório.

Estas atividades acadêmicas devem ser escolhidas e desenvolvidas pelos estudantes durante o período disponível para integralização curricular, realizadas a partir do 1º semestre do Curso de Medicina, de acordo com as orientações das DNC 2014, (ARTIGO 25) e RGCG/UFG distribuídas ao longo do curso.

Atendendo ao RGCG vigente (resolução CEPEC 1557/2017 de 1/12/2017), a carga horária mínima obrigatória é de 100 horas, sendo de responsabilidade do(s) estudante(s), a guarda dos documentos comprobatórios de sua efetivação para posterior validação junto à coordenação do curso.

O estudante deve desenvolver atividades em cada uma das áreas (grupo) de ensino, pesquisa e extensão.

Os comprovantes dessas atividades devem ser encaminhados pelos estudantes pela via SIGAA (Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas), por meio de sua senha pessoal, ao Coordenador de Curso. Esse procedimento pode ser realizado ao longo de todo o curso de Graduação, para que haja tempo hábil para sua homologação conforme calendário acadêmico.

Após a sistematização das informações acadêmicas, é responsabilidade do estudante, por meio de senha pessoal, incluir as AC no sistema e encaminhá-las para validação pelo Coordenador de Curso.

O total de horas complementares das eletivas será de 704 horas.

7.6.7 Atividades Curriculares do Internato

As atividades curriculares do Internato consistirão dos estágios: Urgência e Emergência, Atenção Básica, Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher e Estágio Eletivo.

O estágio obrigatório será a atividade realizada majoritariamente em campo prático, com no máximo 20% de carga teórica, supervisionada por preceptores da rede, docentes ou não, nas áreas previstas pelas Diretrizes curriculares Nacionais, nas áreas de Atenção Básica, Urgência e emergência, Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental.

7.6.8 Requisitos legais e normativos obrigatórios

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina (2014) apontam, no artigo 23, item VII que “Os conteúdos fundamentais para o Curso de Graduação em Medicina devem estar relacionados com todo o processo saúde do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em saúde, contemplando:”... “VII- abordagem de temas transversais no currículo que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos humanos e de pessoas com deficiência, educação ambiental, ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais), educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena”

Com respeito ao ensino de libras, ela está disponível na matriz curricular e é oferecida como núcleo livre a todos os estudantes da UFCAT, inclusive os do curso de Medicina.

Com respeito às questões étnico-raciais e históricas da cultura afro-brasileira e indígena, educação em direitos humanos e de pessoas com deficiência e educação ambiental elas serão abordado de modo transversal dentro dos módulos NECESSIDADES DE SAÚDE E PLANOS TERAPÊUTICOS APLICADOS e ATENÇÃO À SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA, no primeiro caso, pela inserção de contexto que provoque o disparador específico para provocar a discussão entre os estudantes, e no segundo componente curricular por ser elemento presente na realidade que os docentes deste módulo provocarão os estudantes a aprofundar e compreender.

A questão dos direitos da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista ele será objeto de discussão nos casos específicos que exploram os problemas de desenvolvimento nos casos de NECESSIDADES DE SAÚDE E PLANOS TERAPÊUTICOS APLICADOS 5 e 6, bem como nas reflexões de prática de ATENÇÃO À SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA.

A questão das Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos e as discussões sobre as condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, ela será abordada de forma transversal em todos os módulos, especialmente nos módulos onde as discussões envolvem a compreensão de contexto e a construção de planos de cuidado, no caso NECESSIDADES DE SAÚDE E PLANOS TERAPÊUTICOS APLICADOS, ATENÇÃO À SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA e HABILIDADES CLÍNICAS.

A questão da política de educação ambiental será abordada de forma transversal nos módulos NECESSIDADES DE SAÚDE E PLANOS TERAPÊUTICOS APLICADOS, ATENÇÃO À SAÚDE NA PRÁTICA COMUNITÁRIA no caso, como contexto dos determinantes de saúde.

7.6.9 Carga Horária das Atividades Curriculares - Ementas

PRIMEIRO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 1

Código - IBT0766

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-adoecimento-cuidado e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento-cuidado, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas, com foco na prevenção e promoção de saúde.

Carga horária – 128h

Carga horária teórica – 128h

Carga horária prática – 0h

Bibliografia Básica

GUYTON, A.C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1145 p.

LEHNINGER, Albert L. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.

DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

Bibliografia Complementar

GRIFFITHS, Anthony J. F et al. **Introdução à genética**. Tradução de Paulo Armando Motta. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 754 p.

JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. – **Histologia Básica – Texto e Atlas**. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2018. 538 p.

MOORE, Keith L. **Embriologia clínica**. 10. ed Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2016, 540 p.

BAYNES, John W. **Bioquímica médica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xvii, 653 p.

SOBOTTA, J. **Atlas de anatomia humana**. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2006.

Componente curricular - Habilidades clínicas 1

Código - IBT0767

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para

representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de Exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;
BICLEY, SL. BATES PROPEDEUTICA MÉDICA. Editora Guanabara Koogan. 11 ed. 2015;
LOPES, M; LAURENTYS-MEDEIROS. Semiologia Médica: As Bases do Diagnóstico Clínico, 5 ED, 2015.

Bibliografia Complementar

DUTRA, ADALTO. SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA. 2 EDIÇÃO, EDITORA RÚBIO, 2022;
Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;
Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;
Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;
MONTENEGRO, CAB; REZENDE FILHO, J. REZENDE OBSTETRÍCIA. Editora Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 1

Código - IBT0803

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado, o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes comunitários de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. **Manual de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed. 2010.
ROCHA, J. J. Y. **Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil**. Ed. Atheneu. 2012.
SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. **Propedêutica Médica**. Ed. Guanabara Koogan. 2010
VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. **A problematização em educação**
CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em:
<https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilancia>. Acessado em 09 de abril de 2023.
HADDAD; NAGIB. **Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde**. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 1

Código - IBT0804

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais e da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 64h

Bibliografia Básica

GUYTON, A. C; HALL, J. E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 14 ed. Elsevier, 2021.
POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho**. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.
MOORE; DALLEY; AGUR. - **Anatomia Orientada para a Clínica**. 7a ed. Guanabara Koogan. 2017.

Bibliografia Complementar

PAWLINA, W. Ross **Histologia Texto e Atlas – Correlações com biologia celular e molecular**. 7ª ed. Guanabara Koogan. 2017.
MOORE, K. L. - **Embriologia básica**. 9 ed. Elsevier. 2016
NUSSBAUM, R. L., McINNES, R. R., WILLARD, H. F. Thompson & Thompson **Genética Médica**. 8ª ed. Elsevier. 2016.
HALL, Susan J. **Biomecânica Básica**. Rio de Janeiro. 8. Ed Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2020.
JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. **Biologia Celular e Molecular**. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2019.

SEGUNDO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 2

Código - IBT0768

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-adoecimento-cuidado, as alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 128h

Carga horária prática – 0h

Bibliografia Básica

1. GUYTON, A.C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1145 p.
2. LEHNINGER, Albert L. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.
3. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

Bibliografia Complementar

1. GRIFFITHS, Anthony J. F et al. **Introdução à genética**. Tradução de Paulo Armando Motta. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 754 p.
2. JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. – **Histologia Básica – Texto e Atlas**. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2018. 538 p.
3. MOORE, Keith L. **Embriologia clínica**. 10. ed Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2016, 540 p.
4. BAYNES, John W. **Bioquímica médica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xvii, 653 p.
5. SOBOTTA, J. **Atlas de anatomia humana**. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2006.

Componente curricular - Habilidades clínicas 2

Código - IBT0769

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;
BICLEY, SL. BATES PROPEDEUTICA MÉDICA. Editora Guanabara Koogan. 11 ed. 2015;
LOPES, M; LAURENTYS-MEDEIROS. Semiologia Médica: As Bases do Diagnóstico Clínico, 5 ED, 2015.

Bibliografia Complementar

DUTRA, ADALTO. SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA. 2 EDIÇÃO, EDITORA RÚBIO, 2022;
Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;
Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;
Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;
MONTENEGRO, CAB; REZENDE FILHO, J. REZENDE OBSTETRÍCIA. Editora Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 2

Código - IBT0770

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 128h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.
ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. Manual de Medicina de Família e Comunidade. Artmed. 2010.
ROCHA, J. J. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Ed. Atheneu.2012.
SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. Propedêutica Médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010
VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. A problematização em educação CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilancia>. Acessado em 09 de abril de 2023.

HADDAD; NAGIB. Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 2

Código - IBT0771

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 64h

Bibliografia Básica

GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Medica. 14 ed. Elsevier, 2021.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

MOORE; DALLEY; AGUR. - Anatomia Orientada para a Clínica. 7a ed. Guanabara Koogan. 2017.

Bibliografia Complementar

PAWLINA, W. Ross Histologia Texto e Atlas – Correlações com biologia celular e molecular. 7ª ed. Guanabara Koogan. 2017.

MOORE, K. L. - Embriologia básica. 9 ed. Elsevier. 2016

NUSSBAUM, R. L., McINNES, R. R., WILLARD, H. F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª ed. Elsevier. 2016.

HALL, Susan J. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro. 8. Ed Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2020.

JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2019.

TERCEIRO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 3

Código - IBT0773

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos

normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 128h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

1. GUYTON, A.C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1145 p.
2. LEHNINGER, Albert L. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.
3. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

Bibliografia Complementar

1. GRIFFITHS, Anthony J. F et al. **Introdução à genética**. Tradução de Paulo Armando Motta. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 754 p.
2. JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. – **Histologia Básica – Texto e Atlas**. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2018. 538 p.
3. MOORE, Keith L. **Embriologia clínica**. 10. ed Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2016, 540 p.
4. BAYNES, John W. **Bioquímica médica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xvii, 653 p.
5. SOBOTTA, J. **Atlas de anatomia humana**. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1 e 2, 2006.

Componente curricular - Habilidades clínicas 3

Código - IBT0774

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

- PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;
- 2- DUTRA, ADALTO. SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA. 2 EDIÇÃO, EDITORA RÚBIO, 2022;
 - 3- LOPES, M; LAURENTYS-MEDEIROS. Semiologia Médica: As Bases do Diagnóstico Clínico, 5 ED, 2015.

Bibliografia Complementar

- BICLEY, SL. BATES PROPEDEUTICA MÉDICA. Editora Guanabara Koogan. 11 ed. 2015;
2- Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;
3- Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;
4- Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas à saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;
5- MONTENEGRO, CAB; REZENDE FILHO, J. REZENDE OBSTETRÍCIA. Editora Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 3

Código - IBT0775

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 128h

Bibliografia Básica

- CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.
ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

- MCWHINNEY, I. R. Manual de Medicina de Família e Comunidade. Artmed. 2010.
ROCHA, J. J. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Ed. Atheneu.2012.
SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. Propedêutica Médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010
VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. A problematização em educação CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilância>. Acessado em 09 de abril de 2023.
HADDAD; NAGIB. Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 3

Código - IBT0776

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e

biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 64h

Bibliografia Básica

GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 14 ed. Elsevier, 2021.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

MOORE; DALLEY; AGUR. - Anatomia Orientada para a Clínica. 7a ed. Guanabara Koogan. 2017.

Bibliografia Complementar

PAWLINA, W. Ross Histologia Texto e Atlas – Correlações com biologia celular e molecular. 7ª ed. Guanabara Koogan. 2017.

MOORE, K. L. - Embriologia básica. 9 ed. Elsevier. 2016

NUSSBAUM, R. L., McINNES, R. R., WILLARD, H. F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª ed. Elsevier. 2016.

HALL, Susan J. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro. 8. Ed Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2020.

JUNQUEIRA, I. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 13ª ed. Guanabara Koogan. 2019.

QUARTO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 4

Código - IBT0778

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 128h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

DBEHRMAN, R. E. Nelson. **Tratado de Pediatria**. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.

MONTENEGRO, CAB, REZENDE FILHO, J. REZENDE. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de medicina de família e comunidade**. Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

DUTRA, ADALTO. **Semiologia Pediátrica**. 2.ed. Editora Rúbio, 2022.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício**: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

GRIFFITHS, A. J. F. **Introdução à genética**. 11 ed. Guanabara Koogan. 2016.

KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica & clínica**. 13 ed. Guanabara Koogan. 2017

Componente curricular - Habilidades clínicas 4

Código - IBT0779

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

2- DUTRA, ADALTO. **SEMILOGIA PEDIÁTRICA**. 2 EDIÇÃO, EDITORA RÚBIO, 2022;

3- LOPES, M; LAURENTYS-MEDEIROS. **Semiologia Médica: As Bases do Diagnóstico Clínico**, 5 ED, 2015.

Bibliografia Complementar

BICLEY, SL. **BATES PROPEDEUTICA MÉDICA**. Editora Guanabara Koogan. 11 ed. 2015;

2- Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;

3- Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;

4- Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;

5- POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem**: adaptado à realidade brasileira. Elsevier. Tradução da 8ª edição, 2015.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 4

Código - IBT0780

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de

competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 320h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 320h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. Manual de Medicina de Família e Comunidade. Artmed. 2010.

ROCHA, J. J. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Ed. Atheneu.2012.

SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. Propedêutica Médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010

VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. A problematização em educação CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilancia>. Acessado em 09 de abril de 2023.

HADDAD; NAGIB. Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 4

Código - IBT0781

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 128h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 64h

Bibliografia Básica

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia Geral. Ed Guanabara Koogan. 2018

MURRAY, PR. ROSENTHAL, KS, PFALLER, M.A. Microbiologia Médica. Ed. Elsevier, 2015.

ROBBINS & COTRAN. Bases Patológicas das Doenças. Ed. Guanabara Koogan. 2016.

Bibliografia Complementar

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010.

ABBAS, ABUL K.; LICHTMAN, ANDREW H. Imunologia Básica: Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. Ed. Elsevier. 2013.

RANCO, M. MONTENEGRO, MR. DE BRITO, T. BACCHI, CE. DE ALMEIDA, PC. Patologia Processos Gerais. Ed Atheneu, 2015.
ALTERTHUM, F. (Coord.). Microbiologia. Ed. Atheneu, 2008.
TEIXEIRA, P., and VALLE, S., orgs. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar [online]. 2nd ed. rev. and enl. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010. 442 p

QUINTO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 5

Código - IBT0783

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde, **no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação.**

Carga horária - 64h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

DBEHRMAN, R. E. Nelson. **Tratado de Pediatria**. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.
MONTENEGRO, CAB, REZENDE FILHO, J. REZENDE. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de medicina de família e comunidade**. Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
DUTRA, ADALTO. **Semiologia Pediátrica**. 2.ed. Editora Rúbio, 2022.
POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício**: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.
GRIFFITHS, A. J. F. **Introdução à genética**. 11 ed. Guanabara Koogan. 2016.
KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica & clínica**. 13 ed. Guanabara Koogan. 2017.

Componente curricular - Habilidades clínicas 5

Código - IBT0784

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de

gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

GUSSO, G.; LOPES, J.M.C.; DIAS, C. L. - **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. 2. ed. Ed. Artmed. 2019.

JAMESON, J. L. et al. **Harrison's Principles of Internal Medicine**. 20. Ed. McGraw Hill 2018

NELSON, W. E et al. **Nelson Tratado de Pediatria**. 21ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020

Bibliografia Complementar

DUTRA, A. **Semiologia Pediátrica**. 2 Ed. Rubio. Rio de Janeiro: 2010.

Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;

Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;

Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem**: adaptado à realidade brasileira. Elsevier. Tradução da 8ª edição, 2015.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 5

Código - IBT0785

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 320h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 320h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. **Manual de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed. 2010.

ROCHA, J. J. Y. **Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil**. Ed. Atheneu. 2012.

SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. **Propedêutica Médica**. Ed. Guanabara Koogan. 2010.

VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. **A problematização em educação CONASS.** Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/> vigilância. Acessado em 09 de abril de 2023.
HADDAD; NAGIB. **Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde.** Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 5

Código - IBT0786

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica - 32h

Carga horária prática- 32h

Bibliografia Básica

- 1- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. -Tratado de fisiologia médica. Ed. Guanabara . 13 ed. Ed. Guanabara Koogan, 2017.
- 2- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada 7º Ed. Artmed, Porto Alegre, 2017.
- 3- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2016.

Bibliografia Complementar

BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2019. 1738 p.

SOBEL, J.; YOUNG, B.; ACOSTA, F. D. Goldman-Cecil Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021

LEHNINGER, Albert L. Princípios de bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278p

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Surgical Site Infection (SSI) Prevention. Atlanta: CDC, 2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/ssi/index.html>. Acesso em: 27 mar. 2023.

SEXTO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 6

Código - IBT0788

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde, **tratamento e reabilitação**.

Carga horária - 64h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

DBEHRMAN, R. E. Nelson. **Tratado de Pediatria**. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.
MONTENEGRO, CAB, REZENDE FILHO, J. REZENDE. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de medicina de família e comunidade**. Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

DUTRA, ADALTO. **Semiologia Pediátrica**. 2.ed. Editora Rúbio, 2022.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho**. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

GRIFFITHS, A. J. F. **Introdução à genética**. 11 ed. Guanabara Koogan. 2016.

KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica & clínica**. 13 ed. Guanabara Koogan. 2017.

Componente curricular - Habilidades clínicas 6

Código - IBT0789

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

GUSSO, G.; LOPES, J.M.C.; DIAS, C. L. - **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. 2. ed. Ed. Artmed. 2019.

JAMESON, J. L. et al. **Harrison's Principles of Internal Medicine**. 20. Ed. McGraw Hill 2018
NELSON, W. E et al. **Nelson Tratado de Pediatria**. 21ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020

Bibliografia Complementar

DUTRA, A. *Semiologia Pediátrica*. 2 Ed. Rubio. Rio de Janeiro: 2010.
Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;
Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;
Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4ª edição, CFM Brasília, 2018;
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. *Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem*: adaptado à realidade brasileira. Elsevier. Tradução da 8ª edição, 2015.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 6

Código - IBT0790

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 320h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 320h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.
ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. *Manual de Medicina de Família e Comunidade*. Artmed. 2010.
ROCHA, J. J. Y. *Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil*. Ed. Atheneu. 2012.
SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. *Propedêutica Médica*. Ed. Guanabara Koogan. 2010
VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. *A problematização em educação CONASS*. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilância>. Acessado em 09 de abril de 2023.
HADDAD; NAGIB. *Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde*. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 6

Código - IBT0791

Ementa - Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que

embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica - 32h

Carga horária prática- 32h

Bibliografia Básica

- 1- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. -Tratado de fisiologia médica. Ed. Guanabara . 13 ed. Ed. Guanabara Koogan, 2017.
- 2- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada 7º Ed. Artmed, Porto Alegre, 2017.
- 3- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2016.

Bibliografia Complementar

- BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2019. 1738 p.
- SOBEL, J.; YOUNG, B.; ACOSTA, F. D. Goldman-Cecil Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021
- LEHNINGER, Albert L. Princípios de bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.
- CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Surgical Site Infection (SSI) Prevention. Atlanta: CDC, 2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/ssi/index.html>. Acesso em: 27 mar. 2023.

SÉTIMO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 7

Código - IBT0793

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde, **tratamento e reabilitação**.

Carga horária - 64h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

DBEHRMAN, R. E. Nelson. **Tratado de Pediatria**. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.
MONTENEGRO, CAB, REZENDE FILHO, J. REZENDE. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de medicina de família e comunidade**. Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

DUTRA, ADALTO. **Semiologia Pediátrica**. 2.ed. Editora Rúbio, 2022.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício**: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

GRIFFITHS, A. J. F. **Introdução à genética**. 11 ed. Guanabara Koogan. 2016.

KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica & clínica**. 13 ed. Guanabara Koogan. 2017.

Componente curricular - Habilidades clínicas 7

Código - IBT0794

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

GUSSO, G.; LOPES, J.M.C.; DIAS. C. L. - **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. 2. ed. Ed. Artmed. 2019.

JAMESON, J. L. et al. **Harrison's Principles of Internal Medicine**. 20. Ed. McGraw Hill 2018

NELSON, W. E et al. **Nelson Tratado de Pediatria**. 21^a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020

Bibliografia Complementar

DUTRA, A. **Semiologia Pediátrica**. 2 Ed. Rubio. Rio de Janeiro: 2010.

Código de Ética Médica – Resolução do CFM Nº 1.931/2009;

Código de Ética do Estudante de Medicina – Conselho Federal de Medicina – Brasília –DF:CFM, 2018;

Diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas a saúde envolvendo seres humanos - 4^a edição, CFM Brasília, 2018;

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem**: adaptado à realidade brasileira. Elsevier. Tradução da 8^a edição, 2015.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 7

Código - IBT0795

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária - 320h

Carga horária teórica - 0h

Carga horária prática – 320h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. Manual de Medicina de Família e Comunidade. Artmed. 2010.

ROCHA, J. J. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Ed. Atheneu.2012.

SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. Propedêutica Médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010

VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. A problematização em educação CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilancia>. Acessado em 09 de abril de 2023.

HADDAD; NAGIB. Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 7

Código - IBT0796

Ementa- Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica - 32h

Carga horária prática- 32h

Bibliografia Básica

1- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. -Tratado de fisiologia médica. Ed. Guanabara. 13 ed. Ed.

Guanabara Koogan, 2017.

2- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada 7º Ed. Artmed, Porto Alegre, 2017.

3- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2016.

Bibliografia Complementar

BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2019. 1738 p.

SOBEL, J.; YOUNG, B.; ACOSTA, F. D. Goldman-Cecil Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021

LEHNINGER, Albert L. Princípios de bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Surgical Site Infection (SSI) Prevention. Atlanta: CDC, 2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/ssi/index.html>. Acesso em: 27 mar. 2023.

OITAVO PERÍODO

Componente curricular - Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados 8

Código - IBT0793

Ementa - Explorar situações-problema prevalentes da prática médica no contexto do SUS em seus aspectos cognitivos, atitudinais e psicomotores das situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida e o perfil de competência do estudante, com foco nos conceitos de necessidades de saúde, as dimensões do processo saúde-doença e alternativas de cuidado, processos biológicos normais e alterados, processos sociais, culturais, históricos, laborais, ecológicos/ambientais, éticos e legais vinculados ao processo saúde-adoecimento, ainda aos processos comportamentais/psicológicos normais e alterados e os processos de cuidado no contexto do SUS; processos educacionais por meio de metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde, **tratamento e reabilitação**.

Carga horária - 64h

Carga horária teórica - 64h

Carga horária prática - 0h

Bibliografia Básica

DBEHRMAN, R. E. Nelson. **Tratado de Pediatria**. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.
MONTENEGRO, CAB, REZENDE FILHO, J. REZENDE. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de medicina de família e comunidade**. Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO. **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

DUTRA, ADALTO. **Semiologia Pediátrica**. 2.ed. Editora Rúbio, 2022.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do Exercício**: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. São Paulo: Manole, 2014.

GRIFFITHS, A. J. F. **Introdução à genética**. 11 ed. Guanabara Koogan. 2016.

KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica & clínica**. 13 ed. Guanabara Koogan. 2017.

Componente curricular - Habilidades clínicas 8

Código - IBT0794

Ementa - Realização de simulações realísticas de procedimentos de saúde e atendimentos médicos em cenários simulados com o uso de atores e/ou outros recursos tecnológicos e pedagógicos para representarem situações de pacientes, explorando o desenvolvimento de conteúdos cognitivos, atitudinais e psicomotores que fundamentam a prática clínica e aplicação de políticas públicas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para o uso e análise de exames Complementares, segundo o perfil de competência do ciclo do estudante no curso. Os cenários de simulação serão elaborados conforme as situações prevalentes nos diferentes ciclos de vida, especificidades de gênero e o perfil de competência do estudante, no ciclo do curso. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 64h

Bibliografia Básica

MARGARIDO, N.F., Tolosa, E.M.C. Técnica Cirúrgica prática. 1ª Edição; Editora Atheneu, 2001.

BRAZ, J.R.C., Castiglia, Y.M.M. Temas de Anestesiologia. 2ª Edição; Editora Unesp, 2000.

MARQUES, R.G. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental. 1ª Edição; Guanabara Koogan, 2005.

Bibliografia Complementar

GOFFI, F. Bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da Cirurgia. 4ª Edição; Editora Atheneu, 2004.

SAAD Júnior, R. Tratado de Cirurgia do CBC. 3ª. Edição; Editora Atheneu, 2022.

UTIYAMA, E.M. Atualização em cirurgia geral, medicina de urgência e trauma. 12ª. Edição; Editora Manole, 2022.

JAMERSON. Medicina interna de Harrison. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021.

Componente curricular - Atenção à saúde na prática comunitária 8

Código - IBT0795

Ementa - Experimentação de vivências junto às equipes de saúde do município, da realidade da atenção ao cuidado e políticas públicas de saúde, explorando conhecimentos, atitudes e habilidades da prática médica no contexto do SUS, considerando a integralidade do cuidado e o perfil de competência do estudante e o ciclo educacional, contemplando observação do funcionamento de estabelecimentos e instituições, acompanhamento de agentes de saúde, ações em equipamentos sociais e de saúde do território e atendimentos clínicos sob supervisão de preceptores e/ou professores, na atenção primária à saúde em nível domiciliar e ambulatorial com foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 320h

Carga horária teórica – 0h

Carga horária prática – 320h

Bibliografia Básica

CAMPOS, G.W.S et al. **Tratado de saúde coletiva**. São Paulo. Hucitec, 2012.
GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.
ROUQUAYROL, MZ; SILVA MGC. **Epidemiologia e Saúde**, 8ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Bibliografia Complementar

MCWHINNEY, I. R. Manual de Medicina de Família e Comunidade. Artmed. 2010.
ROCHA, J. J. Y. Manual de saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Ed. Atheneu.2012.
SZILAGUI, P. G.; BICKLEY, L. S. Propedêutica Médica. Ed. Guanabara Koogan. 2010
VILLARDI, ML, CYRINO, EG, and BERBEL, NAN. A problematização em educação CONASS. Conselho Nacional dos Secretários da Saúde. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/vigilancia>. Acessado em 09 de abril de 2023.
HADDAD; NAGIB. Metodologia de Estudo em Ciências da Saúde. Ed. Roca. 2013.

Componente curricular - Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado 8

Código- IBT0796

Ementa- Abordagem das contribuições mais atuais da ciência e tecnologias em saúde, que embasam a compreensão do adoecimento e do cuidado, em suas dimensões biológica, psicológica e social relacionadas às situações de importância epidemiológica e comunitária, nos territórios de saúde, contemplando amplamente aspectos bioéticos, normativos-legais, bioestatística e biossegurança, envolvendo compreensão dos processos, da gestão do trabalho em saúde, as inovações no cuidado, a gestão da clínica através de processos educacionais através da aprendizagem colaborativa e ética por metodologias ativas. Foco na prevenção em saúde e promoção de saúde.

Carga horária – 64h

Carga horária teórica - 32h

Carga horária prática- 32h

Bibliografia Básica

1- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. -Tratado de fisiologia médica. Ed. Guanabara. 13 ed. Ed. Guanabara Koogan, 2017.
2- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada 7º Ed. Artmed, Porto Alegre, 2017.
3- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2016.

Bibliografia Complementar

BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2019. 1738 p.
SOBEL, J.; YOUNG, B.; ACOSTA, F. D. Goldman-Cecil Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021

LEHNINGER, Albert L. Princípios de bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2019. 1278 p.
CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Surgical Site Infection (SSI) Prevention. Atlanta: CDC, 2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/ssi/index.html>. Acesso em: 27 mar. 2023.

NONO PERÍODO

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Atenção Básica

Código- IBT0812

Ementa - O estágio curricular na atenção básica consiste na vivência das atividades clínicas feitas nas equipes de saúde da família dentro das rotinas que estas executam junto a suas populações adstritas. Contempla desde o diagnóstico situacional, o mapeamento da área, a construção e a manutenção do mapa inteligente da área, o trabalho de visitas domiciliares junto com o Agente Comunitário de Saúde, a Enfermeira e o Médico da Unidade, o acompanhamento e a execução sob supervisão dos atendimentos clínicos e procedimentos feitos na Unidade Básica de Saúde e no domicílio, acompanhamento e realização sob supervisão da triagem feita na unidade pela enfermeira. os trabalhos de vigilância epidemiológica, busca ativa, promoção, de saúde, prevenção de saúde e reabilitação realizados pela equipe, bem como acompanhamento das ações de matriciamento previstas. Saúde mental na atenção básica. Gestão. indicadores de qualidade do serviço.

Carga Horária- 320 horas práticas

Bibliografia Básica

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Artmed, 2018.
CAMPOS, GWS et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.
BARROSO, W. K. S., et al. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial** – 2020. Arq Bras Cardiol., v. 116, n. 3, pp: 516-658, 2021. Disponível em: https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-116-03-0516/0066-782X-abc-116-03-0516.x55156.pdf.

Bibliografia Complementar

ROUQUAYROL, M.E. Epidemiologia e Saúde. Medbook. 2012.
SÃO PAULO (Cidade). Secretaria da Saúde. Manual técnico: procedimento e legislação para risco biológico – Biossegurança na saúde nas Unidades Básicas de Saúde/Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo : SMS, 2014. 78 p.
BARROSO, W. K. S., et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol., v. 116, n. 3, pp: 516-658, 2021. Disponível em: https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-116-03-0516/0066-782X-abc-116-03-0516.x55156.pdf.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Urgência e Emergência

Código- IBT0813

Ementa - Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de urgência e emergência clínicos da área clínica, pediátrica, ortopédica, cirúrgica e de saúde mental. Discussão e acompanhamento da propedêutica indicada realizada na Unidade de Atendimento de Urgência e

Emergência onde esteja estagiando. Avaliação e discussão dos resultados de exames feitos nos pacientes atendidos. Acompanhamento clínico, e prescrição sequencial dos casos que for indicado permanecer em observação na unidade. Realização dos procedimentos indicados serem realizados ali. Discussão multiprofissional dos casos. Registro das discussões feitas no prontuário do paciente. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança em situações de emergência. Cuidados ao paciente agudamente crítico. Afogamento. Manobras de reanimação.

Carga horária - 320 horas práticas

Bibliografia Básica

BRANDÃO NETO, RA, Medicina de emergência: Abordagem Prática, EDITORA MANOLE, 2023

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

DBEHRMAN, R. E. Nelson tratado de pediatria. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017

JAMERSON. Medicina interna de Harrison. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

DÉCIMO PERÍODO

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde da Criança 1

Ementa - Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de crianças, adolescentes e neonatos em alojamento conjunto, enfermaria, ambulatório. Propedêutica e terapêutica das patologias pediátricas e neonatais mais comuns. Técnica e significado dos principais testes de rastreio feitos no neonato. Aleitamento materno. Aleitamento artificial. Avaliação de crescimento, desenvolvimento, status vacinal, maturação sexual. Abuso infantil. Comportamento suicida. Transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Principais patologias cirúrgicas Aspectos éticos do atendimento de crianças e adolescentes. Prontuário médico. Atendimento em sala de parto. Biossegurança.

Carga horária- 192 horas práticas

Bibliografia Básica

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, TRATADO DE PEDIATRIA, 5 EDIÇÃO Barueri/São Paulo, EDITORA MANOLE, 2021

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

DBEHRMAN, R. E. Nelson tratado de pediatria. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Artmed, 2018.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde do Adulto 1

Ementa - Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de adultos em cenário hospitalar e ambulatorial. Propedêutica e terapêutica das patologias clínicas e cirúrgicas mais prevalentes. Cuidados pós operatórios imediatos. Patologia do envelhecimento. Obesidade. Risco cardiovascular. Abordagem dos transtornos psiquiátricos mais comuns. Cuidados paliativos. Registro em prontuário. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança. Comunicação de más notícias.

Carga horária – 192 horas práticas

Bibliografia Básica

JAMERSON. **Medicina interna de Harrison**. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

TOWNSEND, C.M. **Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna**. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde da Mulher 1

Ementa - Pré- natal de baixo risco. Atendimento supervisionado de pré -natal de risco habitual, das principais patologias ginecológicas e mamárias. Coleta e gestão do preventivo de câncer ginecológico. Propedêutica e terapêutica das patologias clínicas e cirúrgicas mais prevalentes. Cuidados pós operatórios imediatos. Climatério, infertilidade. Contracepção. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança. Comunicação de más notícias.

Carga horária – 192 horas práticas

Bibliografia Básica

MONTENEGRO, CAB; REZENDE FILHO, J. **REZENDE OBSTETRÍCIA**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada: Saúde Da Mulher Na Gestação, Parto E Puerpério. São Paulo (Sp): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2019. 56 p. Disponível em: <https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/03091259-nt-gestante-planificasus.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2023.

Bibliografia Complementar

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Manual de Gestão de Alto Risco: Departamento de ações programáticas. 1. Ed. Brasília (DF): MS, 2022. 659 p. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/manual-de-gestacao-de-alto-risco-ms-2022/>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto SÍrio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de baixo risco. 1. ed. Brasília (DF): MS, 2012. 320 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Lista de Vídeos Aulas. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//lista_video_aulas.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Eletivo 1

Carga horária- 240 horas práticas

Bibliografia Básica

JAMERSON. **Medicina interna de Harrison**. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

TOWNSEND, C.M. **Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna**. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021

DÉCIMO PRIMEIRO PERÍODO

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Atenção Básica 2

Ementa - O estágio curricular na atenção básica consiste na vivência das atividades clínicas feitas nas equipes de saúde da família dentro das rotinas que estas executam junto a suas populações adstritas. Contempla desde o diagnóstico situacional, o mapeamento da área, a construção e a manutenção do mapa inteligente da área, o trabalho de visitas domiciliares junto com o Agente Comunitário de Saúde, a Enfermeira e o Médico da Unidade, o acompanhamento e a execução sob supervisão dos atendimentos clínicos e procedimentos feitos na Unidade Básica de Saúde e no domicílio, acompanhamento e realização sob supervisão da triagem feita na unidade pela enfermeira. os trabalhos de vigilância epidemiológica, busca ativa, promoção, de saúde, prevenção de saúde e reabilitação realizados pela equipe, bem como acompanhamento das ações de matriciamento previstas. Saúde mental na atenção básica. Gestão. indicadores de qualidade do serviço.

Carga horária- 320 horas práticas

Bibliografia Básica

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

CAMPOS, GWS et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.
BARROSO, W. K. S., et al. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial** – 2020. Arq Bras Cardiol., v. 116, n. 3, pp: 516-658, 2021. Disponível em:
https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-116-03-0516/0066-782X-abc-116-03-0516.x55156.pdf.

Bibliografia Complementar

ROUQUAYROL, M.E. Epidemiologia e Saúde. Medbook. 2012.
SÃO PAULO (Cidade). Secretaria da Saúde. Manual técnico: procedimento e legislação para risco biológico – Biossegurança na saúde nas Unidades Básicas de Saúde/Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo : SMS, 2014. 78 p.
BARROSO, W. K. S., et al. **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial** – 2020. Arq Bras Cardiol., v. 116, n. 3, pp: 516-658, 2021. Disponível em:
https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-116-03-0516/0066-782X-abc-116-03-0516.x55156.pdf.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Urgência e Emergência 2

Ementa - Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de urgência e emergência clínicos da área clínica, pediátrica, ortopédica, cirúrgica e de saúde mental. Discussão e acompanhamento da propedêutica indicada realizada na Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência onde esteja estagiando. Avaliação e discussão dos resultados de exames feitos nos pacientes atendidos. Acompanhamento clínico, e prescrição sequencial dos caso que for indicado permanecer em observação na unidade. Realização dos procedimentos indicados serem realizados ali. Discussão multiprofissional dos casos. Registro das discussões feitas no prontuário do paciente. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança em situações de emergência. Cuidados ao paciente agudamente crítico. Afogamento. Manobras de reanimação.

Carga horária - 320 horas práticas

Bibliografia Básica

BRANDÃO NETO, RA, Medicina de emergência: Abordagem Prática, EDITORA MANOLE, 2023
BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019
TOWNSEND, C.M. Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO Semiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;
DBEHRMAN, R. E. Nelson tratado de pediatria. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017
JAMERSON. Medicina interna de Harrison. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

DÉCIMO PERÍODO

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde da Criança 2

Ementa- Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de crianças, adolescentes e neonatos em alojamento conjunto, enfermaria, ambulatório. Propedêutica e terapêutica das patologias pediátricas e neonatais mais comuns. Técnica e significado dos principais testes de rastreio feitos no neonato. Aleitamento materno. Aleitamento artificial. Avaliação de crescimento, desenvolvimento, status vacinal, maturação sexual. Abuso infantil. Comportamento suicida. Transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Principais patologias cirúrgicas Aspectos éticos do atendimento de crianças e adolescentes. Prontuário médico. Atendimento em sala de parto. Biossegurança.

Carga horária - 192 horas práticas

Bibliografia Básica

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, TRATADO DE PEDIATRIA, 5 EDIÇÃO Barueri/São Paulo, EDITORA MANOLE, 2021

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

DBEHRMAN, R. E. Nelson tratado de pediatria. Ed. Guanabara Koogan. 20 ed. 2017.

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Artmed, 2018.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde do Adulto 2

Ementa - Acompanhamento e execução, sob supervisão de atendimentos de adultos em cenário hospitalar e ambulatorial. Propedêutica e terapêutica das patologias clínicas e cirúrgicas mais prevalentes. Cuidados pós operatórios imediatos. Patologia do envelhecimento. Obesidade. Risco cardiovascular. Abordagem dos transtornos psiquiátricos mais comuns. Cuidados paliativos. Registro em prontuário. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança. Comunicação de más notícias.

Carga horária – 192 horas práticas

Bibliografia Básica

JAMERSON. **Medicina interna de Harrison**. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

TOWNSEND, C.M. **Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna**. 20ª. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Saúde da Mulher 2

Ementa - Pré-natal de baixo risco. Atendimento supervisionado de pré-natal de risco habitual, das principais patologias ginecológicas e mamárias. Coleta e gestão do preventivo de câncer ginecológico. Propedêutica e terapêutica das patologias clínicas e cirúrgicas mais prevalentes. Cuidados pós operatórios imediatos. Climatério, infertilidade. Contracepção. Aspectos éticos do atendimento aos casos graves. Biossegurança. Comunicação de más notícias.

Carga horária – 192 horas práticas

Bibliografia Básica

MONTENEGRO, CAB; REZENDE FILHO, J. **REZENDE OBSTETRÍCIA**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 13 ed. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada: Saúde Da Mulher Na Gestaçao, Parto E Puerpério. São Paulo (Sp): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2019. 56 p. Disponível em: <https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/03091259-nt-gestante-planificasus.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2023.

Bibliografia Complementar

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Manual de Gestaçao de Alto Risco: Departamento de açoes programáticas. 1. Ed. Brasília (DF): MS, 2022. 659 p. Disponível em:

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/manual-de-gestacao-de-alto-risco-ms-2022/>. Acesso em: 15 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.

Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de baixo risco. 1. ed. Brasília (DF): MS, 2012. 320 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Lista de Vídeos Aulas. [S. l.], 2023. Disponível em:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//lista_video_aulas.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.

Componente Curricular - Estágio Curricular Obrigatório - Eletivo 2

Carga horária – 240 horas práticas

Bibliografia Básica

JAMERSON. **Medicina interna de Harrison**. 20ª. Edição; AMGH, 2019.

BERNOCHE, Claudia et al. Atualização da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia-2019. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 113, p. 449-663, 2019.

Bibliografia Complementar

PORTO & PORTO **Semiologia médica**. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019;

GUSSO, G., LOPES, J.M.C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Artmed, 2018.

TOWNSEND, C.M. **Sabiston Tratado de Cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica**

moderna. 20^a. Edição; Gen Guanabara Koogan, 2021

CAPÍTULO 8 - POLÍTICA E GESTÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO

8.1 Estágio Curricular Obrigatório

O Estágio Curricular Obrigatório é um programa obrigatório de ensino-aprendizagem com características especiais, durante o qual o estudante deve receber treinamento intensivo e contínuo, com supervisão docente/preceptor. É uma imersão em serviços adequados ao perfil de formação pretendido. Nesta etapa o estudante deverá aplicar, em contexto real e de maneira integrada, os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo dos quatro primeiros anos de formação, de acordo com a Resolução nº 03 de 2014, que prevê:

- A carga horária mínima do estágio curricular obrigatório será de trinta e cinco por cento (35%) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina;
- O mínimo de trinta por cento (30%) da carga horária prevista para o Internato Médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Nas atividades do regime de Internato previsto no inciso anterior e dedicadas à Atenção Básica e em Serviços de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), deve predominar a carga horária dedicada aos serviços de Atenção Básica sobre o que é ofertado nos serviços de Urgência e Emergência;
- As atividades do regime de Internato voltadas para a Atenção Básica devem ser coordenadas e voltadas para a área da Medicina de Família e Comunidade;
- Os setenta por cento (70%) da carga horária restante do Internato incluirão, necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental, em atividades eminentemente práticas e com carga horária teórica que não seja superior a vinte por cento (20%) do total por estágio, em cada uma destas áreas. (BRASIL, 2014)

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) é estabelecido pela Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura nº 1557R/2017, além das Resoluções CEPEC 1538R/2017 e 1539R/2017. Também em consonância com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a Lei Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 que institui o Programa Mais Médicos e, face ao propósito de se formar profissionais que atuem em prol da consolidação do SUS, considera-se o direcionamento a Lei Nº 8.080 de 1990.

A formação do profissional médico busca desenvolver competências, isto é, mobilizar os saberes e fazeres em situação real, aplicando conhecimentos, habilidades e demais recursos frente a problemas reais, com um agir assertivo (PERRENOUD, 1999). O saber, o fazer e o agir se articulam no enfrentamento das necessidades de saúde da comunidade, da família e do indivíduo.

Nesse processo de construção e de agir, o ECO representa um momento singular na consolidação e exercício de todo o saber e fazer teórico-prático, que fora acumulado nos anos anteriores de graduação. Para tanto, o ECO integrará uma importante etapa da formação médica do Curso de Medicina da UFCAT e funcionará em regime de internato a ocorrer nos serviços de atenção à saúde, em parcerias ou conveniados com a UFCAT, em conformidade com o art. 12 da Lei nº 12.871.

Nos serviços haverá preceptoria para o acompanhamento direto do estudante,

obrigatoriamente de um profissional médico, devidamente regulamentado mediante o Conselho Federal de Medicina e o Regional Goiano. Tanto estudante, quanto preceptor serão supervisionados por um docente com vínculo com a UFCAT, regido pela legislação federal para o ensino superior vigente.

Aspectos estabelecidos pela DCN de 2014 que serão norteadores do ECO do Curso de Medicina da UFCAT:

a) A carga horária do Estágio Curricular Obrigatório será de 2912 horas (38,4% da carga horária total do Curso) valor acima do mínimo de 35% da carga horária total;

b) Serão 1280 horas de estágio curricular em estágios na Atenção Básica e em serviços de Urgência e Emergência, no caso, 38,4% da carga horária total do estágio curricular obrigatório, o que é acima do mínimo de 30% (trinta por cento);

c) A Atenção Básica à Saúde nortear-se-á pela Médica da Família e Comunidade, no contexto da Saúde Coletiva;

d) As demais horas de ECO, serão desenvolvidas nas áreas de atenção em Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental, com pelo menos 80% de horas de atividades práticas;

e) O ECO poderá ocorrer fora da cidade de Catalão e do Estado de Goiás, em outra universidade conveniada, em até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio em curso, mediante autorização expressa do Colegiado do Curso de Medicina, em serviços do SUS, conforme já estabelecido.

f) A jornada semanal de cada estudante no ECO atenderá o limite máximo de 40h/semanais, podendo ser em formato de plantão de no máximo 12h corridas, em conformidade com a Lei Federal no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. Contudo sugere-se preferencialmente o atendimento aos horários de funcionamento dos serviços de saúde utilizados como campo prático de internato;

g) Cada estudante do Curso de Medicina deverá ler e assinar o termo de compromisso de estágio, o qual também deverá ser assinado pela Coordenação do ECO no Curso de Medicina, em duas vias, uma a ser entregue na diretoria do serviço de , utilizado como campo prático, e outra retida pela secretaria acadêmica do curso.

As demais alterações ou modificações que porventura sejam necessárias face às demandas da comunidade, do campo prático e/ou da Universidade, deverão ser analisadas pela Coordenação de Estágio e encaminhadas para o Núcleo Docente Estruturante (NDE), para posterior deliberação do Colegiado do Curso de Medicina da UFCAT.

São objetivos específicos do Internato:

Representar a última etapa da formação escolar do médico com perfil generalista, portador de capacidade para resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde prevalentes na população à qual vai servir;

Oferecer, ao estudante, oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nas fases anteriores do curso;

Oferecer condições para um bom adestramento em técnicas e habilidades, indispensáveis ao exercício de atos médicos básicos;

Promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à assistência aos pacientes;

Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo dos diversos profissionais que

constituem a equipe de saúde;

Possibilitar a aquisição de experiências em atividades resultantes da integração ensino-serviço-comunidade, através da participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;

Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das doenças e agravos;

Desenvolver a consciência de limitações, responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;

Desenvolver a consciência da necessidade de aperfeiçoamento profissional permanente.

8.1.1 Metodologia Utilizada

A metodologia utilizada é a aprendizagem em serviço. Este modelo de aprendizagem, baseado no construtivismo social, entende o aprendizado como fenômeno sociocultural, onde o aprendiz é introduzido em uma comunidade de prática. Nessa etapa do curso, o estudante trabalha em estreita colaboração com um professor orientador e um supervisor, e demais profissionais do serviço, na resolução conjunta de problemas.

Tradicionalmente o Internato Médico é visto como um rito de passagem em que os futuros médicos são inseridos na prática profissional para aprenderem o seu ofício. O internato da UFCAT tem planejamento estruturado, com objetivos educacionais definidos, de maneira a prover uma aprendizagem mais consistente e efetiva.

Segundo Cantillon e McDermott (2008), uma das chaves para o sucesso do Internato é o estudante assumir cada vez mais responsabilidades, no cuidado ao paciente, em um ambiente estruturado e supervisionado, o que se constituiria em poderoso motivador de aprendizagem.

Assim, o ciclo de aprendizagem se dá pela execução, sob a supervisão de um profissional experiente, de tarefas da prática profissional, quando o estudante observa, executa, discute e reflete. A execução vai crescendo em complexidade e o apoio do professor vai diminuindo até que o estudante seja capaz de executar a tarefa de forma independente.

Essa metodologia envolve o conceito de Lev Vygotsky de "zonas proximais de desenvolvimento" (FINO, 2001). O estudante é exposto a tarefas autênticas de um grau de dificuldade que não permite sua realização independente, porém, não tão difíceis que não possam ser executadas com o apoio do professor. Na medida em que o processo de ação e reflexão se repete, o suporte dado pelo professor vai sendo reduzido e o estudante ganhando autonomia até o momento em que é capaz de compreender e executar toda a tarefa sem auxílio do professor.

O Internato é feito de forma rotativa e integrada, caracterizada pelos seguintes módulos:

10. **Saúde do Adulto I e II** - engloba as áreas de conhecimento: *Clinica Médica, Cirurgia Geral, Terapia Intensiva, Cardiologia, Pneumologia, Dermatologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Traumatologia, Psiquiatria e Urologia*;
11. **Saúde da Criança I e II** - engloba as áreas de *Pediatria e Neonatologia*;
12. **Saúde da Mulher I e II** - engloba as áreas de *Ginecologia e Obstetrícia*;
13. **ATENÇÃO BÁSICA e ATENÇÃO BÁSICA II** - engloba as áreas de conhecimento: *Epidemiologia Clínica, Saúde do Trabalhador, Saúde Mental e Medicina de Família e Comunidade*.
14. **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II** – engloba as áreas do conhecimento médico voltadas ao atendimento de urgências e emergências dentro *Clinica Médica, Cirurgia Geral, Terapia Intensiva, Cardiologia, Pneumologia,*

Dermatologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Traumatologia, Psiquiatria e Urologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia;

No Internato, o estudante aprende com a experiência desenvolvida, tanto à “beira do leito” como no atendimento prestado aos pacientes nos ambulatórios ou atividades nas unidades básicas e ESF, quando aplicam, de maneira integrada, os conhecimentos, habilidades e atitudes anteriormente adquiridos, procurando novos conhecimentos e desenvolvendo as habilidades e atitudes esperadas.

O cenário onde o Programa de Internato será realizado são as instituições de cuidado à saúde ligadas ao SUS da Região de Saúde da Estrada de Ferro em um programa de rodízio em 5 módulos em cada ano, a saber:

Atenção básica e Atenção básica 2, com carga horária 320 horas cada um;

Urgência e emergência e Urgência e emergência 2, com carga horária 320 horas cada um;

Saúde do adulto e do idoso 1 e 2, com carga horária 192 horas cada um;

Saúde da Mulher 1 e 2, com carga horária 192 horas cada um;

Saúde da Criança 1 e 2, com carga horária 192 horas cada um;

Estágio eletivo 1 e 2, com carga horária 240 horas cada um.

8.2 Estágio curricular não obrigatório

Será considerado Estágio Não-Obrigatório aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescido à carga horária regular e obrigatória, após o seu Plano de Ação ser aprovado pela Coordenação de Estágio e devidamente justificado, e que siga os regramentos gerais aplicáveis para a atividade.

Só poderá ser solicitado por estudantes do Terceiro (3º) Período em diante que tenham sido aprovados em todos os elementos curriculares até aquele momento. Esta solicitação será feita mediante ofício com Plano de Trabalho, professor responsável pela supervisão do estágio e Termo de Compromisso de Estágio.

Todo estágio não obrigatório deverá ser supervisionado por um (1) docente de um Curso de Medicina que deverá assinar os relatórios periódicos deste, quando, então, deve posicionar-se sobre a pertinência da sua continuidade ou não.

No Estágio Curricular Não-Obrigatório, a Instituição Concedente é responsável pela contratação para o estagiário, de seguro contra acidentes pessoais, uma apólice que seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio, de acordo com a Lei 11.788/2008.

As Entidades que serão campo de Estágio Não-Obrigatório, deverão ter convênio com a UFCAT; o Coordenador de Estágio consultará ao Colegiado do Curso sobre a viabilidade da realização do estágio, considerando a contribuição para a formação do estudante e a ausência de prejuízo para as atividades acadêmicas.

A duração do Estágio Curricular Não-Obrigatório não poderá exceder dois (2) anos, exceto quando se tratar de Estagiário Portador de Deficiência;

A orientação do Estágio Não-Obrigatório será exercida por docente que possui área de atuação e experiência profissional no estágio escolhido pelo estudante e poderá ser exercida de acordo com as seguintes modalidades:

a) Orientação Direta: com acompanhamento e orientação do planejado, por observação contínua das atividades desenvolvidas nos campos de estágio ao longo de todo processo;

b) Orientação Semidireta: acompanhamento e orientação do planejado, por meio de visitas sistemáticas aos campos de estágios pelo professor supervisor.

É obrigatória a concessão *de bolsa*, férias e auxílio transporte por parte da Instituição Concedente ao estagiário, de acordo com a Lei 11.788/2008.

O Estágio Não-Obrigatório não cria Vínculo Empregatício.

Não será previsto Estágio Não-Obrigatório em outro país.

CAPÍTULO 9 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Não será previsto trabalho de conclusão de curso para o curso de Medicina da UFCAT.

CAPÍTULO 10 - POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

O Curso de Graduação em Medicina, da UFCAT ao indicar em sua proposta de ensino com enfoque no estudante como sujeito da aprendizagem e o professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, deverá buscar a formação integral e adequada do estudante por meio da articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão, e a assistência. Desse modo, o Curso de Medicina buscará, em um movimento contínuo, implementar as políticas institucionais previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFCAT.

Todos os componentes curriculares são incentivados a articular ensino, pesquisa, extensão; buscando uma formação humanística e social, por meio do desenvolvimento de projetos solidários e socioculturais. Desenvolverá, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, uma política de formação contínua dos docentes, no campo didático-pedagógico, através da oferta de Cursos como o de “Docência no Ensino Superior” destinado aos professores.

Quanto à política de extensão, o curso criará programas que busquem uma maior integração entre a cultura universitária e a não universitária, além de fomentar o ingresso de estudantes em programas, já existentes na UFCAT, que valorizam atividades de extensão e cultura, tais como: Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC) e o Programa de Voluntariado (PROVEC).

Por outro lado, com a finalidade de fomentar a produção científica de docentes, discentes e técnico-administrativos, deverão ser incentivadas as seguintes ações: Inserção do Curso de Medicina nos programas de Iniciação Científica adotados na universidade, tais como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), em todas as suas variações: PIBIC/CNPQ-EM (ensino médio), PIBIC/CNPQ-AF (estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas); o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq); além de incentivar o estágio não remunerado de pesquisa, com direito a certificado, quando reconhecido pelo Colegiado de Curso. Desta forma, contribuir para eliminar o senso comum de que só se faz pesquisa com bolsas, valorizando os esforços de quem participa espontaneamente; estimular a formação sistemática de pesquisadores bolsistas e voluntários, com vistas à qualificação profissional e à preparação para pós-graduação; introduzir estudantes de graduação em grupos de pesquisa; fomentar projetos nas diversas áreas de competência do curso e a interdisciplinaridade com outros departamentos, instituições públicas e privadas; buscar parcerias públicas e privadas entre graduação e pós-graduação, incentivar projetos de aperfeiçoamento do ensino/pesquisa, propondo experiências metodológicas e bibliográficas renovadoras; incentivar, nas diferentes áreas do Curso, atividades sistemáticas de pesquisa e extensão, sempre alinhadas às demandas e prioridades da comunidade, e estimular o intercâmbio entre pesquisadores de cursos de Medicina e áreas afins intra e inter-institucionais.

Também propõe fomentar a participação dos estudantes em políticas de intercâmbio como: Jovens Talentos (CAPES), Programa de Mobilidade Estudantil (ANDIFES-MEC), Intercâmbio para Universitários no Mercosul, Ciência Sem Fronteiras etc. Incentivar o corpo docente do Curso de Medicina da UFCAT desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão de modo indissociável, considerando, sempre em consonância com as necessidades locais, regionais e nacionais; contemplar, na política institucional de extensão, e em suas articulações com ensino e pesquisa, eixos temáticos que se refiram a problemas sociais, econômicos e culturais, incluindo a preservação e sustentabilidade do meio ambiente, a promoção à saúde e à qualidade de vida, o desenvolvimento da cultura, a transferência de tecnologias apropriadas, atenção integral à mulher, a criança, ao

adolescente, ao adulto e ao idoso e a capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas.

CAPÍTULO 11 - PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E APOIO AO DISCENTE;

11.1 Métodos de avaliação

A avaliação do aproveitamento dos componentes curriculares do curso de Medicina da UFCAT será feita por instrumentos variados, que serão apresentados e detalhados no plano de ensino, sendo que cada instrumento avaliativo será escolhido de modo coerente com a metodologia de ensino de cada componente curricular prevista neste PPC (Quadro 17).

Quadro 17 – Componentes Curriculares e Metodologias Avaliativas

Componentes curriculares	Metodologia proposta	Instrumentos avaliativos propostos
Atenção à Saúde na Prática Comunitária	Arco de Maguerez Oficinas pedagógicas	Avaliação formativa (FeedBack) Avaliação de relatórios, resumos e artigos construídos a partir das atividades pedagógicas Avaliação do processo de construção, implementação e documentação de projetos de intervenção na realidade, Autoavaliação e avaliação por pares Avaliação 360 graus
Necessidades de saúde e planos terapêuticos aplicados	Aprendizagem baseada em problemas Oficinas pedagógicas Viagens educacionais	Avaliação formativa(FeedBack) Avaliação de relatórios produzidos nos tutoriais Avaliação somativa Autoavaliação
Ciência, tecnologias em saúde, adoecimento e cuidado	Aprendizagem baseada em times Oficinas pedagógicas outras	Avaliação formativa(FeedBack) Avaliação de relatórios produzidos durante as atividades Avaliação somativa Autoavaliação
Habilidades clínicas	Simulação Oficinas pedagógicas outras	Avaliação formativa(FeedBack) Avaliação de relatórios produzidos durante as atividades Avaliação somativa OSCE Autoavaliação

Fonte: Autoria Própria, 2024

11.2 Autoavaliação e avaliação pelos pares

De modo genérico, avaliar remete à ação de evocar informações sobre o aprendizado e usá-la para modificá-lo, uma ação que historicamente foi associada ao docente mas que, vem acumulando evidências em favor da participação do estudante no processo (Reinholz, 2015).

A autoavaliação e avaliação pelos pares, são estratégias bem conhecidas de promover a educação centrada no estudante e na autorregulação, e devem ser um elemento chave de toda a educação superior (Ndoye, 2017).

A autorregulação do estudo vai ao encontro ainda com a orientação das Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de medicina de que o egresso deve “aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada” (BRASIL, 2014), habilidade de componente essencial por permitir identificar fraquezas e forças, e auto regular sua própria

formação (Tang; Shikama; Otani, 2023) que se traduz pelas habilidades de definir objetivos, adotar estratégias para alcançá-los e monitorar seu próprio progresso (Boekaerts; Corno, 2005)

Pode-se definir avaliação por pares como um conjunto de atividades através das quais os indivíduos fazem julgamentos a respeito do trabalho de outros, e esta atividade, mesmo não tendo um modelo teórico de suporte definido tem melhor correlação com a avaliação docente do que a auto avaliação (Reinholz, 2015).

Se define a autoavaliação como um processo pelo qual os estudantes são direcionados a avaliar suas performances em relação a padrões definidos (Bourke; Mentis, 2013).

A auto avaliação e a avaliação por pares visa, assim, identificar o quanto o comportamento que tiveram durante as atividades, está próximo ou distante do melhor comportamento desejável naquela situação, que pode ser de estudo coletivo, no caso de tutoriais, de realização de algum procedimento clínico, e mesmo da reação emocional (Uebe Mansur; Alves, 2018; Lemes et al., 2021).

A eficácia da autoavaliação pede que o estudante tenha clareza da performance desejada, tenha clareza de como foi sua atuação real, e atue para modificar esta diferença, e é neste campo que a avaliação pelos pares pode ajudar, permitindo contato com outra visão sobre seu esforço e performance, geralmente supervalorizada (Dunning; Health; Suls, 2004).

Deste modo, ela deve estar presente desde o início da formação, com a percepção de ter ou não encontrado os objetivos de estudo de uma determinada situação, até as fases mais avançadas da formação médica, identificando fragilidades no processo de raciocínio clínico ou nas habilidades que deveria demonstrar naquele nível, ambas situações relacionadas ao estudo autorregulado (Eva; Regehr, 2005).

Há evidências de que o impacto da autoavaliação na melhora das habilidades clínicas é maior que nas atividades baseadas em conhecimento (Colthart et al., 2008).

Considerando que as evidências de que a avaliação pelos pares é mais acurada, o uso combinado das duas situações seria um caminho para melhora da autopercepção quando comparada com avaliação de pares e avaliação (Rudy et al., 2001) e que elas promovem a reflexão e o estudo (Tayem et al., 2015; Capan et al., 2020).

A autoavaliação será feita em conjunto com a avaliação pelos pares no curso de medicina da UFCAT, devendo ser reservado momento específico para tal nos planos de ensino, bem como previstos os elementos que serão avaliados, tanto no sentido de definição, como de terminologia usada e, como não há nenhum instrumento padronizado universal validado para este uso (Colthart et al., 2008), os componentes construirão propostas em conjunto com o Núcleo Docente estruturante cada com vistas a alcançar uma padronização.

11.3 Feedback

Considerada a principal forma de avaliação formativa, ela é conceituada hoje como “informação personalizada baseada na observação direta construída e entregue para quem pode usar a informação para alcançar seu melhor potencial” (Jug et al., 2019), entendida como elemento essencial na formação de profissionais de saúde, a palavra teve sua origem em 1860 na revolução industrial, incorporando o sentido de retorno para a máquina ou processo; em 1940, na engenharia de foguetes, ganhou sentido de retorno para corrigir rumo e só em 1945, no fim da segunda guerra mundial passou a ser usada no campo interpessoal. Em 1950 foi incorporada no mundo dos negócios e em 1980 foi usada na educação médica pela primeira vez como recurso para promover reflexão.

Possui diversas técnicas descritas, geralmente construídas para serem usadas em situação clínica (Quadro 18).

Quadro 18 -Diferenças entre os vários métodos de Feed-back ou devolutivas

Nome do método	História	Descrição	Observação
Feedback sanduíche	Descrita por LeBaron and Jernick em 2000	dar um feedback positivo antes e após um negativo. Usar o conectivo “e” no lugar de “mas”	A mais conhecida. É rápida e fácil de fazer. Pode parecer rígido e artificial. Com o tempo pode perder o efeito “protetor” e mesmo gerar pessoas reativas ao feedback
Pergunte – fale pergunte	2005 em Cleveland	Pergunta 1 – pedir autoavaliação do estudante Fale – fale o feedback Pergunta 2 – confirme compreensão e faça plano de melhoria	Foi desenvolvido para melhorar a reflexão dos estudantes médicos e a capacidade de autoavaliação de suas habilidades.
Modelo Pendleton	Regras de feedback criadas por um psicólogo em 1984	O estudante e depois o professor descrevem o que deu certo, seguido das áreas a serem melhoradas, sequencialmente	Fácil de ser usada por quem não tenha experiência
Preceptor de um minuto	Criado em 1992, em cenários de saúde da família	Técnica de ensino em que o estudante se compromete com a conclusão (diagnóstico) e um supervisor estimula o processo de pensamento do estudante enquanto ensina regras gerais	Bem fácil de aprender
Modelo SET GO	Kurtz et al. (1998)	É um modelo descritivo que pode ser aplicado a grupos ou indivíduos, validado para observação de atividades filmadas	Mais difícil para observadores inexperientes

Autoria própria, baseada em Jug e colaboradores (2019) e Chowdhury e Kalu (2011)

Independente da técnica utilizada, sua eficiência depende de existir uma cultura institucional de devolutiva, e se deve buscar sempre ser objetivo, relevante, ter foco no que foi feito e não na pessoa que fez, ser oportuno em relação ao tempo entre o observado e a metodologia usada deve promover a construção de estratégia de melhora do ponto abordado.

Importante, ainda, que seja uma atividade encarada como parte do trabalho docente e o conteúdo da devolutiva deve ser registrado, para que o que foi indicado como problema, seja acompanhado ao longo do tempo.

11.4 Avaliações escritas

As avaliações escritas podem ser classificadas com base no formato de estímulo (o grau de detalhamento do contexto) e como se espera a resposta (seleção de resposta ou elaboração de resposta) (Schuwirth; Van Der Vleuten, 2004).

Com relação ao formato do estímulo (enunciado), podem ser classificadas entre sem contexto, que demandam conhecimento factual específico, e com contexto detalhado, que são as que podem avaliar tomada de decisões e raciocínio clínico, havendo consenso que as questões do primeiro ciclo devem ser mais objetivas e a do ciclo clínico precisa envolver subjetividade e raciocínio clínico (Javaeed, 2018).

11.4.1 Questões abertas

As questões abertas podem ser de resposta curta ou de resposta longa ou tipo ensaio, mais difíceis de corrigir, e enquanto grupo, se correlacionam com menor nota em relação às questões fechadas, tanto as que demandam respostas curtas como as longas (Kwon; Chae; Park, 2023) não são superiores na avaliação de elementos superiores do processo cognitivo em relação às fechadas de múltipla escolha (Hift, 2014).

Um tipo específico de avaliação é o chamada salto, descrita inicialmente por Echavarria (2010) num curso de engenharia e consiste em reproduzir os passos da aprendizagem baseada por problemas, ou seja, uma avaliação em três passos: a) discutir os objetivos de aprendizado, b) pesquisar o conteúdo necessário para o aprendizado dos objetivos e discutir as informações encontradas, e c) avaliar o ganho de conhecimentos. Apesar da relação óbvia com uma das metodologias ativas mais usadas nos cursos de medicina, ainda não encontra expressão em termos de publicações científicas sobre ele (Cansanção et al., 2017).

11.4.2 Questões fechadas

Neste grupo há dois tipos das mais populares: a) de escolha de uma entre várias opções, e b) as de verdadeiro e falso. A questão de verdadeiro e falso consiste em uma afirmação inicial verdadeira, e a declaração que o estudante deve decidir se é verdadeira ou falsa. É uma questão muito difícil de construir. A questão de escolher uma entre várias opções é a mais versátil e largamente usada. Não há evidências de superioridade de testes com 4 sobre o de 5 alternativas (Schuwirth; Van Der Vleuten, 2004).

As críticas às questões de múltipla escolha geralmente têm a ver mais com equívocos no processo de elaboração das mesmas, que com as possibilidades que elas apresentam, por isto é recomendável ocorrer treinamento formal para construção de questões de avaliação (Scully, 2017).

11.5 Avaliação 360 graus

Neste formato de avaliação, se colhem informações sobre o avaliado e de todos os que interagem com ele no campo do trabalho em vários campos (trabalho em grupo, habilidades de comunicação, capacidade de decisão e de gestão) e então, é feita a devolutiva permitindo avaliar todas as competências clínicas gerais (cuidado com o paciente, conhecimento médico, aprendizado e aprimoramento baseado na prática, habilidades interpessoais e comunicacionais, profissionalismo e prática baseada no sistema).

É importante que não haja uma ferramenta padrão genérica para esta avaliação e é necessário desenvolver ferramentas específicas para as avaliações que se deseja fazer (Massagli; Carline, 2007).

11.6 Avaliação de habilidades clínicas

As competências clínicas descritas pelo Conselho de Acreditação para Educação Médica são seis: 1) cuidado com o paciente (indica exames e procedimentos indicados corretamente em diferentes cenários de cuidado), 2) conhecimento médico (sabe como manejar pacientes com patologias diferentes), 3) aprendizado e aprimoramento baseado na prática (escuta as devolutivas, busca descobrir suas próprias fraquezas e busca melhorar, encontra e analisa novos estudos para ajudar o cuidado dos pacientes), 4) habilidades interpessoais e comunicacionais (fala claramente com os pacientes, famílias, pares e outros profissionais ligados ao cuidado, mantém prontuário atualizado, claro e completo), 5) profissionalismo (mostra cuidado e respeito por todos, mostra respeito pela sociedade e profissão médica) e 6) prática baseada no sistema (trabalha em grupo com foco na qualidade do cuidado, pensa em custo benefício nas tomadas de decisão) (Smith et al., 2013).

Um projeto canadense de 2000, apontou que mesmo havendo muitos papéis a desempenhar (especialista, comunicador, colaborador, gerente, defensor da saúde, comprometido com a educação continuada e profissional) haveriam basicamente duas dimensões de avaliação: a humanística, que englobaria comunicação interpessoal e profissionalismo,, e a competência técnica, que englobaria conhecimento médico, cuidado com o paciente e atenção baseada no sistema (Domingues; Amaral; Bicudo-Zeferino, 2009).

Como fica óbvio, a avaliação das habilidades clínicas que envolvem conhecimento teórico, habilidades psicomotoras e aspectos atitudinais, não pode ser avaliada com provas escritas (Epstein, Hundert, 2002), sendo melhor indicados: observação direta em prática simulada ou real.

São exemplos de metodologias de avaliação de observação direta na prática simulada: Objective Structured Clinical Examination (OSCE) e suas variações e a metodologia de avaliação em cenários reais: o Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), avaliação 360 graus, a revisão de vídeo, a observação direta de habilidades clínicas, a observação de registro de prontuário e observação de vídeos de atendimento (Khan; Ramachandran, 2012).

11.6.1 Exame clínico objetivo estruturado (OSCE)

Foi introduzido como método de avaliação por Harden em 1975 por retirar a variabilidade decorrente dos pacientes e dos avaliadores (Harden et al., 1975).

Ele consiste em várias estações contendo demandas específicas, que devem ser realizadas pelos estudantes num determinado tempo após a leitura das orientações disponíveis ali. Após a realização dos procedimentos da estação, deve ser feita devolutiva.

As tarefas demandadas podem ser curtas quando a demanda é de avaliação de pontos específicos, ou mais longas quando o objetivo é mais complexo; o número de estações e a duração muito elevada das estações podem interferir na confiabilidade do método (Elshama, 2021).

Hoje é citada como padrão ouro para avaliar competências clínicas nos domínios competências clínicas, atitudes e comportamento (Elshama, 2021; Sloan, 1995).

O método é aplicável tanto para demonstração das habilidades, como para avaliar conhecimento teórico relacionado às perguntas das estações.

Ele é considerado objetivo, pois a mesma estação estará disponível para todos os estudantes, estruturado por envolver instruções, e demanda de tarefas específicas e seguro, por não envolver pacientes reais.

11.6.2 Mini avaliação do desempenho clínico MINI-CEX

O MINI-CEX (mini - Clinical Exercise Evaluation) é uma modificação de outro método de avaliação criado pela American Board of Internal Medicine. O Clinical Exercise Evaluation (CEX), consiste de uma avaliação de exame clínico realizado pelo estudante no leito do paciente e avaliado por professores diferentes, em diferentes cenários. A modificação, publicada em 1995, consiste na observação direta de um atendimento enquanto ele faz uma consulta objetiva e rápida, focada em uma necessidade do paciente (Diniz Neto et al.; 2020).

Ele avalia sete competências: realização da anamnese, habilidade de comunicação, habilidade ao exame físico, raciocínio clínico, conduta ética, organização/eficiência e competência clínica geral. Após a observação do atendimento, o avaliador pontua e dá o feedback sobre seu desempenho sugerindo melhorias.

Há evidências qualificando seu uso em cenários variados inclusive na graduação (Zaki et al., 2023; Martinsen et al., 2021; Neto et al., 2020).

Avaliação de habilidades clínicas

A avaliação da aquisição de habilidades psicomotoras e atitudinais, usará como referencial a pirâmide de Miller modificada, que tem na base da pirâmide o saber, seguido hierarquicamente, o saber como, o demonstrar como, o fazer, e por último, o ser confiável (Domínguez-Torres; Vega-Peña, 2023), assim, por sua natureza multidimensional (Epstein, Hundert, 2002) a

metodologia avaliativa indicada para estas habilidades, não pode ser baseada em instrumentos avaliativos que lance mão apenas de registro escrito, por exemplo, mas a observação em cenário de prática simulada (OSCE) ou em cenário de prática real (Observação direta de cuidados, observação de registro de prontuário, OSCE, observação de vídeos de atendimento, avaliação 360 graus).

11.5 Avaliação do método de avaliação

A coordenação fará o acompanhamento de todas as atividades avaliativas previstas nos planos de ensino, e manterá arquivo das avaliações aplicadas, com o fim de propor melhorias no processo avaliativo do curso.

Esta tarefa será feita em conjunto com os membros da Comissão de Avaliação.

11.6 Suporte ao estudante

Por motivos variados relacionados às cobranças do curso, à personalidade do estudante, todos os indicadores de sofrimento psíquico avaliados por diferentes meios e instrumentos são alterados nos estudantes de medicina (Conceição et al., 2019).

Assim, a organização de modos de acompanhamento e suporte ao estudante é mandatória e o próprio programa de implantação do curso de medicina incluiu profissionais específicos para esta função, que no curso de Medicina da UFCAT se chama de PROAPOIO, formado por psicólogos e pedagogo, cuja função é construir e executar as ações de apoio psicopedagógico aos discentes.

As ações do PROAPOIO são integradas com o Núcleo de Apoio Discente e incluem escuta, orientação pedagógica, orientação sobre os recursos disponíveis na Universidade e rede de cuidado de saúde da cidade, organização das demandas discentes, acompanhamento dos casos que precisem de tratamento especializado na rede, construção de programas e recursos para abordar as questões mais prevalentes.

11.7 Avaliação de Desempenho Docente

Além da avaliação administrativa obrigatória, o Curso de Medicina da UFCAT vai acompanhar o desenvolvimento das competências centrais essenciais para o docente do curso, uma vez que a tarefa é complexa e já se sabe que a autocrítica neste sentido não é muito acurada (Giesler; Lammerding-Köppel; Griewatz, 2022).

Há consenso que as competências esperadas para os docentes dos cursos de medicina são as seguintes: conhecimento de conteúdo médico, ensino centrado no estudante, habilidades de comunicação (competência social e comunicativa), profissionalismo na modelagem de papéis, reflexão baseada na prática e, ensino e aprendizagem baseada em sistemas (Srinivasan et al., 2011) descritas no quadro XX.

Quadro 19 - Descrição das competências esperadas nos docentes de cursos médicos

Competência	Descrição
Conhecimento de conteúdo médico	Ao ensinar conteúdos, aborda as habilidades de cada um dos estudantes dentro de seu campo de expertise
Ensino centrado no estudante	Demonstra comprometimento tanto com o sucesso como com o bem estar do estudante, e os ajuda a crescer em seus papéis profissionais
Habilidades comunicacionais e interpessoais	Demonstra flexibilidade nos estilos comunicacionais para facilitar o aprendizado
Profissionalismo e modelagem	Demonstra melhores práticas educacionais e de conteúdo para os estudantes
Melhora baseada na reflexão sobre a próxima prática	Demonstra autoavaliação contínua e aprendizado contínuo para melhorar sua efetividade e capacidade como educador
Ensino e aprendizado baseados em sistemas	Utiliza recursos dentro de sistemas de educação permanente para mudar estratégias e oferecer o melhor de ensino e aprendizagem.

Fonte: Autoria própria, baseado em Srinivasan et al (2011) e Görlitz et al (2015)

Há escala validada para avaliar estes itens mas ainda não foi validada para uso em nosso país (Giesler; Lammerding-Köppel; Griewatz, 2022).

11.8 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso

A respeito da Avaliação interna, o curso mantém reflexão contínua sobre o processo de avaliação dos componentes educacionais, promovendo discussões dos processos e resultados destas avaliações no Núcleo Docente Estruturante (NDE), que faz reuniões periódicas para se discutir o projeto pedagógico de curso e seus resultados na formação do estudante.

As ações discutidas no NDE são trazidas para as reuniões do curso para viabilizar a implantação das sugestões e melhorias necessárias.

Há um núcleo específico dentro do curso, formado para implementação e execução desta tarefa: Núcleo de Avaliação cuja função é avaliar os métodos avaliativos usados no curso e promover sua melhoria.

Também neste sentido é necessário registrar o papel da Comissão Própria de Avaliação - CPA (criada pela resolução CONSUNI 11/2022), e no âmbito de Universidade Federal de Catalão é a Comissão de Avaliação Institucional – CAVI, que tem como missão instituir na UFCAT uma cultura de avaliação, subsidiando de modo pleno, a gestão acadêmica, rumo à potencialização e desenvolvimento do desempenho institucional. A CAVI é responsável por conduzir o processo de avaliação dos docentes pelos estudantes, e os resultados são encaminhados ao NDE para análise.

11.8 Avaliação externa

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Medicina de 2014, a educação em saúde pontua no art. 7º que o graduando deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual, responsabilidade social, ao tempo em que se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional. Dentre os objetivos que acessam a aprendizagem do estudante do curso de medicina, no inciso V ressalta o comprometimento do curso de medicina com seu processo de formação, envolvendo-se em ensino,

por meio de processos de autoavaliação e de avaliação externa dos agentes e da instituição, promovendo o conhecimento sobre as escolas médicas e sobre seus egressos.

Para atender as DCNs e acreditando que o processo de ensino-aprendizagem do estudante é crucial para diagnosticar e traçar metas que melhorem a formação profissional dos estudantes de medicina, bem como, buscas no aprimoramento do processo de ensino, o curso de medicina da UFCAT vem participando desde 2020, do Consórcio do Teste de Progresso do Centro-Oeste (TP-CO) com sede em Brasília-DF, sob à coordenação de docentes ligados ao curso de Medicina e ao Núcleo Docente Estruturante.

CAPÍTULO 12 - GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA

O Curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão é coordenado no campo administrativo através de um docente chefe e vice-chefe, e no campo pedagógico através de um coordenador e vice-coordenador pedagógico, e é previsto, ainda, pelo regramento da Universidade, coordenador e vice-coordenador de Estágio.

Com exceção do cargo de chefia e vice chefia, os demais são privativos de médicos.

São ainda instâncias administrativas do curso: Coordenação Pedagógica de Períodos, Coordenação Administrativa de Laboratórios; Colegiado de curso; Núcleo Docente Estruturante (NDE); Comissão Interna de Avaliação (CIA); Secretaria Executiva; Secretaria Administrativa; Comunidade Universitária do Curso; Pro-Apoio.

As decisões do curso se farão por colegiado, que se reunirá ordinariamente na primeira quarta feira do mês e terá como membros: chefia do departamento, coordenação pedagógica do departamento, coordenador de estágio, coordenadores docentes, representantes discentes, representantes dos técnicos administrativos e do PROAPOIO.

No quesito avaliação externa, a UFCAT tem Programa de Autoavaliação Institucional - a CPA - Comissão Própria de Avaliação que é um órgão de governança, portanto com autonomia dos outros conselhos da Universidade, garantida pelo artigo 11 da Lei 10 861 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação Superior SINAES, que investe a comissão de poder e da incumbência de sistematização referida acima, bem como da obrigação de envio de informações solicitadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, disciplinada pela Portaria Normativa do MEC - 840 de 24 de agosto de 2018.

A CPA-UFCAT é composta por membros representantes dos segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, sendo encarregados do planejamento, da autoavaliação da instituição, dos seus cursos e dos docentes, e no caso da UFCAT, comporta ainda a Autoavaliação discente.

Para além do processo institucionalizado de Autoavaliação mencionado acima, a CPA posiciona-se de forma partilhada na crença de que os seus procedimentos são fundamentais para que os cursos possam zelar pela sua autonomia, quando possuem dados de sua comunidade, da instituição, de seus professores e estudantes, possibilitando a tomada de consciência em vários níveis, na busca de seu diálogo com sua missão enquanto instituição social e promotora da educação superior; isto, por acreditar na autoavaliação como o momento de conhecer pontos fortes, eventuais fragilidades, percepção da forma como a sua comunidade universitária entende e responde às propostas formuladas e aplicadas pelos gestores educacionais.

Há ainda para os gestores, os conselhos diversos e as demais instâncias deliberativas, a possibilidade de, de posse dos dados e da expressão da percepção contida no Programa de Autoavaliação Institucional, se orientar em relação ao próprio curso, mas também em relação à Universidade, bem como em relação à sociedade em geral.

REFERÊNCIAS

- ABREU, JRP. **Contexto Atual do Ensino Médico: Metodologias Tradicionais e Ativas - Necessidades Pedagógicas dos Professores e da Estrutura das Escolas**. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) Faculdade de Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS pp. 105, 2009.
- AGUIAR, A. C. DE .; RIBEIRO, E. C. DE O.. Conceito e avaliação de habilidades e competência na educação médica: percepções atuais dos especialistas. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 3, p. 371–378, jul. 2010.
- AUSUBEL, D. **Aquisição e retenção de conhecimentos: Uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Editora Plátano, 2003.
- BAARTMAN, L. K. J. et al. Evaluating assessment quality in competence-based education: a qualitative comparison of two frameworks. **Educational Research Review**, United Kingdom, 2(2)114-129, 2007.
- BEN, AJ et al., Rumo à educação baseada em competências: construindo a matriz do internato em Medicina de Família e Comunidade. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 39, p. 1–16, 2017.
- BRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de dezembro de 1990. **Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.
- BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução Nº 3, De 20 De Junho De 2014. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências**. 2014.
- BRASIL. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. **Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 1971.
- BRASIL. - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**. Ministério de Educação e Cultura. LDB, 1996.
- CABRAL, MFCT; VIANA, AL; GONTIJO, DT. Utilização do paradigma da complexidade no campo da saúde: revisão de escopo. **Escola Anna Nery**, v. 24, 2020.
- CAMPOS, C. M. S.; MISHIMA, S. Necessidades de saúde pela voz da sociedade civil e do Estado. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 21, n. 4, p. 1260-1268, 2005.
- CASTAÑON, GA. O que é construtivismo? **Cad. Hist. Fil. Ci.**, Campinas, Série 4, v. 1, n. 2, p. 209-242, jul.-dez. 2015.
- CECÍLIO, L. C. O.; MATSUMOTO, N. F. Uma taxonomia operacional de necessidades de saúde. In: PINHEIRO, R.; FERLA, A. F.; MATTOS, R. A (orgs.). **Gestão em Redes: tecendo os fios da integralidade em saúde**. Rio Grande do Sul: Rio de Janeiro: EdUCS/UFRS: IMS/UERJ: CEPESC, 2006. 112p.

CECILIO, LCO. **As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta pela Integralidade e Equidade na Atenção em Saúde .In Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde** / Roseni Pinheiro e Ruben Araujo de Mattos, organizadores. Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2006. 184p. ISBN 978-85-89737-52-4.

CESARIO, RR; CESARIO, M; SANTOS, CG. Alvorecer do Paradigma Sistêmico na Educação Médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, p. 305-313, 2020.

CHOWDHURY, RR; KALU, G. Learning to give feedback in medical education, **The Obstetrician & Gynaecologist**, 6:243–247, 2011.

CONCEIÇÃO, LS et al. Saúde mental dos estudantes de medicina brasileiros: uma revisão sistemática da literatura. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 24, p. 785-802, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Internato médico: formação médica, responsabilidade social, competências gerais, cenários de prática, avaliação, preceptoria**. Textos relativos ao conteúdo apresentado no X Fórum Nacional de Ensino Médico, Fortaleza, 30 e 31 de maio de 2019 / Lúcio Flávio Gonzaga Silva, editor. Comissão de Ensino Médico, Conselho Federal de Medicina. – Brasília: CFM, 2020.

DESIDERIO, TMP; FERREIRA, ASS. Avaliação de egresso da área da saúde: uma revisão. **Rev. bras. educ. med.** 46 (01)e039, 2022.

DINIZ NETO, A. P.; LIMA, C. F. T. de; CARVALHO, K. R. P.; SANTOS, R. M. P. dos; LIMA, R. S.; FERNANDES, R. A. M. L. O Mini-CEX na avaliação de habilidades clínicas na graduação médica. **Revista de Medicina**, [S. l.], v. 99, n. 1, p. 35-39, 2020.

DOMÍNGUEZ-TORRES, LC; VEGA-PEÑA, NV. Las pirámides de la educación médica: una síntesis sobre su conceptualización y utilidad. **Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología**. 74 (2)163-174, 2023.

ELSHAMA, SS. How to design and apply an objective structured clinical examination (OSCE) in medical education?. **Iberoamerican Journal of Medicine-3 (1)**, p. 51-55, 2021.

FERRAZ, MJ et al. Avaliação Criterial e avaliação normativa. In: Domingos Fernandes (Coord.), **Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem** (Folha A/4). Lisboa: IIE. Disponível no sítio da DGE, 1994.

EPSTEIN, R. M.; HUNDERT, E. M. Defining and assessing professional competence. **JAMA**, 9(2)287:226-235, 2002.

FAZENDA, I (org) **Didática e interdisciplinaridade**. 13 edição. Campinas, SP: Papirus, 1998.

FERNANDES, AMM et al., O Construtivismo na Educação. **Id on Line Rev. Mult. Psic.** V.12, N. 40. 2018

FERRAZ, M. J. et al. **A Avaliação Formativa: Algumas Notas**. I.I.E. (Ed.). Pensar Avaliação, Melhorar a Aprendizagem. Lisboa: I.I.E, 1994

FLEURY, MTL.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 5, n. spe, p. 183–196, 2001.

FREITAS, L.S; RIBEIRO, M.F; BARATA, J.L.M. O desenvolvimento de competências na formação médica: os desafios de se conciliar as Diretrizes Curriculares Nacionais num cenário educacional em transformação. **Revista médica de Minas Gerais**; 28: [1-8], jan.-dez. 2018.

FRENK J et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. **Lancet**. 4;376(9756):1923-58., 2010.

GALINDO MASSABNI, V.. O construtivismo na prática de professores de ciências: realidade ou utopia?. **Ciênc. cogn.**, Rio de Janeiro , v. 10, p. 104-114, mar. 2007.

GIESLER, M; LAMMERDING-KÖPPEL, M; GRIEWATZ, J. Development of a diagnostic instrument for the assessment of teaching competencies in medicine (FKM_L): First results of the test statistical verification. **GMS J Med Educ**. 15;39(5):Doc53, 2022.

HAGER, P; GONCZI A. **What is competence?**, Medical Teacher, 18:1, 15-18, 1996 DOI: [10.3109/01421599609040255](https://doi.org/10.3109/01421599609040255)

HARDEN RM et al., . Assessment of clinical competence using objective structured examination. **Br Med J**. 1975 Feb 22;1(5955):447-51.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago,1976.

JUG, R et al., Giving and Receiving Effective Feedback. A Review Article and How-To Guide. **Arch Pathol Lab Med**. 43:244–250; 2019.

KHAN, K; RAMACHANDRAN, S. Conceptual framework for performance assessment:Competency, competence and performance in the context of assessments in healthcare-deciphering the terminology. **Medical Teacher**, 34(11)920–928, 2012

LIMA, V et al..**Projeto Pedagógico do Curso de Medicina - 2020**.PPC: ISBN 978-65-992935-3-5.

LIMA VV. Competência: distintas abordagens e implicações na formação de profissionais de saúde. **Interface** (Botucatu) [Internet]. 2005; [cited 2018 Jan 16]; 9(17):369-79.

LIMA, V. V.; RIBEIRO, E. C. DE O.. Abordagem dialógica de competência: pressupostos e percurso metodológico para a construção de perfis na área da Saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 26, p. e210737, 2022.

MARTINSEN, SSS et al. Examining the educational impact of the mini-CEX: a randomized controlled study. **BMC medical education**, 21(1)-10, 2021.

MATTOS, R. Os sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de valores que devem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde**. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003.

NEVES, L. M. W.. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. **Revista Brasileira de Educação**, n. 22, p. 173–175, jan. 2003.

NOBRE, M. L. et al.. Diretrizes curriculares do curso médico: o “GPS” precisa ser reprogramado?. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 47, n. 2, p. e055, 2023.

NORCINI, J. et al. 2018 Consensus framework for good assessment. **Medical Teacher**, v. 40, n. 1. p. 1102-1109, 2018.

NORDI ABA et al. Experiências mundiais em preceptoria na graduação médica: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 46, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Cuidados de Saúde Primários, 2023, recurso eletrônico, disponível em <https://www.who.int/world-health-day/world-health-day-2019/fact-sheets/details/primary-health-care>, acessado em 17/12/2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Constituição**. Genebra: OMS, 1948.

PANUNCIO-PINTO, MP; TRONCON, LEA; Avaliação do estudante – aspectos gerais. **Medicina (Ribeirão Preto)** 47(3): 314-23, 2014;

PEREIRA JUNIOR, G. A.; SÁ, C. R. F. **A evolução do conceito de competências para marcos de competências e “Entrustable Professional Activities” (EPAs) in Simulação em saúde para ensino e avaliação**[livro eletrônico] : conceitos e práticas /Associação Brasileira de Educação Médica. -- São Carlos, SP : Cubo Multimídia, 2021.

PERRENOUD, P. Não mexam na minha avaliação! Para uma abordagem sistêmica da mudança pedagógica. In: ESTRELA, A; NÓVOA, A. **Avaliações em educação: novas perspectivas**. Porto – Portugal: Porto Editora, 1999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, **Sobre a Cidade**, SEM DATA, disponível em: <https://catalao.go.gov.br/sobre-a-cidade>, acesso em 22 de dezembro de 2023.

ROSSI, G. Z. et al.. Abordagens de aprendizado e sua correlação com ambiente educacional e características individuais em escola médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, n. 3, p. e169, 2021.

SALGADO, MI. BOLETIM UFMG - **Opinião: Saúde e espiritualidade**, 2006 disponível na internet em <https://www.ufmg.br/boletim/bol1551/segunda.shtml> consultado em 23 de dezembro de 2023.

SANTOS, WS. Organização curricular baseada em competência na educação médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 35, n. 1, p. 86–92, jan. 2011.

SAWYER T et al., Learn, See, Practice, Prove, Do, Maintain: An Evidence-Based Pedagogical Framework for Procedural Skill Training in Medicine. **Acad Med.**;90:1025–1033, 2015.

SCHMIDT, HG; DAUPHINEE, WD; PATEL, VL. Comparing the effects of problem-based and conventional curricula in an international sample. **J Med Educ**. Apr;62(4):305-15, 1987.

SCHUT, S et al. “Where the rubber meets the road - An integrative review of programmatic assessment in health care professions education. **Perspectives on medical education** v.. 10, n. , p. 6-13.2021

SCHWARTZ, Y.. Os ingredientes da competência: Um exercício necessário para uma questão insolúvel. **Educação & Sociedade**, v. 19, n. 65, p. 101–140, dez. 1998.

SCRIVEN, M. **The methodology of evaluation**. Social Science Education Consortium, 110, 1-58, 1966.

SCHEFFER, M. et al., **Demografia Médica no Brasil 2023**. São Paulo, SP: FMUSP, AMB, 2023. 344 p.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS, GERÊNCIA DE ESTATÍSTICA E ECONOMIA, Regiões de Planejamento do Estado de Goiás. Goiânia : SEPLAN. 2006, 166 p. ; il. Disponível em: <https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/regioes-planejamento/regplan2006.pdf>

SILVA, AL; GOMES AM. Avaliação educacional: concepções e embates teóricos. **Estud. Aval. Educ.**, São Paulo, v. 29, n. 71, p. 350-384, maio/ago. 2018.

SIQUEIRA-BATISTA, R; SIQUEIRA-BATISTA, R.Os anéis da serpente: a aprendizagem baseada em problemas e as sociedades de controle. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, p. 1183-1192, 2009.

SLOAN DA et al., The Objective Structured Clinical Examination. The new gold standard for evaluating postgraduate clinical performance. **Ann Surg**. 1995 Dec;222(6):735-42.

SRINIVASAN, M., "Teaching as a Competency": competencies for medical educators. **Acad Med**. 86(10):1211-20, 2011.

STOTZ, EN. **Necessidade de Saúde : mediações de um conceito** .Tese de doutorado. Escola Nacional de Saúde Pública, 1991.

TAROCO, A. P. R. M.; TSUJI, H.; HIGA, E. DE F. R.. Currículo Orientado por Competência para a Compreensão da Integralidade. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 1, p. 12–21, jan. 2017.

TRONCON, LEA. Avaliação do estudante de medicina. **Medicina, Ribeirão Preto**, 29() 429-439, out./dez. 1996.

TRONCON, L. E. DE A.. Estruturação de Sistemas para Avaliação Programática do Estudante de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, n. 1, p. 30–42, jan. 2016.

UFCAT, **História**, sem data, disponível em <https://catalao.ufg.br/p/6189-historia> acesso em 22 de dezembro de 2023.

VALADARES, J. A teoria da aprendizagem significativa como teoria construtivista. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 1, p. 36-57, 2011.

VAN DER VLEUTEN, C. P. M. et al. A model for programmatic assessment fit for purpose. **Medical teacher** v. 34, n.3 p. 205-14, 2012.

VENTURELLI J. **Educación médica: nuevos enfoques, metas métodos**. 2ª ed. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud; 2003.

ZAKI, HA. et al. The Utility of the Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) in the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating the Readability, Feasibility, and Acceptability of Mini-CEX Utilization. **Cureus**, v. 15, n. 8, 2023.